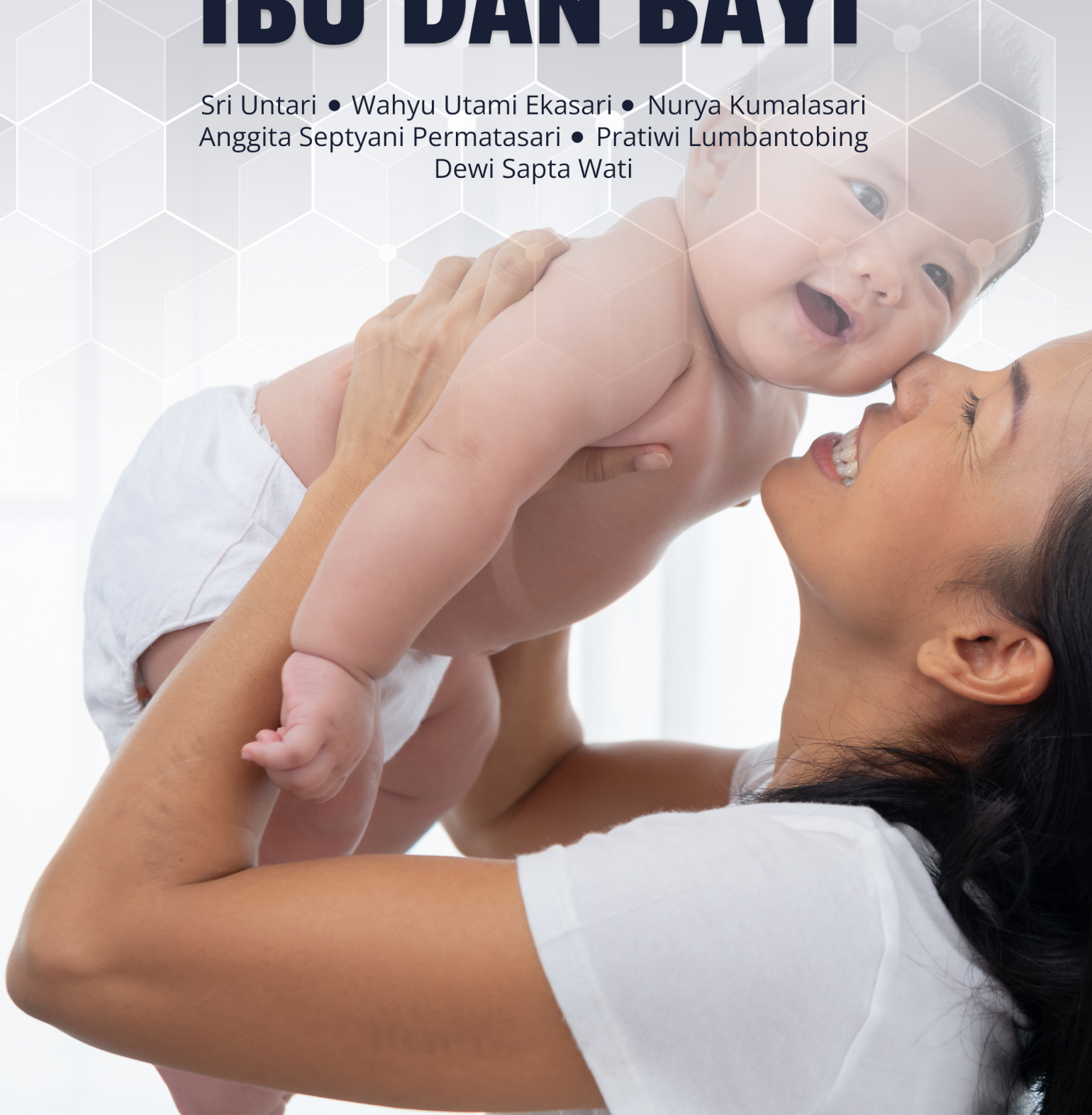


Buku Ajar

PEMERIKSAAN FISIK IBU DAN BAYI

Sri Untari • Wahyu Utami Ekasari • Nurya Kumalasari
Anggita Septyani Permatasari • Pratiwi Lumbantobing
Dewi Sapta Wati



BUKU AJAR PEMERIKSAAN FISIK IBU DAN BAYI

Penulis:

Sri Untari, S.SiT., M.Kes.

Wahyu Utami Ekasari, S.ST., MPH.

Nurya Kumalasari, S.ST., M.Kes.

Anggita Septyani Permatasari, S.Tr.Keb., M.Tr.Keb.

Pratiwi Lumbantobing, SST., M.KM.

Dewi Sapta Wati, S.Tr.Keb., M.Kes.



**Optimal
Untuk
Negeri**

BUKU AJAR PEMERIKSAAN FISIK IBU DAN BAYI

Penulis: Sri Untari, S.SiT., M.Kes.

Wahyu Utami Ekasari, S.ST., MPH.

Nurya Kumalasari, S.ST., M.Kes.

Anggita Septyani Permatasari, S.Tr.Keb., M.Tr.Keb.

Pratiwi Lumbantobing, SST., M.KM.

Dewi Sapta Wati, S.Tr.Keb., M.Kes.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Penata Letak: Muhammad Ilham

ISBN: 978-634-7426-25-3

Cetakan Pertama : Oktober, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Buku Ajar Pemeriksaan Fisik Ibu dan Bayi ini disusun untuk memperkuat kompetensi mahasiswa dan praktisi kebidanan dalam melakukan pengkajian komprehensif yang akurat, aman, dan beretika. Materi dirancang selaras dengan kebutuhan pembelajaran klinik dan laboratorium keterampilan, sehingga dapat digunakan dalam perkuliahan, praktik layanan, serta persiapan uji kompetensi dan Objective Structured Clinical Examination. Buku ini menekankan pendekatan berpusat pada keluarga, keselamatan pasien, dan komunikasi terapeutik sebagai fondasi pelayanan kebidanan yang bermutu.

Mengacu pada daftar isi, Bab 1 membahas konsep anamnesis, pengkajian riwayat kesehatan dan obstetri, serta keterampilan komunikasi. Bab 2 memandu pengkajian tanda vital ibu dan bayi, pengenalan peralatan dan perlengkapan, pemeriksaan tanda vital, faktor yang memengaruhi, peran bidan, hingga pengenalan alat ukur gula darah dan infus set. Bab 3 mengintegrasikan pemeriksaan umum pada ibu dan bayi, pemantauan tanda vital, pemeriksaan neurologi, serta pemeriksaan penunjang. Bab 4 mendalami pemeriksaan abdomen pada kehamilan dan persalinan yang mencakup prinsip dasar, teknik pemeriksaan fisik, pendekatan per sistem, serta penerapan pada ibu hamil, ibu bersalin, dan masa nifas. Bab 6 mengulas pemeriksaan dasar pada kehamilan, persalinan, dan nifas dengan topik optimalisasi posisi janin, pemeriksaan dalam dan penggunaan spekulum, serta perbaikan perineum. Bab 7 memfokuskan pemeriksaan bayi baru lahir, bayi, dan anak yang mencakup pemeriksaan fisik, tanda vital, dan antropometri.

Untuk memfasilitasi pembelajaran aktif dan penilaian diri, setiap bab dilengkapi latihan atau soal, rangkuman materi, glosarium, serta daftar pustaka. Kami menyampaikan terima kasih kepada para penulis, mitra institusi, serta semua pihak yang berkontribusi dalam penyusunan naskah ini. Umpan balik dari pembaca sangat kami harapkan guna peningkatan kualitas pada edisi berikutnya. Semoga buku ajar ini menjadi rujukan terpercaya dalam mewujudkan pelayanan kebidanan yang aman, efektif, dan berorientasi pada keselamatan serta kesejahteraan ibu dan bayi.

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 ANAMNESIS	1
A. Konsep Anamnesis.....	3
B. Pengkajian Riwayat Kesehatan Dan Obstetri	4
C. Keterampilan dalam Komunikasi.....	7
D. Latihan.....	17
E. Rangkuman Materi	18
F. Glosarium.....	19
G. Referensi.....	20
BAB 2 PENGKAJIAN TANDA VITAL IBU DAN BAYI.....	21
A. Pengenalan Peralatan Dan Perlengkapan Yang Diperlukan Dalam Praktik Kebidanan	23
B. Pemeriksaan pada Tanda-Tanda Vital (TTV)	25
C. Perlengkapan umum Pemeriksaan Tanda-Tanda Vital (TTV)/TTV KIT	27
D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tanda Vital	30
E. Peran Bidan dalam Pemeriksaan Tanda Vital.....	31
F. Alat Ukur Gula Darah (<i>Glucometer</i>).....	32
G. Infus Set (IV Infusion Set)	35
H. Latihan Soal.....	38
I. Referensi.....	41
BAB 3 PENGKAJIAN TANDA VITAL IBU DAN BAYI, PEMERIKSAAN UMUM DALAM PRAKTIK KEBIDANAN	43
A. Anamnesa Obstetri Dan Neonatal	44
B. Pemeriksaan Umum Pada Ibu dan Bayi	47
C. Pemeriksaan Tanda Vital Ibu dan Bayi	50
D. Pemeriksaan Neurologi Pada Ibu Dan Bayi	57
E. Pemeriksaan Penunjang Pada Ibu Dan Bayi.....	59
F. Latihan Soal.....	62
G. Glosarium.....	65

H. Daftar Pustaka	67
BAB 4 PEMERIKSAAN ABDOMEN PADA KEHAMILAN DAN PERSALINAN	73
A. Prinsip Dasar Pemeriksaan Fisik.....	75
B. Anamnesa	75
C. Teknik Pemeriksaan Fisik.....	76
D. Pemeriksaan Fisik per Sistem.....	78
E. Konsep Dasar Pemeriksaan Fisik	80
F. Pemeriksaan Fisik Pada Ibu Hamil	82
G. Pemeriksaan Fisik pada Ibu Bersalin	86
H. Pemeriksaan Saat Ibu Nifas	90
I. Latihan.....	91
J. Rangkuman Materi	92
K. Glosarium.....	92
L. Referensi.....	93
BAB 6 PEMERIKSAAN DASAR PADA KEHAMILAN, PERSALINAN DAN NIFAS	95
A. Optimalisasi Posisi Fetus	96
B. Pemeriksaan dalam dan penggunaan spekulum	105
C. Perbaikan Perinium.....	112
D. Latihan Soal.....	116
E. Glosarium.....	117
F. Daftar Pustaka	118
BAB 7 PEMERIKSAAN BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK	119
A. Pemeriksaan Fisik Bayi Baru Lahir (BBL)	121
B. Tanda-tanda Vital Pada Bayi	128
C. Pemeriksaan Fisik dan Antropometri pada Bayi dan Anak	132
D. Latihan.....	136
E. Rangkuman Materi	138
F. Glosarium.....	139
G. Referensi.....	141
PROFIL PENULIS	147

BAB 1

ANAMNESIS

Tujuan Intruksional:

- Menjelaskan Konsep Anamnesis
- Mempraktikkan Pengkajian Riwayat Kesehatan Dan Obstetrik;
- Mempraktikkan Keterampilan Dalam Komunikasi.

Capaian Pembelajaran:

CPL PRODI yang dibebankan pada MK	
CPL	Mahasiswa mampu untuk menerapkan anamnesis pada ibu;
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	
CPMK	Bila mahasiswa diberikan pengalaman belajar di kelas, mahasiswa mampu mengintergrasikan (C4) pengetahuan, sikap, dan keterampilan praktik dan aktifitas menerapkan gaya kepemimpinan dan manajemen tim yang efektif dalam anamnesis pada ibu;
Sub – CPMK	
Sub – CPMK 1	Memahami Konsep anamnesis
Sub – CPMK 1	Mempraktikkan Pengkajian Riwayat Kesehatan dan Obstetrik
Sub – CPMK 2	Mempraktikkan keterampilan dalam komunikasi

Pendahuluan:

Saat melakukan asuhan pada ibu dan bayi, tahapan awal yang harus dilakukan adalah anamnesis. Anamnesis atau wawancara medis, merupakan landasan utama dalam praktik kebidanan yang berkualitas. Anamnesis bukan sekadar proses mengumpulkan data, melainkan sebuah seni komunikasi yang bertujuan untuk membangun hubungan kepercayaan antara bidan dan klien. Melalui proses ini, bidan dapat memperoleh informasi yang mendalam dan holistik mengenai riwayat kesehatan dan obstetrik klien, yang menjadi kunci dalam menegakkan diagnosis, mengidentifikasi risiko, dan menyusun rencana asuhan yang tepat.

Bab ini akan mengupas tuntas pentingnya anamnesis sebagai langkah awal asuhan kebidanan. Mahasiswa akan mempelajari bagaimana melakukan pengkajian riwayat

kesehatan dan obstetrik yang efektif, serta mengasah keterampilan komunikasi terapeutik yang esensial dalam membangun kepercayaan dengan klien.

Tujuan Penulisan Buku

Buku ini disusun dengan beberapa tujuan utama:

1. **Sebagai Panduan Komprehensif:** Menyediakan panduan lengkap dan sistematis bagi mahasiswa kebidanan dalam melaksanakan pemeriksaan fisik pada ibu dan bayi secara profesional.
2. **Meningkatkan Kompetensi Klinis:** Membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan klinis, mulai dari anamnesis hingga pemeriksaan fisik yang terperinci, sehingga mampu mendeteksi masalah kesehatan sedini mungkin.
3. **Memperkuat Aspek Humanistik:** Menekankan pentingnya keterampilan komunikasi yang sensitif dan empatik untuk membangun hubungan terapeutik yang kuat dengan klien, sejalan dengan filosofi asuhan kebidanan yang berpusat pada pasien.
4. **Menyajikan Materi Terkini:** Mengintegrasikan perkembangan terbaru, isu, dan tantangan yang relevan dalam praktik pemeriksaan fisik ibu dan bayi, sehingga pengetahuan mahasiswa selalu relevan dengan kondisi lapangan.

Pendekatan Pembelajaran

Untuk memastikan pemahaman yang mendalam dan holistik, buku ini mengadopsi pendekatan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (***student-centered learning***). Melalui pendekatan ini, diharapkan mahasiswa kebidanan tidak hanya menguasai teknik pemeriksaan fisik, tetapi juga menjadi bidan yang peka, komunikatif, dan mampu memberikan asuhan kebidanan yang optimal bagi ibu dan bayi.

A. Konsep Anamnesis

1. Pengertian Anamnesis

Anamnesis merupakan proses pengumpulan informasi medis yang meliputi riwayat kesehatan hingga keluhan pasien. Setelah dilakukan anamnesis, pasien akan menjalani pemeriksaan fisik dan pemeriksaan laboratorium. (Desi Aryani, Samsul Mustofa, Ahmad Rusdan Handoyo Utomo, 2024)

Anamnesa merupakan proses pengumpulan informasi subjektif yang dilaksanakan oleh bidan untuk mendapatkan informasi terkait kesehatan ibu hamil serta janin yang dikandungnya. (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022)

Pada pasien dengan penurunan kesadaran pada pasien dengan parese facial sehingga kesulitan berbicara anamnesis dapat dilakukan dengan metode alloanamnesis pada orang terdekat pasien atau orang yang berada di tempat kejadian. Pasien dalam keadaan sadar dan mampu melakukan komunikasi dengan baik, bisa dilakukan auto anamnesis. (Tapuwa D. Musuka MBChB, Stephen B. Wilton MD, Mouhieddin Traboulsi MD, 2015)

2. Tujuan Anamnesis

Tujuan utama anamnesis adalah untuk mendapatkan data subjektif yang komprehensif tentang kondisi pasien. Informasi ini sangat penting dalam membuat keputusan klinis yang tepat.

Tujuan khusus anamnesis dalam kebidanan meliputi :

- a. Untuk menentukan diagnosis yang tepat berdasarkan keluhan, riwayat kesehatan, dan obstetri yang terperinci;
- b. Untuk mengidentifikasi faktor risiko yang dapat mempengaruhi kehamilan, persalinan, ataupun kesehatan bayi;
- c. Untuk merencanakan asuhan kebidanan yang efektif, tepat, dan disesuaikan kebutuhan pasien;
- d. Untuk menciptakan hubungan yang positif dan saling menghargai antara bidan dan klien, sehingga klien merasa aman dan nyaman serta bersedia mengungkapkan informasi;
- e. Untuk mengumpulkan data awal sehingga dapat digunakan untuk memantau perkembangan keadaan kesehatan ibu dan bayi secara berkala.

B. Pengkajian Riwayat Kesehatan Dan Obstetri

1. Pengkajian Identitas Pasien

Data umum pribadi yang dapat ditanyakan yaitu

a. Nama lengkap

Nama pasien beserta penanggungjawab (suami atau keluarga) digunakan untuk mempermudah bidan dalam melakukan komunikasi, serta dapat mempererat hubungan antara bidan dan pasien. Nama pasien harus sesuai dengan kartu pengenalan yang dimiliki oleh pasien (KTP, SIM, JKN atau tanda pengenalan yang lain).

b. Umur

Usia diartikan dengan lamanya/ durasi dari keberadaan seseorang yang diukur berdasarkan waktu dari perspektif kronologis, individu normal yang menunjukkan tingkat perkembangan anatomi dan fisiologi yang serupa (Dorland, 2020).

Komplikasi saat kehamilan dan persalinan pada perempuan yang berusia di bawah 20 tahun ternyata 2 hingga 5 kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan angka kematian maternal pada usia 20 hingga 29 tahun. Angka kematian maternal kembali meningkat setelah mencapai usia 30 hingga 35 tahun. (Sarwono Prawirohardjo, 2018)

c. Jenis kelamin

Informasi jenis kelamin dapat mempengaruhi penentuan diagnosis dan penatalaksanaan yang sesuai.

d. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu elemen yang penting dalam anamnesis.

Tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pasien (Notoatmodjo, 2014). Semakin tinggi tingkat pendidikan individu maka pengetahuan yang dimilikinya akan semakin baik, dan sebaliknya.

e. Alamat

Dalam anamnesis, alamat pasien sangat penting untuk ditanyakan. Informasi terkait dengan alamat dapat digunakan bidan untuk memberikan asuhan dan menghubungi pasien atau penanggungjawab. Selain itu, alamat digunakan bidan untuk menganalisis keadaan lingkungan. Lingkungan merupakan salah satu faktor eksternal dominan yang dapat mempengaruhi perilaku individu (Notoatmodjo, 2014)

f. Agama

Keyakinan atau agama yang dianut pasien seringkali digunakan sebagai upaya dalam memberikan dukungan emosional dan spiritual pasien. Pasien mampu meredakan kecemasan saat menghadapi kesulitan

atau penyakit yang dideritanya dan memahami persepsi tentang rasa sakit dan penderitaan sehingga perspektif ini akan membantu tenaga kesehatan dalam mengelola rasa sakit dan memberikan dukungan psikologis sesuai dengan keyakinan pasien.

g. Suku bangsa

Suku bangsa perlu untuk dikaji dalam pemberian asuhan kebidanan, karena suku bangsa erat kaitannya dengan sosial budaya yang dianut oleh pasien dan keluarga.

Seni, musik, tradisi, atau peninggalan masa lalu kadang – kadang dikaitkan dengan budaya di suatu tempat. Budaya membantu memahami bagaimana bidan berperilaku tertentu dan menjelaskan perbedaan sekelompok orang. (Bidan dan Dosen Kebidanan, 2017).

Suku bangsa menganut kepercayaan yang diturunkan secara turun temurun. Kepercayaan tersebut seringkali diperoleh dari orangtua, kakek, atau nenek. Seseorang menerima kepercayaan berdasarkan keyakinan dan tanpa bukti sebelumnya. Misalnya, telur tidak boleh dikonsumsi oleh wanita hamil untuk menghindari komplikasi saat melahirkan. (Notoatmodjo, 2014)

h. Pekerjaan

Status pekerjaan atau jenis pekerjaan seseorang dapat mempengaruhi keberhasilan asuhan. Status pekerjaan dapat dikaitkan dengan keadaan ekonomi pasien, sehingga bidan dalam pemberian asuhan dapat disesuaikan dengan keadaan ekonomi pasien.

(Futriani & Bela, 2025) menjelaskan bahwa salah satu faktor yang berpengaruh yaitu ibu hamil dengan status sosial ekonomi rendah, terbukti menyebabkan outcome obstetri yang buruk akibat kunjungan prenatal yang tidak maksimal.

i. Nomor telp/ HP

Nomor telp/ HP digunakan untuk mempermudah bidan dalam berkomunikasi dengan pasien. Selain nomor hp pasien, bidan juga memerlukan nomor hp suami/ penanggungjawab ataupun keluarga.

j. Keluhan Utama

Keluhan utama adalah alasan utama atau gejala yang membuat pasien datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam praktik kebidanan, keluhan utama merupakan informasi paling penting yang mengarahkan bidan dalam melakukan pengkajian lebih lanjut, menegakkan diagnosis, dan memberikan asuhan yang tepat.

2. Riwayat Kesehatan Saat Ini

Keluhan yang dapat ditanyakan kepada pasien meliputi jenis dan karakteristik gangguan yang dirasakan serta lama pasien mengalami keluhan tersebut (Sarwono Prawirohardjo, 2018).

3. Riwayat Obstetri

- a. Riwayat Menstruasi (Usia menarch, siklus menstruasi, durasi/ lama, keluhan, volume, bau, konsistensi, HPHT/ Hari Pertama Haid terakhir) (Jannah & Rahayu, 2023)

Riwayat menstruasi (siklus, lama, dan volume) yang dialami oleh remaja, dapat berhubungan dengan kejadian anemia. (Ningrum et al., 2025)

- b. Riwayat Kehamilan, Persalinan, Nifas terdahulu

Bidan menanyakan jumlah kehamilan, jumlah anak yang lahir hidup, jumlah kelahiran prematur, jumlah ibu mengalami keguguran, apakah persalinan dilakukan dengan tindakan (SC, forcep, atau vakum), riwayat perdarahan saat persalinan atau pascapersalinan, apakah kehamilan dengan tekanan darah tinggi, dan menanyakan berat bayi (< 2.500 gram atau > 4.000 gram)(Jannah & Rahayu, 2023).

- c. Riwayat Penggunaan Kontrasepsi

Kaji riwayat kontrasepsi riwayat kontrasepsi saat ini, terdahulu (kontrasepsi terakhir sebelum kehamilan jika sekarang ibu sedang hamil), serta rencana penggunaan kontrasepsi jika sekarang ibu sedang hamil atau postpartum. Perlu dikaji apakah terdapat efek samping selama pemakaian kontrasepsi dan alasan berhenti menggunakan kontrasepsi. (Bidan dan Dosen Kebidanan, 2017)

- d. Riwayat Kesehatan

- 1) Riwayat kesehatan ibu untuk mengetahui karakteristiknya, riwayat penyakit yang menular/ keturunan, dan riwayat pengobatan;
- 2) Riwayat kesehatan keluarga untuk mengetahui risiko penyakit menular atau keturunan dan kelainan genetik.

- e. Data Psikososial

- 1) Riwayat pernikahan (usia suami dan istri saat menikah, lama pernikahan, berapa kali menikah, dan status perkawinan)
- 2) Respon suami dan keluarga terhadap kehamilan ini.
Dukungan suami dan juga keluarga mencerminkan sikap atau tindakan yang dapat memberikan dorongan positif bagi individu, termasuk dalam memberikan pemahaman mengenai dampak dari kebiasaan tertentu, seperti bermain game. (Nurtanti, 2020)
- 3) Respon ibu terhadap kehamilan, persalinan, atau kehadiran bayi

- 4) Hubungan ibu dengan keluarga, pasangan, dan anggota keluarga yang lainnya.
- 5) Adat setempat yang dianut dan berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan nifas.
Sejumlah budaya memiliki kepercayaan, pantangan, dan perilaku terkait perempuan dan bayi baru lahir pada masa pasca kelahiran yang berlangsung hingga 40 hari. Menjaga ibu tetap bersama bayinya merupakan hal yang penting secara medis dan budaya dan selama periode 40 hari sering kali dipraktikkan sebagai periode "karantina" bagi perempuan, sebagai masa istirahat dan penyucian. (Seran et al., 2024)
- 6) Pola pemenuhan kebutuhan sehari – hari
 - a) Nutrisi
 - b) Eliminasi
 - c) Aktivitas dan Latihan
 - d) Istirahat – Tidur
 - e) Personal hygiene
 - f) Seksualitas
 - g) Persepsi dan Kognitif
 - h) Persepsi diri dan konsep diri
 - i) Keyakinan budaya
 - j) Kepercayaan dan ibadah
 - k) Kebiasaan yang merugikan.

C. Keterampilan dalam Komunikasi

1. Komunikasi

a. Pengertian Komunikasi

Komunikasi berasal dari kata latin "*communicare* atau *communis*" yang berarti sama atau menjadikan milik bersama. Jika suatu sistem atau sumber mempengaruhi yang lain dengan mengolah pemakaian isyarat – isyarat pilihan yang dapat diteruskan melalui saluran yang menghubungkan kedua belah pihak. Komunikasi merupakan suatu seni untuk menyampaikan informasi, ide – ide dan sikap – sikap dari seseorang kepada orang lain. (Endang Purwoastuti dan Elisabeth Siwi Walyani, 2015)

b. Unsur Komunikasi

Menurut (Bidan dan Dosen Kebidanan, 2017) Unsur – unsur terpenting dalam komunikasi yaitu :

1) Sumber.

Sumber merupakan pembuat atau pengirim informasi. Sumber dapat seorang individu, kelompok misalnya partai, organisasi, maupun suatu negara sebagai komunikator. Sumber sering disebut pengirim, komunikator atau *source*, *sender*, atau *encode*.

2) Pesan

Pesan merupakan symbol baik verbal ataupun nonverbal dari ide, gagasan, nilai, dan perasaan yang dikemas dalam bentuk pesan yang akan disampaikan oleh komunikator kepada komunikan.

3) Media

Media atau saluran untuk menyampaikan pesan merupakan alat yang digunakan untuk memindahkan pesan dari sumber kepada penerima yang sifatnya terbuka, yang setiap orang dapat melihat, membaca dan mendengarnya.

Media dibedakan menjadi media cetak (surat kabar, majalah, buku, *leaflet*, brosur, stiker, bulletin, *hand out*, poster, spanduk, dan sebagainya) dan media elektronik (radio, film, televisi, *video recording*, komputer, *electronic board*, dan *audio cassette*)

4) Penerima

Penerima adalah pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirim oleh sumber. Penerima pesan dapat individu, kelompok, organisasi, atau negara.

5) Efek

Efek merupakan dampak yang terjadi pada komunikan setelah menerima pesan dari komunikator. Efek dapat berupa perubahan dalam pengetahuan, sikap, ataupun perubahan perilaku.

6) Umpan balik

Umpan balik adalah salah satu bentuk pengaruh yang berasal dari penerima.

7) Lingkungan

Lingkungan atau situasi adalah faktor – faktor tertentu yang dapat mempengaruhi jalannya komunikasi. Faktor yang dapat mempengaruhi komunikasi yaitu lingkungan fisik, lingkungan sosial budaya, lingkungan psikologis, dan dimensi waktu.

a) Lingkungan fisik menunjukkan bahwa suatu proses komunikasi hanya dapat terjadi jika tidak terdapat rintangan fisik misalnya geografis. Seringkali komunikasi sulit dilakukan karena tidak tersedia fasilitas komunikasi seperti telepon, kantor pos, ataupun jalan raya.

- b) Lingkungan sosial menunjukkan faktor sosial budaya, ekonomi, dan politik yang dapat menjadi kendala terjadinya komunikasi misalnya bahasa, kepercayaan, adat istiadat, dan status sosial.
- c) Dimensi psikologis adalah pertimbangan kejiwaan yang digunakan dalam komunikasi. Misalnya menghindari komunikasi yang akan menyinggung pasien, menyajikan materi yang sesuai dengan usia dan lain – lain.
- d) Dimensi waktu menunjukkan situasi yang tepat untuk melakukan kegiatan komunikasi. Proses komunikasi disesuaikan dengan pertimbangan waktu pemberi informasi dan penerima informasi.

c. Komponen Komunikasi

Komponen komunikasi meliputi:

1) Pesan

Pesan adalah informasi yang dikirimkan oleh pengirim pesan dan diterima oleh penerima pesan. Pesan yang efektif adalah pesan yang jelas dan terorganisasi serta diekspresikan oleh pengirim pesan. (Endang Purwoastuti dan Elisabeth Siwi Walyani, 2015)

2) Pengirim Pesan/ *Sender*

pengirim pesan adalah seseorang yang mempunyai inisiatif untuk menyampaikan pesan kepada orang lain dimana pesan tersebut disampaikan secara verbal maupun nonverbal. Pengirim pesan menyampaikan stimulus berupa ide ke dalam bentuk yang dapat diterima oleh orang lain atau penerima pesan secara tepat. (Bidan dan Dosen Kebidanan, 2017)

3) Variabel pesan

Variabel pesan menurut (Endang Purwoastuti dan Elisabeth Siwi Walyani, 2015) meliputi komunikasi secara verbal, komunikasi nonverbal, suara atau bunyi, keterampilan komunikasi, penempatan, dan media.

a) Komunikasi verbal

Bahasa merupakan ekspresi ide atau perasaan. Kata – kata merupakan alat atau simbol yang dipakai untuk mengekspresikan ide atau perasaan, mengembangkan dan membangkitkan respons emosional, atau menguraikan objek, observasi, dan ingatan.

Pertukaran informasi terjadi secara interaktif, mendengarkan lawan bicara atau sebaliknya. Kontak mata sangat membantu kelancaran komunikasi. Pengamatan bahasa dan gaya bicara serta berlangsung dua arah atau timbal balik. (Sarwono Prawirohardjo, 2018)

b) Komunikasi nonverbal. Merupakan penyampaian pesan tanpa menggunakan kata – kata. Perilaku nonverbal yang umum adalah menangis, tertawa, berteriak atau menjerit, dan mengerang. Bentuk lain dari komunikasi ini meliputi ekspresi wajah, suara atau bunyi, isyarat, sikap tubuh, dan cara berjalan.

Komunikasi nonverbal melalui observasi dari gerak – gerak, ekspresi, gerak tubuh, dan isyarat. Terkadang sulit untuk menyelami maksud dan perasaan pasien dan sering terjadi salah persepsi. Maka dari itu petugas kesehatan harus lebih banyak mengambil inisiatif. (Sarwono Prawirohardjo, 2018)

c) Suara atau bunyi

Bunyi mengacu pada sistem komunikasi untuk menghindari penyampaian pesan yang tidak akurat.

d) Keterampilan komunikasi

Meliputi kemampuan pengirim dan penerima pesan untuk mengobservasi, mendengar, mengklarifikasi, dan memvalidasi arti pesan.

e) Penempatan

Penempatan mengacu pada tempat atau lokasi dimana komunikasi dilaksanakan.

f) Media

Media merupakan *channels sensory* yang membawa pesan. *Channels sensory* meliputi pendengaran, penglihatan, peraba, perasa, dan penciuman. Sebagai contoh, bidan melalui *channels sensory* melihat bahwa kulit bayi berwarna kekuningan.

g) Umpan balik

Merupakan proses lanjutan dari pesan yang diterima. Penerima pesan akan memberikan tanggapan atau pesan kembali kepada pengirim pesan. Umpan balik ini membantu memberikan kejelasan kepada pengirim pesan bahwa pesan yang dikirim dapat diterima dengan tepat oleh penerima pesan atau sebaliknya. Respons verbal atau nonverbal dari penerima pesan memberikan umpan balik kepada pengirim pesan.

4) Penerima pesan

Penerima pesan (*decoder*) yaitu seseorang yang menerima pesan. Pengiriman dan penerimaan pesan terjadi secara bersamaan dan merupakan aktivitas dari pengirim pesan dan penerima pesan.

d. Proses Komunikasi

Proses komunikasi merupakan cara komunikator (pengirim pesan) untuk menyampaikan pesan kepada komunikan (penerima pesan), sehingga dapat menghasilkan suatu persamaan makna antara komunikan dan komunikatornya. Berdasarkan teori dan praktiknya, proses komunikasi dibagi menjadi 2 yaitu:

1) Proses komunikasi primer

Proses komunikasi secara primer adalah proses penyampaian pikiran dan atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang (simbol) sebagai media. Lambang sebagai media primer dalam proses komunikasi adalah bahasa, isyarat, gambar, warna, dan sebagainya yang secara langsung mampu menerjemahkan pikiran dan atau perasaan komunikator terhadap komunikan. Proses ini berlangsung secara tatap muka sehingga umpan balik dapat diterima secara langsung oleh komunikan. (Bidan dan Dosen Kebidanan, 2017)

2) Proses komunikasi sekunder

Proses komunikasi sekunder adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau media. Media yang sering digunakan dalam komunikasi diantaranya adalah surat, telepon, surat kabar, majalah, radio, televisi, dan film. Proses ini tidak terjadi secara bertatap muka seperti komunikasi primer sehingga umpan balik atau feedback dalam komunikasi bermedia seperti ini menjadi tertunda. (Bidan dan Dosen Kebidanan, 2017)

2. Bentuk Komunikasi

a. Komunikasi Massa

Komunikasi massa adalah komunikasi yang menggunakan media massa baik cetak, baik cetak (surat kabar, majalah) atau elektronik (radio atau televisi) yang dikelola oleh suatu lembaga atau orang yang dilembagakan, ditujukan kepada sejumlah besar orang yang tersebar di banyak tempat, anonim, dan heterogen. Pesan yang disampaikan secara cepat bersifat umum, dan serentak serta selintas (khususnya media elektronik) (Bidan dan Dosen Kebidanan, 2017)

b. Komunikasi Interpersonal

Komunikasi interpersonal adalah pertukaran informasi, perasaan, atau pemikiran antar manusia secara tatap muka, individu dengan individu, verbal non – verbal. Oleh karena sifat dari interaksi adalah langsung dan segera, komunikasi interpersonal merupakan inti dari semua hubungan antar manusia. (Bidan dan Dosen Kebidanan, 2017)

Agar komunikasi interpersonal berhasil, maka perlu dimiliki keterampilan dalam komunikasi interpersonal baik sosial maupun *behavioral*. Kompetensi tersebut meliputi :

- 1) Empati (*emphati*), adalah kecakapan memahami perasaan dan pengertian orang lain;
 - 2) Perspektif sosial adalah kecakapan melihat kemungkinan yang diambil oleh orang yang kita ajak komunikasi;
 - 3) Kepekaan (*sensitivity*), terhadap sesuatu hal dalam komunikasi interpersonal;
 - 4) Pengetahuan akan situasi pada saat melakukan komunikasi interpersonal;
 - 5) Memonitor diri, adalah menjaga ketepatan perilaku dan pengungkapan komunikasi;
 - 6) Kecakapan dalam tingkah laku antara lain keterlibatan dalam berinteraksi.
- c. Komunikasi Kelompok

Komunikasi kelompok atau *group communication* adalah komunikasi yang berlangsung antara seorang komunikator dengan sekelompok orang jumlahnya lebih dari dua orang. Jika komunikasi dalam kelompok kecil maka disebut komunikasi kelompok kecil (*small group communication*), dan jika jumlahnya banyak maka disebut komunikasi kelompok besar (*large group communication*). (Endang Purwoastuti dan Elisabeth Siwi Walyani, 2015)

3. Komunikasi Terapeutik Dalam Kebidanan

a. Pengertian

Komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang direncanakan dan dilakukan bertujuan untuk membantu penyembuhan atau pemulihan pasien. Bidan harus memiliki keterampilan komunikasi yang bersifat profesional dan bertujuan untuk menyembuhkan pasien. Bidan yang memiliki keterampilan komunikasi terapeutik akan lebih mudah menjalin hubungan saling percaya dengan pasien, sehingga akan lebih efektif dalam mencapai tujuan asuhan kebidanan dan memberikan kepuasan profesional dalam pelayanannya. (Damaiyanti, 2010)

Komunikasi tidak bisa dipisahkan dari setiap individu yang hidup, komunikasi juga merupakan hal yang sangat penting bagi individu dalam melakukan interaksi. Kadangkala individu merasakan komunikasi menjadi tidak efektif karena kesalahan yang menafsirkan pesan yang diterimanya. Hal yang disebabkan karena setiap manusia mempunyai keterbatasan dalam menelaah komunikasi yang disampaikan. Kesalahan menafsirkan pesan bisa disebabkan

karena persepsi yang berbeda-beda. (Islami; et al., 2024)

b. Tujuan Komunikasi Terapeutik

Tujuan komunikasi terapeutik yaitu untuk mengurangi beban perasaan dan rasa takut yang ada pada pasien, mengurangi keraguan pasien, serta dapat mempengaruhi orang lain, lingkungan, dan dirinya sendiri. (Bidan dan Dosen Kebidanan, 2017)

Komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang direncanakan secara sadar, bertujuan dan kegiatannya dipusatkan untuk kesembuhan pasien. Pada dasarnya, komunikasi terapeutik merupakan komunikasi profesional yang mengarah pada tujuan yaitu penyembuhan pasien. Penyembuhan pasien dalam konteks ini adalah penyembuhan dengan sistem terapi, bukan dengan obat, sehingga yang menjadi kunci dalam pengobatan terapeutik adalah komunikasi bidan terhadap pasien. (Damaiyanti, 2010)

c. Ciri Komunikasi Terapeutik

Komunikasi terapeutik tidak seperti komunikasi lainnya. Komunikasi terapeutik apabila terjadi antara bidan dan pasien, mempunyai hubungan akrab dan mempunyai tujuan, berfokus pada pasien yang membutuhkan bantuan, bidan dengan aktif mendengarkan dan memberikan respons pada pasien.

Hal mendasar yang memberi ciri – ciri komunikasi terapeutik:

- 1) Keikhlasan (*genuiness*). Bidan harus menyadari tentang nilai, sikap, dan perasaan yang dimiliki terhadap keadaan klien. Bidan yang mampu menunjukkan rasa ikhlasnya mempunyai kesadaran mengenai sikap yang dipunyai terhadap klien sehingga mampu belajar untuk mengkomunikasikan secara tepat. Semua perasaan negatif yang dimiliki oleh pasien harus dapat diterima.
- 2) Empati (*empathy*). Empati merupakan perasaan “pemahaman” dan “penerimaan” bidan terhadap perasaan yang dialami oleh klien dan kemampuan merasakan dunia pribadi klien. Empati merupakan sesuatu yang jujur, sensitif, dan tidak dibuat – buat (objektif) didasarkan atas apa yang dialami orang lain. Empati cenderung bergantung pada kesamaan pengalaman di antara orang yang terlibat komunikasi.
- 3) Kehangatan (*warmth*). Dengan kehangatan, bidan akan mendorong klien untuk mengekspresikan ide – ide dan menuangkannya dalam bentuk perbuatan tanpa rasa takut dimaki atau dikonfrontasi. Suasana yang hangat, permisif dan tanpa adanya ancaman menunjukkan adanya rasa penerimaan bidan terhadap klien, sehingga klien akan mengekspresikan perasaannya secara lebih mendalam karena kehangatan dan sikap permisif yang diberikan.

d. Prinsip Komunikasi terapeutik

Prinsip yang ada dalam komunikasi terapeutik adalah kejujuran, tidak membingungkan, dan cukup ekspresif, bersikap positif empati bukan simpati, mampu melihat permasalahan pasien, menerima pasien apa adanya, dan sensitif terhadap perasaan pasien. Bidan memiliki prinsip *"helping relationship"* dalam menerapkan komunikasi terapeutik, diantaranya:

- 1) Pasien harus menjadi fokus utama;
- 2) Bidan harus mengenal dirinya sendiri yang berarti menghayati, memahami dirinya sendiri, serta nilai yang dianut;
- 3) Komunikasi harus ditandai dengan sikap saling menerima, saling percaya, dan saling menghargai;
- 4) Bidan harus memahami, menghayati nilai yang dianut oleh pasien;
- 5) Bidan harus menyadari pentingnya kebutuhan pasien baik fisik maupun mental;
- 6) Bidan harus menciptakan suasana yang memungkinkan pasien memiliki motivasi untuk mengubah dirinya baik sikap maupun tingkat lakunya sehingga tumbuh makin matang dan dapat memecahkan masalah yang dihadapi;
- 7) Bidan harus mampu menguasai perasaannya sendiri secara bertahap untuk mengetahui dan mengatasi perasaan gembira, sedih, marah, keberhasilan maupun frustrasi. Mampu menentukan batas waktu yang sesuai dan dapat mempertahankan konsistensinya.
- 8) Memahami arti empati sebagai tindakan yang terapeutik dan sebaliknya simpati bukan tindakan terapeutik;
- 9) Kejujuran dan komunikasi terbuka merupakan dasar dari hubungan terapeutik;
- 10) Mampu berperan sebagai role model agar dapat menunjukkan dan meyakinkan orang lain tentang kesehatan;
- 11) Bidan harus menciptakan suasana yang memungkinkan pasien bebas berkembang tanpa rasa takut;
- 12) Altruisme, mendapatkan kepuasan dengan menolong orang lain secara manusiawi;
- 13) Berpegang pada etika dengan cara berusaha sedapat mungkin keputusan berdasarkan prinsip kesejahteraan manusia;
- 14) Bertanggung jawab dalam 2 dimensi yaitu tanggungjawab terhadap dirinya sendiri atas tindakan yang dilakukan dan tanggungjawab terhadap orang lain.

e. Teknik – Teknik Komunikasi Terapeutik

1) Mendengar

Dengan mendengar, dapat mengetahui perasaan klien dan memberikan kesempatan lebih banyak pada klien untuk bicara. Tujuan teknik ini adalah memberi rasa aman klien dalam mengungkapkan perasaannya dan menjaga kestabilan emosi/ psikologi klien.

2) Pertanyaan terbuka

Teknik ini memberi kesempatan klien untuk mengungkapkan perasaannya sesuai kehendak klien tanpa membatasi, contoh : "Apa yang sedang anda pikirkan?", "Apa yang akan kita bicarakan hari ini?"

Agar klien merasa aman dalam mengungkapkan perasaannya, bidan dapat memberi dorongan dengan mendengar atau mengatakan "Saya mengerti apa yang saudara katakan."

3) Mengulang (*Restarting*)

Mengulang pokok pikiran yang diungkapkan klien. Gunanya untuk menguatkan ungkapan klien dan memberi indikasi bidan mengikuti pembicaraan klien. Misalnya : "Ohh..jadi saudara tadi malam tidak bisa tidur karena....."

4) Klarifikasi

Dilakukan bila bidan ragu, tidak jelas, tidak mendengar, atau klien berhenti karena malu mengemukakan informasi, informasi yang diperoleh tidak lengkap atau mengemukakannya berpindah – pindah. Contoh : "Dapatkah anda menjelaskan kembali tentang?". Gunanya untuk kejelasan dan kesamaan ide, perasaan, dan persepsi bidan.

5) Refleksi

Refleksi merupakan reaksi bidan – klien selama berlangsungnya komunikasi. Refleksi ini dapat dibedakan menjadi 2 yaitu :

- a) Refleksi isi bertujuan memvalidasi apa yang didengar. Klarifikasi ide yang diekspresikan klien dengan pengertian bidan;
- b) Refleksi perasaan bertujuan memberi respons pada perasaan klien terhadap isi pembicaraan agar klien mengetahui dan menerima perasaannya.

6) Memfokuskan

Membantu klien bicara pada topik yang telah dipilih dan yang penting serta menjaga pembicaraan tetap menuju tujuan yaitu lebih spesifik, jelas, dan berfokus pada realitas.

7) Membagi persepsi

Meminta pendapat klien tentang hal yang bidan rasakan dan pikirkan. Dengan cara ini bidan dapat meminta umpan balik dan memberi informasi.

Contoh : " Anda tertawa, tetapi saya rasa anda marah kepada saya."

8) Identifikasi tema

Mengidentifikasi latar belakang masalah yang dialami klien yang muncul selama percakapan. Gunanya untuk meningkatkan pengertian dan mengeksplorasi masalah yang penting.

Contoh : "Saya lihat dari semua keterangan yang anda jelaskan, anda telah disakiti. Apakah ini latar belakang masalahnya?"

9) Diam (*Silence*)

Cara yang sukar biasanya dilakukan setelah mengajukan pertanyaan. Tujuannya untuk memberi kesempatan berpikir dan memotivasi klien untuk bicara. Pada klien yang menarik diri, teknik, diam berarti bidan menerima klien.

Misalnya :

Klien : "Saya jengkel dengan suami saya."

Bidan : diam (memberi kesempatan klien untuk melanjutkan)

Klien : "Suami saya selalu telat pulang kerja tanpa alasan yang jelas, kalau saya tanya pasti marah."

10) Informing

Teknik ini bertujuan memberi informasi dan fakta untuk pendidikan kesehatan klien, misalnya bidan menjelaskan tentang penyebab demam yang dialami klien.

Klien : "Bu Bidan, kenapa suhu tubuh saya masih tinggi? Padahal saya sudah minum obat."

Bidan : " baik bu, akan saya jelaskan. Demam yang ibu alami dapat disebabkan karena"

11) Saran

Memberi alternatif ide untuk pemecahan masalah. Dapat dipakai pada fase kerja dan tidak tepat pada fase awal hubungan.

Misalnya : "Kita tadi sudah cukup banyak bicara tentang penyebab batuk dan sesak nafas, salah satunya karena merokok. Kami berharap anda dapat mengurangi atau berhenti merokok."

D. Latihan

Soal Pilihan Ganda

1. Apakah tujuan dilakukannya anamnesis dalam pengkajian pasien?
 - A. Untuk mendapatkan data subjektif yang komprehensif tentang kondisi pasien
 - B. Untuk mengetahui status pendidikan semua anggota keluarga
 - C. Untuk mengetahui status keuangan dan penghasilan keluarga
 - D. Untuk mengetahui keluhan yang dialami oleh keluarga pasien
 - E. Untuk menentukan gaya hidup pasien
2. Apakah informasi yang ditanyakan kepada pasien, kaitannya dengan identitas?
 - A. Nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, alamat, agama, suku bangsa, pekerjaan, nomor Hp, riwayat kesehatan sekarang dan keluarga
 - B. Nama, umur, pendidikan, jenis kelamin, status ekonomi, alamat, agama, suku bangsa, pekerjaan, nomor Hp, keluhan utama
 - C. Nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, alamat, agama, suku bangsa, pekerjaan, nomor Hp, keluhan utama
 - D. Nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, alamat, agama, suku bangsa, pekerjaan, status sosial ekonomi.
 - E. Nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, alamat, agama, suku bangsa, riwayat pernikahan, keluhan utama
3. Seorang perempuan berusia 29 tahun memeriksakan diri ke puskesmas. Perempuan tersebut mengeluhkan 3 bulan terakhir mengalami keputihan setiap harinya dengan warna kekuningan dan sangat gatal. Apakah anamnesis yang tepat dilakukan pada perempuan tersebut?
 - A. Anamnesis tentang riwayat penyakit/ keluhan
 - B. Anamnesis tentang status sosial ekonomi
 - C. Anamnesis tentang identitas pendidikan
 - D. Anamnesis tentang pola istirahat
 - E. Anamnesis tentang pola nutrisi
4. Dalam melakukan anamnesis, bidan harus mempunyai kecakapan memahami perasaan dan pengertian orang lain. Apakah kompetensi yang harus dicapai seorang bidan sesuai dengan pernyataan di atas?
 - A. Kecakapan dalam tingkah laku
 - B. Perspektif sosial
 - C. Memonitor diri
 - D. Kepekaan
 - E. Empati

5. Dalam melakukan komunikasi yang efektif, seorang bidan harus mampu untuk membantu klien bicara pada topik yang telah dipilih dan yang penting serta menjaga pembicaraan tetap menuju tujuan yaitu lebih spesifik, jelas, dan berfokus pada realitas. Apakah teknik yang sesuai dengan pernyataan di atas?
 - A. Pernyataan terbuka
 - B. Memfokuskan
 - C. Mendengar
 - D. Mengulang
 - E. Refleksi

Soal Essai

1. Jelaskan tujuan dari anamnesis yang dilakukan bidan pada pasien saat pengkajian!
2. Sebutkan apa saja yang ditanyakan kepada pasien saat melakukan anamnesis pola pemenuhan kebutuhan sehari – hari!
3. Apakah yang dimaksud dengan anamnesis riwayat kehamilan, persalinan, nifas yang lalu?
4. Sebutkan dan jelaskan unsur – unsur yang penting dalam komunikasi!
5. Jelaskan prinsip yang harus dipegang oleh bidan dalam melakukan komunikasi terapeutik pada pasien!

Kunci Jawaban

1. A
2. C
3. A
4. E
5. B

E. Rangkuman Materi

1. Konsep Anamnesis

Anamnesis merupakan proses pengumpulan informasi medis yang meliputi riwayat kesehatan hingga keluhan pasien. Setelah dilakukan anamnesis, pasien akan menjalani pemeriksaan fisik dan pemeriksaan laboratorium.

Tujuan utama anamnesis adalah untuk mendapatkan data subjektif yang komprehensif tentang kondisi pasien. Informasi ini sangat penting dalam membuat keputusan klinis yang tepat.

2. Pengkajian Riwayat Kesehatan dan Obstetri

- a. Pengkajian riwayat kesehatan meliputi pengkajian identitas pasien, riwayat kesehatan saat ini, riwayat kesehatan, dan data psikososial.
- b. Riwayat Obstetri meliputi riwayat menstruasi, riwayat kehamilan, persalinan dan nifas terdahulu, riwayat penggunaan kontrasepsi,

3. Keterampilan Dalam Komunikasi

Komunikasi merupakan suatu seni untuk menyampaikan informasi, ide – ide dan sikap – sikap dari seseorang kepada orang lain.

Komunikasi terapeutik dalam kebidanan merupakan komunikasi yang direncanakan dan dilakukan bertujuan untuk membantu penyembuhan atau pemulihan pasien. Bidan harus memiliki keterampilan komunikasi yang bersifat profesional dan bertujuan untuk menyembuhkan pasien.

F. Glosarium

Anamnesis: proses pengumpulan informasi medis yang meliputi riwayat kesehatan hingga keluhan pasien.

Channels sensory. meliputi pendengaran, penglihatan, peraba, perasa, dan penciuman.

Diagnosis: proses mengidentifikasi dan menentukan jenis penyakit, kondisi, atau cedera pada seseorang berdasarkan analisis tanda, gejala, dan hasil pemeriksaan medis.

Forcep: instrumen logam yang menyerupai penjepit dan melengkung agar pas di sekitar kepala bayi

Komplikasi: Masalah atau penyakit baru yang timbul sebagai akibat dari penyakit, prosedur medis, atau perawatan yang sudah ada sebelumnya.

Operasi Sesar: prosedur bedah mayor di mana bayi dilahirkan melalui sayatan yang dibuat di perut dan rahim ibu

Psikososial: istilah yang menggambarkan hubungan timbal balik antara kondisi psikologis (mental dan emosional) seseorang dengan lingkungan sosialnya

Riwayat Obstetrik: Pengkajian riwayat kehamilan, persalinan, dan komplikasi yang pernah dialami oleh wanita hamil, untuk mengetahui potensi risiko kesehatan pada ibu dan janin.

Vacum: metode persalinan pervaginam berbantu lainnya yang menggunakan alat ekstraktor vakum

G. Referensi

- Bidan dan Dosen Kebidanan. (2017). *Kebidanan : Teori dan Asuhan Volume 1* (Ida Yosefni (ed.)). EGC.
- Damaiyanti, M. (2010). *Komunikasi terapeutik dalam Praktik Keperawatan*. Refika Aditama.
- Desi Aryani, Samsul Mustofa, Ahmad Rusdan Handoyo Utomo, S. L. (2024). Pemeriksaan Laboratorium Sebagai Penegak Diagnosis Penyakit Malaria. *Binawan Student Journal (BSJ)*, 6 (3), 223–228. <https://doi.org/https://doi.org/10.54771/sbnfrv55>
- Dorland, W. N. (2020). *Kamus Saku Kedokteran Dorland* (30th ed.). Elsevier.
- Endang Purwoastuti dan Elisabeth Siwi Walyani. (2015). *Komunikasi & Konseling Kebidanan*. Pustaka Baru Press.
- Futriani, E. S., & Bela, I. (2025). Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi Terhadap Kunjungan Antenatal Care di PMB Iis Musliha Tangerang Tahun 2024. *Jurnal Ners*, 9 (2).
- Islami, I. M. R., Qomariyah, N., & Sholekah, A. I. (2024). Pengetahuan Bidan tentang Komunikasi Terapeutik Dalam Praktik Kebidanan. *Jurnal Bidan Mandira Cendikia*, 3 (1), 1–7.
- Jannah, N., & Rahayu, S. (2023). *Penuntun Belajar Laboratorium Kebidanan* (E. K. Yudha (ed.)). EGC.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Kurikulum Pelatihan Asuhan Ibu Hamil Standar Terpadu Bagi Bidan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama*.
- Ningrum, M. P., Distinarista, H., & Rahayu, T. (2025). Hubungan Riwayat Menstruasi Dengan Kejadian Anemia Pada Remaja Awal Di SMPN 1 Wonosalam. *Jurnal Cakra Medika*, 12 (1), 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.55313/ojs.v12i1.207>
- Notoatmodjo, S. (2014). *Promosi Kesehatan dan perilaku Kesehatan*. Rineka Cipta.
- Nurtanti, S. (2020). Gambaran Tingkat Kecemasan Orangtua Di RSUD. dr.Soediran mangun Sumarso Wonogiri. *Jurnal Keperawatan GSH*, 9 (2).
- Sarwono Prawirohardjo. (2018). *Ilmu Kebidanan*. PT Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
- Seran, A. A., Huru, M. M., Angraeningsih, N. L. D. P., & Tadam, N. A.-. (2024). Tradisi Empat Puluh Hari masa Nifas: Praktik Budaya Pasca melahirkan di Pulau Timor, Nusa Tenggara Timur. *OMJ (Optimal Midwife Journal)*, 1 (1), 46–58.
- Tapuwa D. Musuka MBChB, Stephen B. Wilton MD, Mouhieddin Traboulsi MD, M. D. H. M. (2015). Diagnosis and Management of Acute Ischemic Stroke: Speed is Critical. *Canadian Medical Association Journal (CMAJ)*, 187 (12), 887–893. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.1503/cmaj.140355>

BAB 2

PENGKAJIAN TANDA VITAL IBU DAN BAYI

Pendahuluan

Pada materi berikut ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai pemeriksaan tanda-tanda vital ibu dan bayi agar menguasai tentang pengkajian tanda vital ibu dan bayi (Prawirohardjo, 2016; Varney, Kriebs, & Gegor, 2014). Selain hal tersebut, pokok bahasan ini juga memberikan bekal ketrampilan praktik dalam melakukan pemeriksaan tanda vital pada ibu dan bayi yang meliputi pengenalan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam praktik kebidanan terdiri dari a) perlengkapan umum; b) TTV kit; c) alat ukur gula darah; dan d) infus set

Pengkajian tanda vital merupakan salah satu keterampilan dasar dalam praktik kebidanan, karena tanda vital menjadi indikator penting dalam menilai kondisi fisiologis ibu maupun bayi (Manuaba, 2010; World Health Organization [WHO], 2018). Tanda vital yang dimaksud meliputi suhu tubuh, denyut nadi, frekuensi pernapasan, dan tekanan darah, serta pada bayi ditambah dengan pemeriksaan tanda vital khusus sesuai tahap perkembangan (Astuti & Sari, 2021).

Pemeriksaan tanda vital yang dilakukan secara rutin dapat membantu deteksi dini adanya kelainan, komplikasi, atau penyulit baik pada ibu maupun bayi. Oleh sebab itu, pemahaman teori dan keterampilan praktik pemeriksaan tanda vital menjadi hal yang fundamental bagi mahasiswa kebidanan (Wiknjosastro, 2015).

Tujuan Instruksional :

- Menguraikan konsep pengkajian tanda vital ibu
- Menguraikan konsep pengkajian tanda vital bayi
- Menjelaskan prosedur pemeriksaan tanda vital pada ibu
- Menjelaskan prosedur pemeriksaan tanda vital pada bayi
- Mengenalkan perlengkapan umum yang digunakan pada pemeriksaan vital ibu dan bayi
- Mengenalkan KIT TTV pada ibu dan bayi
- Menjelaskan prosedur pemeriksaan gula darah pada ibu dan bayi
- Mengenalkan infus set yang digunakan pada ibu dan bayi

Capaian Pembelajaran:

Capaian pembelajaran dalam materi ini yang diharapkan adalah mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan pengetahuan, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan sikap profesional dalam memberikan asuhan kebidanan sebagai pemberi pelayanan kebidanan pada ketrampilan yang berkaitan dengan pengkajian tanda vital ibu dan bayi.

A. Pengenalan Peralatan Dan Perlengkapan Yang Diperlukan Dalam Praktik Kebidanan

1. Perlengkapan Umum

Alat Pemeriksaan Ibu

- a. **Tensimeter:** (Sphygmomanometer) : mengukur tekanan darah ibu.
- b. **Stetoskop:** mendengarkan detak jantung ibu, suara usus, dan frekuensi pernapasan.
- c. **Termometer:** Untuk mengukur suhu tubuh ibu.
- d. **Funduskop:** pemeriksaan kepala dan organ dalam.
- e. **Timbangan Badan:** mengukur berat badan ibu.
- f. **Pengukur Tinggi Badan/Metlin :** mengukur tinggi badan ibu.
- g. **Spekulum:** membantu memeriksa bagian dalam vagina dan leher Rahim pada ibu.
- h. **USG (Ultrasonografi):** Untuk melihat kondisi janin dan ibu secara lebih detail.
- i. **Pita Pengukur:** Digunakan untuk mengukur tinggi fundus uteri (tinggi puncak rahim).

2. Alat Pemeriksaan Bayi

- a. **Fetoskop/monoskop/leanec atau Doppler:** mendengarkan dan memantau detak jantung janin.
- b. **Timbangan Bayi :** menimbang berat badan bayi baru lahir.
- c. **Termometer Bayi :** mengukur suhu tubuh bayi.
- d. **Pengisap lender (*Penguin Suction*) :** menyedot lendir pada jalan napas bayi baru lahir.

3. Pemeriksaan Tanda-Tanda Vital

a. Pengertian TTV

TTV adalah singkatan dari **Tanda-Tanda Vital**, yaitu parameter secara fisiologis digunakan sebagai indikator utama untuk menilai kondisi secara umum pasien, selain itu pemeriksaan TTV ini dapat juga berfungsi mendeteksi apabila terjadi gangguan fungsi tubuh klien. Pemeriksaan TTV merupakan salah satu pemeriksaan yang digunakan oleh tenaga Kesehatan diantara pemeriksaan lainnya untuk membantu menegaskan diagnose (Manuaba, 2010; Prawirohardjo, 2016).

Menurut WHO (2018), tanda vital mencerminkan fungsi organ-organ vital seperti jantung, paru, pembuluh darah, serta mekanisme pengaturan

suhu tubuh. Dengan demikian, tanda vital menjadi dasar dalam menentukan ada tidaknya masalah kesehatan yang memerlukan penanganan segera (Varney, Kriebs, & Gegor, 2014).

b. Tujuan Pemeriksaan TTV

Secara Umum tujuan pemeriksaan tanda-tanda vital adalah sebagai berikut (Prawirohardjo, 2016; WHO, 2018):

- **Menjaga Kesejahteraan Ibu dan Bayi :**

Pengkajian tanda vital merupakan bagian dari upaya menjaga kesehatan dan kesejahteraan ibu serta bayinya. Apabila secara dini diketahui ada gangguan maka dapat segera dilakukan tindakan yang sesuai kebutuhan.

- **Mencegah Masalah Kesehatan :**

Dengan deteksi dini, masalah kesehatan pada ibu dan bayi dapat ditangani sebelum menjadi lebih parah, sehingga mencegah komplikasi dalam hal ini yang berhubungan dengan masalah Kesehatan.

- **Memastikan Proses Kehamilan dan Persalinan yang Aman :**

Pengkajian TTV ini juga mendukung upaya untuk mewujudkan proses kehamilan dan persalinan yang aman dan minim risiko bagi ibu dan bayi, sehingga dalam menjalani kehamilan dan persalinan TTV terpantau dalam batas normal.

c. Tujuan Pengkajian Tanda Vital Ibu

- **Deteksi Dini Komplikasi**

Mengenali tanda-tanda seperti tekanan darah tinggi atau rendah, ketidaknormalan suhu tubuh, atau perubahan denyut nadi yang bisa menjadikan komplikasi kebidanan, seperti perdarahan atau infeksi. Hal ini dapat menjadi bahan pemantauan dan memastikan bahwa kehamilan, persalinan dan adaptasi pasca salin berjalan dengan baik.

- **Menilai Hemodinamik dan Keadaan Umum**

Memeriksa sistem kardiovaskular dan kondisi umum ibu secara keseluruhan untuk memastikan tidak ada gangguan serius yang terjadi. Selain itu pemeriksaan TTV ini mampu mengidentifikasi apabila terjadi kelainan bawaan.

- **Mendeteksi Risiko Anemia**

Anemia merupakan kondisi tubuh kekurangan *haemoglobin* dalam peredaran darah pada tubuh. Merupakan salah satu hal penting setelah melahirkan, pemeriksaan darah bisa dilakukan untuk mengetahui kadar *haemoglobin* dan risiko anemia.

- **Menyusun Rencana Perawatan**

Hasil pengkajian TTV menjadi dasar untuk menyusun rencana perawatan yang sesuai, hal ini berguna menjaga kesehatan ibu apabila terjadi kelainan segera diberikan penanganan yang tepat.

d. Tujuan Pengkajian Tanda Vital Bayi

- **Menilai Transisi ke Kehidupan Ekstrauterin**

Bayi baru lahir mengalami perbedaan kehidupan dari dalam Rahim ke dunia luar. Dalam proses ini bayi dapat beradaptasi dengan baik setelah keluar dari rahim dan dapat bernapas serta memiliki sirkulasi darah yang sendiri dengan stabil. Hal ini dapat diketahui dengan pemeriksaan TTV pada bayi.

- **Mendeteksi Malformasi Kongenital**

Pemeriksaan intra uteri memungkinkan tidak terdeteksi secara detail, hal ini dapat dilakukan pemeriksaan TTV setelah lahir atau hidup ekstrauteri, sehingga dapat mengidentifikasi adanya kelainan bawaan pada bayi.

- **Mendeteksi Penyakit Aktual atau Potensial**

Keadaan bayi dengan kondisi tertentu dapat terdeteksi, baik kondisi medis yang sudah ada atau yang berpotensi muncul pada bayi baru lahir meskipun belum terdiagnosa.

- **Memantau Kesehatan Fisik Bayi**

Memantau tanda-tanda vital secara berkala bertujuan memastikan kondisi fisik bayi stabil dan berkembang dengan baik.

B. Pemeriksaan pada Tanda-Tanda Vital (TTV)

1. Suhu Tubuh (*Temperature*) adalah ukuran panas atau dinginnya tubuh sebagai hasil keseimbangan antara produksi panas (dari metabolisme) dan kehilangan panas (lingkungan) atau berpindahnya panas tubuh yang dipengaruhi oleh lingkungan

Suhu tubuh mencerminkan keseimbangan antara produksi panas dan kehilangan panas dari tubuh. Suhu normal orang dewasa berkisar antara 36,5°C–37,5°C, sedangkan pada bayi dapat sedikit lebih bervariasi (Wiknjosastro, 2015). Peningkatan atau penurunan suhu dapat menjadi indikator adanya infeksi atau gangguan metabolisme (Astuti & Sari, 2021).

Alat ukur yang sesuai digunakan dalam pemeriksaan suhu/*temperature* adalah termometer dengan berbagai sediaan/type/model yang beredar di pasaran (digital, raksa, infrared).

Tempat pengukuran yang tepat untuk mengetahui suhu yaitu berada di aksila (ketiak), oral (mulut), rektal (anus), timpani (telinga), dahi. Pemeriksaan ditempat

yang berbeda menggunakan thermometer yang sesuai, sehingga ada jenis thermometer oral, rektal dan aksila yang berbeda-beda (WHO, 2018).

Nilai normal yang direferensikan sebagai acuan adalah sebagai berikut:

Oral : 36,5° – 37,5°C

Rektal : 36,6° – 38°C

Aksila : 36° – 37°C

Kelainan yang dapat terjadi apabila keadaan berada tidak normal pada suhu tubuh diantaranya:

- **Hipotermia** (<35°C)
- **Hipertermia/demam** (>37,5°C)

2. Nadi (*Pulse*) merupakan denyutan arteri akibat kontraksi jantung yang dapat diraba di permukaan tubuh. Hal ini menunjukkan frekuensi jantung dalam memompa darah untuk memenuhi peredaran darah ke seluruh tubuh (Prawirohardjo, 2016; WHO, 2018).

Alat ukur yang dapat digunakan dalam pemeriksaan ini diantaranya jam/stopwatch yang disertai dengan tindakan perabaan memanfaatkan 2 jari terdiri dari jari telunjuk dan tengah, detak jantung ini dapat dirasakan pada arteri yang dekat dengan kulit.

Lokasi pengukuran yang paling tepat adalah dengan meraba disekitar arteri radialis (pergelangan tangan), karotis (leher), brakialis, femoralis, dorsalis pedis (Sulistyowati A, 2018).

Nilai normal dalam pemeriksaan nadi adalah:

- Dewasa: 60 – 100 x/menit
- Anak: 80 – 100 x/menit
- Bayi: 100 – 140 x/menit

Aspek yang dinilai dalam pemeriksaan denyut nadi diantaranya frekuensi, irama, kekuatan (kuat/lemah), kesamaan kanan–kiri.

Kelainan dalam pemeriksaan nadi apabila < normal disebut dengan bradikardi, sedangkan apabila > normal disebut dengan takikardi

3. Pernafasan (*Respiration*) adalah proses keluar-masuknya udara melalui paru-paru (Manuaba, 2010).

Cara pemeriksaan yang tepat yaitu dengan melakukan pengamatan gerakan dada/perut, kemudian menghitung frekuensi selama 1 menit.

Nilai normal pernafasan adalah :

- Dewasa: 16 – 24 x/menit
- Anak: 20 – 30 x/menit
- Bayi: 30 – 60 x/menit

Aspek yang dinilai kenormalan dalam pemeriksaan pernapasan meliputi frekuensi, irama, kedalaman (dangkal/dalam), kesulitan bernapas.

Kelainan yang dapat ditemukan dalam pemeriksaan pernapasan adalah :

- *Bradipnea* (napas lambat)
- *Takipnea* (napas cepat)
- *Dispnea* (sesak)

4. Tekanan Darah (Blood Pressure) artinya tekanan darah terhadap dinding arteri yang terjadi akibat dari usaha pemompaan dari jantung untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh (Astuti & Sari, 2021).

Alat ukur yang dapat digunakan dalam pemeriksaan tekanan darah ini yaitu *sphygmomanometer* atau lebih sering dikenal dengan nama tensimeter yang berupa model (manual/ digital) dan stetoskop.

Cara pemeriksaan:

- Pasien duduk/berbaring tenang.
- Manset dipasang 2–3 cm di atas lipat siku.
- Pompa hingga ± 20 mmHg di atas nadi hilang, lalu lepaskan perlahan.
- Bunyi pertama = sistolik, bunyi menghilang = diastolik.

Nilai normal (dewasa) :

- Sistolik: 100 – 120 mmHg
- Diastolik: 60 – 80 mmHg

Kelainan :

- Hipotensi (<90/60 mmHg)
- Hipertensi (>140/90 mmHg)

5. Tanda Vital Tambahan (opsional)

Saturasi Oksigen (SpO₂) : normal 95–100% (alat : pulse oximeter).

Nyeri : dinilai dengan skala nyeri (0–10).

Kesadaran : dinilai dengan GCS (Glasgow Coma Scale).

C. Perlengkapan umum Pemeriksaan Tanda-Tanda Vital (TTV)/TTV KIT

TTV KIT adalah satu set perlengkapan standar yang wajib dimiliki dan digunakan tenaga kesehatan (bidan, perawat, dokter) untuk melakukan pemeriksaan **Tanda-Tanda Vital (TTV)**, meliputi suhu tubuh, nadi, pernapasan, dan tekanan darah.

Perlengkapan TTV ini (TTV Kit) ini bersifat **portable**, artinya bisa dibawa secara mobile sehingga bisa dibawa ke ruang perawatan, klinik, maupun kunjungan rumah.

Tujuan TTV Kit

Dengan adanya TTV Kit mempunyai beberapa tujuan, yaitu sebagai berikut ini:

- Memudahkan pemeriksaan TTV secara cepat, tepat, dan aman.
- Menstandarkan alat pemeriksaan agar hasil terukur akurat.
- Mendukung praktik klinis, home care, dan tindakan gawat darurat.
- Menunjang pencatatan dan dokumentasi hasil pemeriksaan.

Prinsip Perawatan & Penyimpanan TTV Kit

Penggunaan TTV Kit memerlukan perawatan dan penyimpanan yang tepat, agar TTV Kit tetap terjaga fungsinya dengan baik. Selain itu menghindari terjadinya kontaminasi silang mikroorganisme antar klien dengan klien, antar klien dengan petugas serta sebaliknya. Berpegang pada prinsip bahwa semua orang dapat menularkan mikroorganisme menjadi salah satu dasar dalam perawatan dan penyimpanan TTV Kit. Hal yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- Semua alat **dibersihkan sebelum dan sesudah digunakan**.
- Alat disimpan dalam **kotak atau wadah khusus** agar tidak terkontaminasi oleh mikroorganisme dari lingkungan.
- Termometer & stetoskop harus dilakukan **disinfeksi dengan alkohol**.
- Tensimeter (*spygomanometer*) digital pastikan baterai terisi, sehingga alat selalu *ready* setiap saat akan digunakan.
- Setiap perlengkapan dicek secara berkala agar tetap **layak pakai & akurat termasuk melakukan kalibrasi**.

1. Pemeriksaan Suhu Tubuh (Temperature)

Perlengkapan yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Termometer

Thermometer dalam penggunaannya di beberapa Rumah sakit disediakan untuk masing-masing pasien dan digunakan sekaligus sebagai media promosi intsansi tersebut untuk kenang-kenangan dibawa pulang ke rumah. Thermometer yang beredar di masyarakat tersedia beberapa macam dengan memiliki nilai kelebihan dan kekurangan masing-masing, diantaranya adalah:

- **Digital** memiliki kelebihan dalam penggunaan lebih praktis, hasil pengukuran sudah muncul berupa angka sehingga kita tinggal membaca sesuai dengan yang muncul di monitor, selain itu dalam pengukuran menunjukkan hasil lebih cepat. Apabila hasil sudah muncul maka termometer akan mengeluarkan suara sebagai alarm.
- **Raksa (merkuri), termometer jenis ini merupakan termometer** klasik, memberikan nilai yang akurat, membutuhkan waktu lebih lama untuk mengetahui hasilnya, akan tetapi jenis ini sudah jarang digunakan karena

berisiko tinggi terjadi pecah apabila jatuh saat digunakan dan tentunya dapat membahayakan sekitar berbahaya.

- **Infrared/tembak (*forehead/ear thermometer*)**, penggunaan dari termometer ini adalah digunakan pada dahi atau telinga. Cara menggunakannya pun sangat mudah, cepat dan lebih *safety*.
- b. Tisu atau kapas alkohol (*alcohol swab*)**, fungsi dari bahan habis pakai ini adalah untuk membersihkan termometer sebelum dan sesudah pemakaian.
- c. Wadah khusus**, bisa menggunakan bak instrument yang berfungsi untuk menyimpan termometer agar tetap bersih.
- d. Jam/stopwatch**, alat ini digunakan pada saat pemeriksaan suhu menggunakan termometer manual (raksa) untuk menghitung waktu $\pm 3-5$ menit.

2. Pemeriksaan Nadi (Pulse)

Perlengkapan yang harus dipersiapkan adalah:

- a. Jam/stopwatch, berfungsi untuk menghitung denyut nadi selama 1 menit.
- b. Stetoskop (opsional)
- c. Alkohol swab digunakan untuk membersihkan area kulit bila perlu.

Pemeriksaan nadi yang sering dilakukan pada arteri radialis (pergelangan tangan), karotis (leher), brakialis (lengan), femoralis (lipat paha), dorsalis pedis (punggung kaki).

3. Pemeriksaan Pernafasan (Respiration)

Perlengkapan yang harus disediakan dalam pemeriksaan pernafasan adalah:

- a. Jam/stopwatch → menghitung frekuensi pernapasan per menit.
- b. Alat tulis/formulir → untuk mencatat hasil.

Pemeriksaan pernapasan pada umumnya tidak memerlukan alat khusus karena dapat dilakukan dengan inspeksi visual atau dengan cara melihat gerakan dada/perut).

Pada pasien dengan kondisi tertentu, dapat dibantu dengan alat yang disebut dengan *pulse oximetry* yang berfungsi untuk mengukur saturasi oksigen sekaligus frekuensi napas.

4. Pemeriksaan Tekanan Darah (Blood Pressure)

Perlengkapan dalam pemeriksaan tekanan darah perlu disiapkan:

a. *Sphygmomanometer* (tensimeter) dapat menggunakan salah satu jenis saja, diantaranya adalah:

- Manual (air raksa atau aneroid), penggunaan dengan tambahan stetoskop.
- Digital, dalam penggunaannya lebih praktis, hasil langsung terbaca tekanan diastole dan systolenya.

b. Stetoskop, berfungsi untuk mendengarkan bunyi Korotkoff (sistolik & diastolik).

c. Alkohol swab, digunakan untuk membersihkan *ear piece* stetoskop.

d. Alat tulis/formular, bertujuan untuk mencatat hasil pengukuran.

Hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan tensimeter yaitu manset tensimeter harus sesuai ukuran lengan pasien dengan standar berikut :

- Dewasa standar: lebar 12–14 cm.
- Anak: lebih kecil.
- Obesitas: lebih besar.

5. Perlengkapan Tambahan TTV

a. Pulse Oximeter bertujuan untuk mengukur saturasi oksigen (SpO₂) dan denyut nadi.

b. Glasgow Coma Scale (GCS) chart berfungsi untuk menilai tingkat kesadaran.

c. Pain Scale (Skala Nyeri) memiliki wujud seperti skala numerik (0–10) atau wajah (*Wong-Baker Faces*).

d. Hand sanitizer / sabun & air mengalir digunakan untuk kebersihan tangan sebelum & sesudah pemeriksaan.

e. APD (Alat Pelindung Diri) yang wajib digunakan minimal sarung tangan bila diperlukan.

D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tanda Vital

1. Faktor yang Mempengaruhi Suhu Tubuh

Suhu tubuh dipengaruhi oleh metabolisme, aktivitas fisik, lingkungan, usia, serta kondisi kesehatan. Pada ibu, perubahan hormonal juga dapat menyebabkan fluktuasi suhu, sedangkan pada bayi, mekanisme pengaturan suhu masih belum sempurna (Manuaba, 2010; WHO, 2018).

2. Faktor yang Mempengaruhi Nadi

Frekuensi nadi dipengaruhi oleh usia, aktivitas, emosi, suhu tubuh, dan status kesehatan. Bayi cenderung memiliki nadi lebih cepat dibandingkan orang dewasa karena metabolisme tubuhnya lebih tinggi (Prawirohardjo, 2016; Varney, Kriebs, & Gegor, 2014).

3. Faktor yang Mempengaruhi Pernapasan

Pernapasan dapat dipengaruhi oleh aktivitas fisik, emosi, suhu tubuh, nyeri, dan kondisi patologis seperti penyakit paru atau kelainan metabolisme. Pada bayi baru lahir, pola pernapasan sering tidak teratur karena sistem pernapasan masih beradaptasi (Wiknjosastro, 2015; WHO, 2018).

4. Faktor yang Mempengaruhi Tekanan Darah

Tekanan darah dipengaruhi oleh umur, jenis kelamin, posisi tubuh, aktivitas fisik, emosi, asupan makanan, serta kondisi kehamilan. Hipertensi pada ibu hamil merupakan faktor risiko yang dapat membahayakan ibu maupun janin (Prawirohardjo, 2016; Astuti & Sari, 2021).

Dengan demikian, faktor-faktor tersebut harus selalu dipertimbangkan dalam menilai hasil pemeriksaan tanda vital, sehingga interpretasi yang dilakukan lebih akurat (Manuaba, 2010).

Ringkasan dalam Tabel

Pemeriksaan	Alat Utama	Alat Tambahan
Suhu	Termometer (digital, raksa, infrared)	Tisu/alkohol, wadah, jam
Nadi	Jari tangan, jam/stopwatch	Tensimeter & stetoskop (opsional)
Pernapasan	Observasi, jam/stopwatch	Pulse oximeter
Tekanan darah	Sphygmomanometer (manual/digital), stetoskop	Alkohol swab, alat tulis
Tambahan	Pulse oximeter, GCS chart, skala nyeri	APD, hand sanitizer

E. Peran Bidan dalam Pemeriksaan Tanda Vital

1. Peran Bidan dalam Asuhan Kebidanan

Bidan memiliki peran penting dalam melakukan pemeriksaan tanda vital sebagai bagian dari asuhan kebidanan komprehensif. Pemeriksaan ini menjadi langkah awal dalam menilai kondisi ibu dan bayi, sekaligus dasar untuk menentukan intervensi lebih lanjut (Prawirohardjo, 2016; Varney, Kriebs, & Gegor, 2014).

2. Deteksi Dini dan Pencegahan Komplikasi

Melalui pemeriksaan tanda vital secara rutin, bidan dapat mendeteksi dini adanya komplikasi seperti hipertensi dalam kehamilan, perdarahan, infeksi, atau gangguan pernapasan pada bayi baru lahir (Manuaba, 2010; WHO, 2018). Tindakan cepat dan tepat dari bidan dapat menurunkan risiko morbiditas maupun mortalitas ibu dan bayi.

3. Edukasi kepada Ibu dan Keluarga

Selain melakukan pemeriksaan, bidan juga berperan memberikan edukasi kepada ibu dan keluarga mengenai pentingnya memantau tanda vital, misalnya mengenali gejala demam, napas cepat, atau tekanan darah tinggi. Edukasi ini bertujuan agar keluarga dapat segera mencari pertolongan medis bila ditemukan tanda bahaya (Wiknjosastro, 2015; Astuti & Sari, 2021).

4. Dokumentasi Hasil Pemeriksaan

Hasil pemeriksaan tanda vital harus dicatat secara sistematis dalam rekam medis. Dokumentasi yang baik akan membantu memantau perkembangan kondisi ibu dan bayi serta menjadi dasar pengambilan keputusan klinis (Varney et al., 2014; Prawirohardjo, 2016).

5. Kolaborasi dengan Tenaga Kesehatan Lain

Bidan juga harus mampu bekerja sama dengan tenaga kesehatan lain apabila ditemukan tanda vital yang abnormal, sehingga penanganan dapat dilakukan secara interdisipliner (WHO, 2018).

6. Kesimpulan

Pemeriksaan tanda vital merupakan bagian esensial dalam praktik kebidanan yang mencakup pengukuran suhu tubuh, nadi, pernapasan, dan tekanan darah, baik pada ibu maupun bayi. Pemeriksaan ini menjadi indikator penting dalam menilai kondisi fisiologis, mendeteksi dini adanya komplikasi, serta menentukan intervensi yang tepat (Manuaba, 2010; Prawirohardjo, 2016).

Tanda vital pada bayi memiliki karakteristik berbeda dengan orang dewasa, sehingga bidan perlu memahami perbedaan tersebut agar hasil interpretasi akurat (Varney, Kriebs, & Gegor, 2014; WHO, 2018). Pemantauan rutin tanda vital juga bermanfaat untuk mengevaluasi respon ibu dan bayi terhadap tindakan medis atau terapi (Wiknjosastro, 2015).

Dengan demikian, pemeriksaan tanda vital tidak hanya sebagai prosedur rutin, tetapi juga memiliki peran strategis dalam upaya menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu serta bayi (Astuti & Sari, 2021).

F. Alat Ukur Gula Darah (*Glucometer*)

1. Pengertian

Alat ukur gula darah (*Glucometer*) merupakan alat medis portabel yang digunakan untuk mengukur kadar glukosa dalam darah secara cepat dan praktis. Alat ini banyak digunakan oleh penderita diabetes melitus untuk memantau kadar gula darah harian sehingga dapat mengatur pola makan, aktivitas, dan penggunaan obat (American Diabetes Association, 2022). Alat ini penting untuk:

- a. Skrining dan diagnosis awal gangguan metabolisme (misalnya diabetes mellitus).
- b. Pemantauan kadar gula darah harian pada penderita diabetes.
- c. Evaluasi efektivitas terapi obat, insulin, dan pola hidup.

2. Jenis Alat Ukur Gula Darah

a. *Glucometer portabel* (paling sering digunakan)

- Ukuran kecil, praktis, bisa digunakan pasien di rumah.

- Menggunakan strip uji sekali pakai.

b. Glucometer laboratorium (*Bench-top analyzer*)

- Digunakan di laboratorium atau rumah sakit.
- Lebih akurat, mampu memeriksa sampel dalam jumlah banyak.

c. *Continuous Glucose Monitoring (CGM)*

- Alat canggih yang dipasang pada tubuh pasien (sensor di bawah kulit).
- Mengukur kadar gula darah setiap beberapa menit secara otomatis.
- Terhubung dengan aplikasi smartphone/alat monitor.

3. Komponen Glucometer Portabel

a. Alat utama (glukometer) adalah sebuah mesin pembaca hasil pemeriksaan gula darah.

b. Strip uji glukosa merupakan tempat meneteskan sampel darah, yang digunakan hanya sekali pakai.

c. *Lancing device* (penusuk jari) adalah alat yang berbentuk seperti bolpoint yaitu merupakan alat dengan ujung dipasang lancet yang berfungsi membantu dalam menusuk ujung jari untuk mengurangi rasa ketakutan atau trauma karena melihat jarum.

d. Lancet yaitu jarum kecil sekali pakai yang dipasang di *lancing device* bertujuan untuk mengambil sampel darah.

e. *Display*/layar digital adalah bagian dalam menampilkan hasil pemeriksaan dalam satuan mg/dL atau mmol/L.

f. Baterai bermanfaat sebagai sumber daya. Agar alat berfungsi dengan baik dalam menampilkan hasil pemeriksaan

g. Wadah/tas kit berfungsi untuk menyimpan semua perlengkapan agar tetap steril dan rapi serta praktis dalam membawa alat-alat yang dibutuhkan.

4. Cara Kerja

- Jarum lancet menusuk ujung jari bertujuan menghasilkan setetes darah kapiler.
- Darah diteteskan pada strip uji.
- Strip dimasukkan ke dalam glucometer.
- Sensor enzim dalam strip bereaksi dengan glukosa sehingga menghasilkan arus listrik.
- Glucometer menghitung kadar glukosa berdasarkan reaksi tersebut.
- Hasil ditampilkan di layar dalam hitungan detik.

5. Langkah Pemeriksaan Gula Darah dengan Glucometer

- Mencuci tangan pasien dan petugas dengan sabun/hand sanitizer.
- Menyiapkan alat dan bahan habis pakai yang dibutuhkan yaitu ***glucometer*, strip uji, *lancing device*, lanset dan kapas alkohol.**

- c. Memastikan alat berfungsi atau menyala yang dapat kita lihat di monitor, memasang memori card yang ada pada kaleng strip glukosa sehingga muncul kode yang sesuai
- d. Memasukkan strip ke dalam glucometer, sehingga muncul kode setetes darah
- e. Masukkan strip ke glucometer dengan demikian alat siap digunakan
- f. Bersihkan ujung jari pasien dengan kapas alkohol, biarkan kering
- g. Menusuk ujung jari dengan lancet device yang telah terpasang jarum lancet sampai menghasilkan setetes darah kapiler.
- h. Teteskan darah secukupnya pada strip uji.
- i. Glucometer menghitung kadar glukosa selama beberapa detik berdasarkan reaksi tersebut.
- j. Tunggu hasil pemeriksaan ditampilkan di layar dalam hitungan 5-15 detik.
- k. Catat hasil pada rekam medis/lembar pemantauan pasien.
- l. Bersihkan bekas tusukan dan tekan dengan kapas alcohol sampai darah berhenti, buang lancet/strip di wadah medis tajam

6. Nilai Normal Kadar Gula Darah

Nilai normal berdasarkan darah kapiler/glucometer, satuan mg/dL (Kementerian Kesehatan RI, 2019)

- **Puasa (8 jam tidak makan)** : 70 – 100 mg/dL
- **2 jam setelah makan (postprandial)** : < 140 mg/dL
- **Sewaktu (acak)** : < 140 mg/dL

Apabila dalam hasil pemeriksaan melebihi batas normal maka perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut (pemeriksaan laboratorium atau pemeriksaan lanjutan).

7. Kelebihan dan Kekurangan Glucometer Portabel

Kelebihan pada penggunaan alat glucometer portable (Suyono S, 2017) diantaranya:

- Praktis, cepat, bisa digunakan di rumah.
- Hasil dalam hitungan detik.
- Mendukung pasien diabetes untuk pemantauan mandiri.

Kekurangan alat *glucometer portable* yaitu:

- Akurasi lebih rendah dibandingkan alat laboratorium.
- Hanya bisa digunakan dengan strip khusus sesuai merek.
- Biaya penggunaan bisa tinggi karena strip bersifat sekali pakai.

8. Perawatan & Penyimpanan

Penggunaan alat glucometer yang tepat tidak lepas dari perawatan dan penyimpanan yang sesuai, diantaranya dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Simpan alat dan strip di tempat kering, suhu ruangan.
- Jangan gunakan strip yang sudah kadaluarsa.
- Bersihkan lancing device secara rutin.
- Ganti lancet setiap kali pemakaian.
- Kalibrasi glucometer secara berkala sesuai petunjuk pabrik.

9. Kesimpulan

Alat ukur gula darah (**glucometer**) adalah perangkat penting dalam pemantauan kesehatan, khususnya bagi penderita diabetes. Alat ini terdiri dari glucometer, strip, dan lancet, bekerja dengan menganalisis darah kapiler di ujung jari. Pemeriksaan sederhana ini membantu tenaga kesehatan maupun pasien memantau kadar glukosa secara cepat, sehingga keputusan terapi dapat dilakukan lebih tepat.

G. Infus Set (IV Infusion Set)

1. Pengertian

Infus set adalah seperangkat alat medis/Kesehatan sekali pakai yang digunakan untuk menyalurkan cairan, obat, atau nutrisi dari botol/ kantong infus ke dalam pembuluh darah pasien melalui akses intravena. Alat ini bekerja dengan prinsip **gravitasi** (atau menggunakan pompa infus) untuk mengatur tetesan cairan secara kontinu (Potter & Perry, 2017).

2. Fungsi Infus Set

- a. Menyalurkan cairan intravena (NaCl, Ringer Laktat, Dextrose, dll).
- b. Menghantarkan obat intravena yang dilarutkan.
- c. Memberikan transfusi darah (dengan infus set khusus).
- d. Memberikan nutrisi parenteral (Kozier et al., 2018)

3. Komponen Infus Set

Bagian dari infus set terdiri dari beberapa bagian utama (Setiawan A, 2020), yaitu:

a. Spuit tajam/Spike

- 1) Ujung runcing untuk menusuk botol/kantong cairan infus.
- 2) Dilengkapi **pelindung penutup** untuk menjaga sterilitas.

b. Chamber (Ruang Tetesan/Drip Chamber)

- 1) Tabung transparan tempat terlihatnya tetesan cairan
- 2) Berfungsi untuk menghitung tetesan per menit.

3) Ada 2 jenis :

- **Makrodrip** menghasilkan 10–20 tetes = 1 mL (untuk dewasa).
- **Mikrodrip** menghasilkan 60 tetes = 1 mL (untuk anak & pasien yang butuh akurasi tinggi).

c. Selang Fleksibel (Tubing)

- 1) Mengalirkan cairan dari chamber menuju vena pasien.
- 2) Terbuat dari plastik transparan, panjang ± 150 cm.

d. Roller Clamp / Screw Clamp

- 1) Alat penjepit di selang untuk mengatur kecepatan tetesan cairan.
- 2) Bisa mempercepat, memperlambat, atau menghentikan aliran cairan.

e. Injeksi Port / Rubber Injection Site

- 1) Tempat memasukkan obat tambahan langsung ke jalur infus menggunakan spuit.

f. Adaptor / Luer Lock Connector

- 1) Ujung penghubung selang infus dengan jarum intravena atau kateter.
- 2) Didesain agar kencang dan tidak mudah lepas.

4. Jenis-Jenis Infus Set

a. Infus set standar (makrodrip) dipergunakan untuk dewasa dan umum digunakan.

b. Infus set mikrodrip untuk bayi, anak, atau pasien dengan kebutuhan cairan akurat.

c. Infus set darah alat ini dilengkapi filter khusus untuk transfusi darah.

d. Infus set dengan filter memiliki fungsi khusus menyaring partikel/udara agar tidak masuk ke tubuh pasien.

e. Infus set dengan pompa (pump set) diperuntukkan khusus untuk digunakan pada infusion pump.

5. Cara Penggunaan Infus Set (Prinsip Umum)

- a. Cuci tangan dan gunakan **APD (sarung tangan, masker)**.
- b. Siapkan cairan infus sesuai instruksi medis.
- c. Buka infus set, pastikan dalam keadaan steril.
- d. Tusukkan spike pada botol/kantong infus.
- e. Isi drip chamber hingga setengah penuh.
- f. Buka roller clamp dan biarkan cairan mengalir hingga selang penuh (mengeluarkan udara/air purge).
- g. Hubungkan adaptor ke jarum infus/kateter vena pasien.
- h. Atur kecepatan tetesan dengan *roller clamp* sesuai instruksi dokter (tetesan per menit).

- i. Amati respon pasien dan pastikan jalur infus aman (Kementerian Kesehatan RI, 2020).

6. Mengganti Infus set

Mengganti selang infus adalah penggantian selang infus setelah pemasangan infus minimal 3 x 24 jam. Hal ini dilakukan mempunyai tujuan untuk persiapan akan dilakukannya transfuse darah.

Peralatan yang harus disiapkan antara lain:

- a. Botol infus sesuai dengan jenis cairan infus yang diberikan
- b. Infus set yang baru
- c. Perlak dan pengalas
- d. Bengkok
- e. Plester
- f. Handschoon

Berikut ini merupakan Langkah-langkah yang dilakukan dalam mengganti infus set:

- a. Siapkan infus set yang baru, termasuk botol / cairan infus
- b. Buka penutup botol, lakukan desinfeksi botol cairan, dan tusukkan set infus ke botol / kantong cairan dengan benar.
- c. Gantungkan botol cairan infus pada tiang infus, isi tabung drip infus $\frac{1}{3}$ - $\frac{1}{2}$ penuh.
- d. Buka penutup jarum dan buka klem untuk mengalirkan cairan sampai ke ujung jarum hingga tidak ada udara dalam selang, klem kembali, dan lepas jarum dari selang.
- e. Pasang perlak dan pengalas
- f. Pakai handschoon
- g. Lepas plester pada selang
- h. Pegang poros jarum dan tangan lain melepas selang
- i. Tusukan tube yang baru ke poros jarum
- j. Alirkan cairan infus
- k. Fiksasi selang dengan plester
- l. Atur tetesan cairan infus

7. Keamanan dan Perawatan

- a. Gunakan **alat steril sekali pakai**, jangan digunakan ulang.
- b. Periksa tanggal kedaluwarsa dan kondisi kemasan.
- c. Pastikan tidak ada **gelembung udara (air emboli)** di dalam selang.
- d. Gunakan filter bila memberikan transfusi darah.
- e. Buang infus set ke **tempat limbah medis** setelah digunakan (Hudak & Gallo, 2015).

H. Latihan Soal

1. Seorang pasien diabetes melitus tipe 2 melakukan pemeriksaan mandiri menggunakan glucometer di rumah. Hasil menunjukkan kadar glukosa darah 250 mg/dL setelah makan siang. Apa langkah yang paling tepat dilakukan pasien?
 - a. Menghentikan konsumsi air putih
 - b. Segera menghentikan obat diabetes
 - c. Melanjutkan pengobatan dan berkonsultasi ke dokter
 - d. Menggunakan strip uji yang sama untuk pemeriksaan ulang
 - e. Tidak melakukan apa-apa karena hasil normal
2. Seorang perawat mendampingi pasien menggunakan glucometer. Pasien memasukkan strip uji ke glucometer setelah meneteskan darah pada strip. Hasil tidak terbaca di layar. Apa kemungkinan penyebabnya?
 - a. Strip uji dimasukkan setelah darah diteteskan
 - b. Pasien menggunakan jari yang salah
 - c. Pasien mencuci tangan sebelum pemeriksaan
 - d. Layar glucometer terlalu kecil
 - e. Darah pasien terlalu sedikit
3. Pasien dengan riwayat diabetes merasa pusing dan lemas. Saat diperiksa menggunakan glucometer, kadar glukosa darahnya 58 mg/dL. Apa tindakan awal yang tepat diberikan?
 - a. Segera memberikan makanan/minuman manis
 - b. Meminta pasien tidur dan beristirahat
 - c. Menghentikan obat diabetes untuk selamanya
 - d. Melakukan pemeriksaan ulang tanpa Tindakan
 - e. Memberikan air putih saja
4. Seorang pasien rawat inap dengan dehidrasi sedang dipasang infus Ringer Laktat menggunakan infus set. Setelah 15 menit, perawat melihat cairan tidak menetes di drip chamber. Apa tindakan pertama yang paling tepat?
 - a. Melepaskan jarum infus lalu memasang Kembali
 - b. Memeriksa posisi selang dan roller clamp
 - c. Menambah volume cairan dalam drip chamber
 - d. Mengganti seluruh infus set baru
 - e. Menekan vena pasien agar cairan mengalir
5. Pasien anak usia 6 tahun mendapat terapi intravena. Setelah 2 jam, perawat melihat daerah sekitar pemasangan infus tampak kemerahan dan nyeri saat disentuh. Komplikasi apakah yang kemungkinan terjadi?
 - a. Emboli udara

- b. Flebitis
 - c. Infeksi sistemik
 - d. Hematoma
 - e. Syok anafilaktik
6. Seorang pasien dewasa datang ke puskesmas dengan keluhan demam. Setelah dilakukan pemeriksaan, suhu tubuhnya tercatat 39°C. Bagaimana interpretasi hasil pemeriksaan tersebut?
- a. Normal
 - b. Hipotermia
 - c. Hipertermia
 - d. Febris ringan
 - e. Subfebris
7. Seorang bidan memeriksa tekanan darah seorang pasien lansia dan mendapatkan hasil 160/100 mmHg. Bagaimana klasifikasi tekanan darah pasien tersebut?
- a. Normal
 - b. Prahipertensi
 - c. Hipotensi
 - d. Hipertensi
 - e. Normal tinggi
8. Saat pemeriksaan nadi pada pasien dewasa, didapatkan frekuensi nadi 52 kali/menit, teratur. Kondisi ini disebut...
- a. Takikardia
 - b. Bradikardia
 - c. Normal
 - d. Irregular pulse
 - e. Aritmia
9. Seorang anak usia 7 tahun diperiksa pernapasannya, frekuensi pernapasan tercatat 32 kali/menit. Bagaimana interpretasi hasil tersebut?
- a. Bradipnea
 - b. Takipnea
 - c. Apnea
 - d. Normal
 - e. Dispnea
10. Pasien dewasa sedang dalam kondisi syok hipovolemik. Hasil pemeriksaan TTV menunjukkan: tekanan darah 80/50 mmHg, nadi 120 kali/menit, pernapasan 28 kali/menit, suhu 36°C. Apa interpretasi yang tepat?
- a. Hipertensi emergensi

- b. Normal
 - c. Syok dengan tanda hipotensi, takipnea, dan takikardia
 - d. Demam ringan
 - e. Hipotermia
11. Seorang pasien datang dengan keluhan pusing. Hasil pemeriksaan TTV menunjukkan tekanan darah 90/60 mmHg. Kondisi ini dapat diartikan sebagai...
- a. Hipertensi
 - b. Hipotensi
 - c. Hipotermia
 - d. Bradikardia
 - e. Normal
12. Seorang pasien dewasa diperiksa TTV. Hasil menunjukkan: nadi 110 kali/menit, frekuensi pernapasan 30 kali/menit, suhu 37,2°C, tekanan darah 110/70 mmHg. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya...
- a. Bradikardia dan hipotensi
 - b. Takipnea dan takikardia
 - c. Normal
 - d. Hipertermia dan hipertensi
 - e. Hipotermia
13. Seorang bayi usia 1 tahun diperiksa frekuensi napasnya. Hasil tercatat 22 kali/menit. Bagaimana interpretasi hasil pemeriksaan tersebut?
- a. Bradipnea
 - b. Normal untuk bayi
 - c. Takipnea
 - d. Apnea
 - e. Hiperpnea
14. Saat melakukan pemeriksaan tekanan darah pada pasien ibu bersalin, bidan mendapatkan hasil 120/80 mmHg. Interpretasi yang tepat adalah...
- a. Hipotensi
 - b. Normal
 - c. Hipertensi
 - d. Prehipertensi
 - e. Hipertensi emergensi

Kunci Jawaban

1. C
2. A
3. A
4. B
5. B
6. C
7. D
8. B
9. B
10. C
11. B
12. B
13. A
14. B

I. Referensi

- American Diabetes Association. (2022). *Standards of medical care in diabetes—2022*. Diabetes Care, 45(Supplement_1)
- Astuti, R., & Sari, N. (2021). Hubungan tanda vital ibu dengan kejadian komplikasi persalinan. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 12 (2)
- Hudak, C. M., & Gallo, B. M. (2015). *Keperawatan kritis: Pendekatan holistik* (Terj. 7 ed.). Jakarta : EGC.
- Kementerian Kesehatan RI. (2019). *Pedoman teknis pengukuran kadar glukosa darah*. Jakarta : Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan RI. (2020). *Pedoman teknis penggunaan cairan intravena*. Jakarta : Kemenkes RI.
- Kozier, B., Erb, G., Berman, A., & Snyder, S. (2018). *Fundamentals of nursing: Concepts, process, and practice* (10th ed.). New York : Pearson.
- Manuaba, I. B. G. (2010). *Ilmu kebidanan, penyakit kandungan, dan keluarga berencana untuk pendidikan bidan*. Jakarta : EGC.
- Potter, P. A., & Perry, A. G. (2017). *Fundamentals of nursing* (9th ed.). St. Louis : Elsevier.
- Prawirohardjo, S. (2016). *Ilmu kebidanan*. Jakarta: PT Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
- Setiawan, A. (2020). *Alat kesehatan dasar untuk pemeriksaan mandiri*. Yogyakarta : Deepublish.

- Sulistiyowati A. 2018. Pemeriksaan Tanda-Tanda Vital. Akademi Keperawatan Kerta Cendekia Sidoarjo
- Suyono, S. (2017). *Diabetes melitus di Indonesia*. Jakarta : Balai Penerbit FKUI.
- Varney, H., Kriebs, J. M., & Gegor, C. L. (2014). *Varney's midwifery* (5th ed.). Burlington : Jones & Bartlett Learning.
- WHO (World Health Organization). (2018). *WHO recommendations: Intrapartum care for a positive childbirth experience*. Geneva : WHO Press.
- Wiknjosastro, H. (2015). *Ilmu Kebidanan*. Jakarta : Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
- Yusra, A., & Yulianti, R. (2021). Analisis penggunaan glucometer pada pasien diabetes melitus. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 16(2)

BAB 3

PENGKAJIAN TANDA VITAL IBU DAN BAYI, PEMERIKSAAN UMUM DALAM PRAKTIK KEBIDANAN

Pendahuluan

Anamnesa dan pengkajian tanda vital merupakan langkah awal dalam pemeriksaan fisik ibu dan bayi. Keduanya menjadi fondasi dalam proses asuhan kebidanan yang berkesinambungan dan berpusat pada pasien. Anamnesa memberikan informasi subjektif dari ibu atau keluarga, sedangkan pengkajian tanda vital memberikan data objektif yang mencerminkan kondisi fisiologis tubuh (Potter et al., 2023).

Pemahaman mendalam terhadap tanda vital penting bagi bidan untuk mendeteksi dini adanya gangguan homeostasis baik pada ibu maupun bayi, sehingga intervensi dapat dilakukan tepat waktu dan berbasis bukti (WHO, 2023).

Pemeriksaan umum merupakan komponen utama pelayanan kebidanan yang meliputi evaluasi fisik sistematis pada ibu dan bayi. Tujuannya adalah mendeteksi kelainan sedini mungkin dan merencanakan intervensi sesuai kebutuhan. Bukti ilmiah menunjukkan bahwa kualitas pemeriksaan umum berkaitan erat dengan hasil maternal dan neonatal yang lebih baik (Murzakanova et al., 2025; WHO, 2023).

Tujuan Instruksional Umum

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa mampu melakukan pengkajian anamnesa dan pemeriksaan fisik komprehensif pada ibu dan bayi baru lahir, menilai tanda vital sesuai fase (antenatal/intrapartum/postnatal), menerapkan pemeriksaan neurologis dasar, memutuskan pemeriksaan penunjang yang relevan, serta menyusun dokumentasi dan rencana tindak lanjut atau rujukan sesuai standar mutakhir.

Tujuan Instruksional Khusus

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa mampu:

1. Menjelaskan komponen anamnesa obstetri dan neonatal.
2. Melakukan pemeriksaan umum pada ibu dan bayi

3. Melakukan pemeriksaan tanda vital pada ibu dan bayi
4. Melakukan pemeriksaan neurologi pada ibu dan bayi
5. Melakukan pemeriksaan penunjang pada ibu dan bayi

A. Anamnesa Obstetri Dan Neonatal

1. Pengertian Anamnesa

Anamnesa merupakan proses pengumpulan informasi subjektif mengenai kondisi kesehatan pasien melalui wawancara terarah dan empatik (Lowdermilk et al., 2022). Dalam praktik kebidanan, anamnesa dilakukan untuk memahami keadaan umum ibu dan bayi, termasuk faktor risiko obstetri, riwayat penyakit, serta kondisi psikososial yang memengaruhi kesehatannya.

2. Prinsip Anamnesa Humanistik

Pendekatan humanistik menempatkan ibu sebagai individu yang unik dengan pengalaman dan nilai personal yang harus dihormati (Leifer, 2021). Bidan harus mampu membangun hubungan terapeutik berdasarkan kepercayaan dan empati. Pendekatan ini meningkatkan kualitas data yang diperoleh dan memperkuat kepercayaan antara ibu dan tenaga kesehatan (WHO, 2021).

3. Komponen Anamnesa Pada Ibu

Anamnesa bertujuan mengidentifikasi faktor risiko maternal, kehamilan, persalinan, dan lingkungan yang dapat mempengaruhi keselamatan dan hasil ibu–bayi; sebagai dasar skrining, prioritas tindakan, rujukan, dan pendidikan kesehatan. Anamnesa pada ibu meliputi:

a. Identitas & keluhan utama

Elemen: nama, umur, alamat, pekerjaan, alasan kunjungan (mis. perdarahan, gerakan janin berkurang, kontraksi).

Mengapa: menempatkan konteks immediat dan triage.

b. Riwayat obstetri (gravida–paritas dan detail kehamilan sebelumnya)

Elemen: Gravida, para (G P A L atau GTPAL), tanggal/usia kehamilan tiap kehamilan sebelumnya, hasil (bayi hidup/mati, usia gestasi, komplikasi—preeklampsia, perdarahan, infeksi, persalinan prematur, sectio caesarea), kelahiran, dan outcome neonatus.

Mengapa: riwayat obstetri sebelumnya (mis. kelahiran prematur, sectio caesarea) mempengaruhi risiko dan rencana persalinan sekarang.

c. Riwayat kehamilan saat ini (current pregnancy history)

Elemen: tanggal haid terakhir / Taksiran Persalinan (HPL/EDD), riwayat ANC (kapan pertama ANC, jumlah kunjungan, hasil skrining: Hb, golongan

darah/Rh, TORCH/serologi, diabetes gestasional, USG), keluhan kehamilan (perdarahan, nyeri, kebocoran cairan), pemeriksaan/prior intervensi (pemberian tetanus, profilaksis GBS jika ada kebijakan lokal).

Mengapa: menentukan usia kehamilan akurat, mendeteksi komplikasi yang memerlukan intervensi segera.

d. Riwayat penyakit umum / Medis / Bedah

Elemen: hipertensi kronik, diabetes, penyakit jantung, penyakit ginjal, gangguan tiroid, asma, penyakit autoimun, operasi uterus sebelumnya, transfusi darah, alergi obat.

Mengapa: kondisi sistemik mempengaruhi management kehamilan, pilihan obat, dan kebutuhan rujukan.

e. Riwayat obat, toksikologi, imunisasi, dan alergi

Elemen: obat rutin (mis. antihipertensi), obat terlarang, merokok, alkohol, paparan zat berbahaya di kerja, status imunisasi (TT/tetanus).

Mengapa: risiko teratogen, intervensi pencegahan, dan konseling gaya hidup.

f. Riwayat keluarga dan genetik

Elemen: riwayat penyakit turunan (hemofilia, talasemia, cacat kongenital, kelainan metabolik), riwayat abortus berulang, konsanguinitas.

Mengapa: menilai risiko genetik pada janin/ bayi sehingga diperlukan tes tambahan atau konseling genetik.

g. Riwayat sosial / psikososial

Elemen: dukungan keluarga, status ekonomi, akses layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan berisiko, KDRT, gangguan kesehatan mental (depresi, kecemasan).

Mengapa: faktor sosial berkaitan erat dengan kepatuhan ANC, nutrisi, dan outcome ibu–bayi; penting untuk rujukan sosial/psikologis.

h. Riwayat reproduksi tambahan

Elemen: kontrasepsi pra-kehamilan, perawatan kesuburan, riwayat infeksi menular seksual (HIV, Sifilis), riwayat PAP test/lesi serviks.

Mengapa: memengaruhi risiko infeksi perinatal, rencana persalinan dan pengobatan profilaksis

4. Komponen Anamnesa Pada Bayi

Pada bayi baru lahir, informasi diperoleh dari ibu atau pengasuh, meliputi:

a. Ringkasan kehamilan–persalinan (pregnancy–labor summary)

Elemen: usia gestasi saat lahir (waktu kehamilan), komplikasi kehamilan (intrauterine growth restriction, oligohydramnios, preeklampsia), infeksi

maternal (GBS, HIV, TORCH), obat-obatan yang diberikan selama kehamilan atau persalinan (antibiotik, tocolytics, obat anestesi).

Mengapa: faktor prenatal dapat memprediksi masalah seperti prematuritas, infeksi, dan gangguan metabolik pada bayi.

b. Riwayat persalinan dan proses lahir (labor & delivery)

Elemen: lama persalinan (fase I/II), jenis persalinan (spontan/vaginal/instrumental/sectio), adanya ketuban pecah dini (PROM), adanya mekonium, adanya kegawatan (distres janin), tindakan resusitasi (apgar 1/5/10 menit, intubasi, CPAP, kompresi), pemberian obat (vitamin K, antibiotik).

Mengapa: intervensi selama persalinan (mis. asfiksia, resusitasi) meningkatkan risiko komplikasi neurologis atau infeksi; data Apgar penting untuk penapisan awal.

c. Riwayat neonatal awal / transisi postnatal

Elemen: berat lahir, panjang, lingkar kepala, skor Apgar, kebutuhan oksigen/ventilasi, masalah gula darah, suhu, pemberian ASI pertama (IMD), tindakan perawatan kulit-ke-kulit, pemberian vaksin neonatal awal (HB0), pengamatan kuning (ikterus).

Mengapa: parameter antropometri dan transisi pernapasan/metabolik memandu perawatan awal dan kebutuhan observasi/rujuk.

d. Riwayat nutrisi & pemberian ASI

Elemen: apakah bayi disusui/ASI eksklusif atau diberi susu formula, frekuensi menyusu, kesulitan menyusu (latch problem), adanya kolostrum, dukungan laktasi.

Mengapa: nutrisi awal mempengaruhi suhu, gula darah, dan ikterus; IMD dan ASI eksklusif menurunkan morbiditas.

e. Riwayat skrining & pemeriksaan masa neonatus

Elemen: hasil skrining metabolik/penyakit bawaan (jika tersedia), pemeriksaan pendengaran baru lahir, skrining hiperbilirubinemia, pemeriksaan fisik lengkap (kelainan kongenital terdeteksi).

Mengapa: deteksi dini kondisi yang bisa diintervensi mengurangi morbiditas jangka panjang.

f. Riwayat kontak & paparan

Elemen: infeksi maternal (COVID-19, varicella, herpes), paparan asap rokok atau bahan beracun, orang yang tinggal serumah (TB, infeksi), status imunisasi keluarga (mis. difteri, pertusis).

Mengapa: menentukan risiko infeksi nosokomial/perinatal dan kebutuhan pencegahan.

5. Dokumentasi dan Etika Pengkajian

Semua hasil anamnesa dan pemeriksaan tanda vital harus dicatat dalam format SOAP atau rekam medis elektronik sesuai standar pelayanan kebidanan. Etika profesional menuntut kerahasiaan, persetujuan tindakan (informed consent), serta komunikasi empatik kepada ibu dan keluarga (ICM, 2022).

6. Interpretasi dan Tindak Lanjut

Hasil pengkajian menjadi dasar bagi bidan untuk menentukan masalah, diagnosis kebidanan, serta intervensi asuhan. Ketepatan interpretasi membantu mencegah komplikasi, terutama pada kasus preeklampsia, infeksi nifas, atau gangguan napas neonatal (Hussein et al., 2022).

Anamnesa dan pengkajian tanda vital merupakan tahap esensial dalam asuhan kebidanan yang menuntut keterampilan teknis dan empati interpersonal. Dengan penerapan berbasis bukti dan pendekatan humanistik, bidan mampu memberikan pelayanan yang aman, efektif, dan berorientasi pada kesejahteraan ibu dan bayi.

B. Pemeriksaan Umum Pada Ibu dan Bayi

Pemeriksaan umum perinatal mencakup penilaian kondisi ibu dan neonatus pada masa sebelum, saat, dan segera setelah persalinan; tujuan utamanya adalah mendeteksi risiko atau kelainan yang memerlukan intervensi segera, merencanakan tindak lanjut (observasi, perawatan, rujukan), dan memberikan konseling keluarga. Pada bayi baru lahir, pemeriksaan fisik menyaring adanya malformasi kongenital, gangguan transisi pernapasan/metabolik, dan kebutuhan nutrisi/perawatan segera.

Waktu optimal pemeriksaan bayi: Skrining pemeriksaan lengkap direkomendasikan dilakukan dalam rentang 6–72 jam setelah lahir (bila kondisi memungkinkan) dan diulang bila ada masalah atau sebelum pulang. Pemeriksaan awal segera (trim pertama menit–jam) fokus pada transisi (pernapasan, suhu, warna, tonus).

1. Prinsip Umum Pelaksanaan Pemeriksaan

- a. Persiapan lingkungan: hangat, cukup pencahayaan, privacy; cuci tangan; jelaskan tujuan kepada ibu.
- b. Prioritas kegawatdaruratan dulu: jika bayi tampak sesak, sianosis, apnea, hipotermia, atau perdarahan ibu, tangani segera (resusitasi/rujukan).

- c. Urutan pemeriksaan: mulai dari observasi umum tanpa disentuh → vital & antropometri → kepala/leher → dada & jantung → perut → genitalia/anus → ekstremitas → sistem saraf → pemeriksaan kulit & mata/mulut.
- d. Dokumentasi lengkap: berat lahir, panjang, lingkar kepala, Apgar, tindakan yang sudah dilakukan (vit K, HB0, IMD), hasil skrining.

2. Observasi Umum dan Triage Awal

Apa yang dicari & mengapa:

- a. Tampilan umum: warna kulit (pink vs sianotik), usaha bernapas (napas cepat, retraksi), tonus otot (fleksibilitas vs limpa), reaksi terhadap rangsangan, adanya malformasi jelas. Ini membantu menilai transisi neonatal dan kebutuhan resusitasi.
- b. Triage cepat: suhu, napas per menit, denyut jantung, respons. Jika pernapasan tidak efektif atau HR <100 bpm → manajemen pernapasan segera.

3. Pengukuran Vital & Antropometri

- a. Berat lahir (gram): catat berat lahir pertama (dengan skala terkalibrasi). Indikator status nutrisi in utero (LBW <2500 g).
- b. Panjang (cm) dan lingkar kepala (cm): deteksi gangguan pertumbuhan (IUGR/makrosomia).
- c. Suhu axilla: bayi harus hangat; hipotermia memperburuk gula darah & pernapasan.
- d. Denyut jantung & frekuensi napas: normal pada term: HR 100–160 bpm, RR 30–60 x/menit.
- e. Apgar: nilai pada menit ke-1 dan ke-5; penanda awal transisi dan kebutuhan intervensi. AAP+1

4. Pemeriksaan Kepala, Leher, dan Sistem Sensorik Kepala

- a. Palpasi kepala: bentuk, sutura, fontanel (kondisi tegangan; fontanel cekung/turun → dehidrasi; tegang → hipertensi intrakranial). Moulding atau cephalohematoma (pembengkakan subperiosteal) — catat lokasi, besar, dan kemungkinan hubungan dengan pemeriksaan instrumental.
- b. Mata
Pemeriksaan reaksi pupil, adanya discharge, kecurigaan katarak kongenital, pemeriksaan penapisan red reflex.
- c. Telinga & Hidung

Posisi dan bentuk telinga (indikator anomali kromosomal), patensi hidung (nose-breathing pada bayi), tanda ketidakmampuan menyusu karena nasal obstruction.

d. Mulut & orofaring

Evaluasi bibir sumbing, atresia choanal, palatum robusta, keberfungsian refleks hisap / gag reflex yang mempengaruhi menyusu.

5. Pemeriksaan Dada & Sistem Respirasi

a. Inspeksi: bentuk dada, simetri gerakan, retraksi, ekspansi.

b. Auskultasi: bunyi napas (ronki/stridor bisa menandakan masalah), murmur jantung awal (bisa fisiologis; tapi murmur persisten perlu evaluasi).

c. Palpasi: pergerakan dada dan adanya fremitus abnormal (rare pada neonatus).

d. Temuan penting: napas cepat (>60), retraksi, sianosis sentral → segera penanganan oksigenasi; adanya grunting → tanda distress pernapasan.

6. Pemeriksaan Jantung & Sirkulasi

a. Palpasi denyut janin eksternal (precordial activity), auskultasi murmur, frekuensi jantung.

b. Periksa perifer: perfusi (capillary refill), kulit dingin, warna.

c. Catatan: transisi sirkulasi normal pada term dapat memberikan bunyi murmur fungsional; murmur yang disertai sianosis, insufisiensi perfusi, atau kegagalan napas memerlukan pemeriksaan lebih lanjut (ekokardiografi).

7. Pemeriksaan Abdomen & Gastrointestinal

a. Inspeksi: bentuk, distensi, bekas operasi/lepuh, umbilikus (hernia umbilikalis), cairan, mekonium passing (ideal dalam 24 jam).

b. Palpasi: massa, hepatosplenomegali (infeksi/kelainan metabolik).

c. Auskultasi: bunyi usus.

d. Pemeriksaan anus: patensi anus.

e. Temuan peringatan: tidak melewati mekonium dalam 24–48 jam, muntah bilious, distensi berat → rujukan bedah neonatal.

8. Pemeriksaan Genitalia & Urinari

a. Kelamin: kelainan ambiguitas, testis (bagaimana turun), hypospadias, tanda-tanda infeksi.

b. Pendarahan dari vagina neonatus (normal akibat pengaruh hormon ibu) — catat tapi biasanya benign.

c. Catat jumlah urin (urinasi dalam 24 jam pertama penting).

9. Pemeriksaan Sistem Muskuloskeletal & Ekstremitas

a. Lengkung, simetri, gerak aktif. Periksa dislokasi kongenital panggul (Ortolani/Barlow test), klubfoot, cacat anggota tubuh.

- b. Periksa polidaktili/sindiktili.

10. Pemeriksaan Neurologis & Refleks Neonatal

- a. Tonus umum, gerak spontan, refleks primitif: rooting, sucking, moro, grasp, stepping — kehadiran/refleks asimetri harus dicatat.
- b. Evaluasi respons terhadap rangsangan, kejang, atau letargi.
- c. Catatan: gangguan tonus/tonus fluktuatif dan refleks abnormal memerlukan evaluasi neurology/neonatal (risiko asfiksia, infeksi, metabolik).

11. Pemeriksaan Kulit & Termoregulasi

- a. Inspeksi tanda lahir, ekkimosis/meconium staining, desquamation (pada postmature), miliaria, lanugo, vernix caseosa.
- b. Tanda jaundice awal: lokasi & waktu onset (perhatikan onset <24 jam — patut dicurigai patologi hemolitik).
- c. Evaluasi kemampuan menjaga suhu (hipotermia dapat memperburuk outcome).

12. Skrining & Pemeriksaan Tambahan yang Direkomendasikan

- a. Vaksin dan obat pencegah: HB0 (hepatitis B), vitamin K, profilaksis ocular (sesuai kebijakan lokal). Catat pemberian.
- b. Skrining pendengaran, skrining metabolik (nbs) jika tersedia, skrining hipoglikemia/hiperbilirubinemia berdasarkan risiko dan pedoman nasional. Pemeriksaan skrining awal untuk mata (red reflex) dan pemeriksaan ortopedi (DDH) pada beberapa negara juga direkomendasikan.

13. Dokumentasi, Konseling, dan Rencana Tindak Lanjut

- a. Dokumentasikan semua temuan, tindakan yang dilakukan, dan instruksi pulang (kapan kembali, tanda bahaya: demam, tidak menyusu, napas cepat, kuning meluas, tidak BAB/urin).
- b. Konseling ibu tentang IMD (Inisiasi Menyusu Dini), ASI eksklusif, menjaga suhu, dan imunisasi.
- c. Jika ditemukan masalah, rujuk sesuai tingkat keparahan (neonatal unit, bedah, kardiologi).

C. Pemeriksaan Tanda Vital Ibu dan Bayi

Tanda vital (tekanan darah, denyut jantung, frekuensi napas, suhu tubuh, perfusi/urine output, dan kadang saturasi oksigen) adalah indikator pertama kondisi fisiologis individu. Perubahan kecil dapat menandakan kegawatdaruratan obstetri — perdarahan pascapersalinan, preeklampsia/hipertensi, sepsis maternal, emboli, atau gagal jantung — sehingga pemeriksaan sistematis dan pengambilan tindakan cepat menyelamatkan nyawa. Pemantauan tanda vital juga menjadi dasar bagi

sistem deteksi dini seperti Modified Early Obstetric Warning Score (MEOWS) atau sistem peringatan maternal lainnya.

Pada periode transisi dari in utero ke extrauterine life (kelahiran), kemampuan bayi menyesuaikan diri secara cepat sangat tergantung pada status respirasi, kardiovaskular, dan termoregulasi. Gangguan pada tanda vital bisa menjadi petunjuk awal kegawatan (misalnya asfiksia, sepsis, hipoksia, hipotermia).

Dalam praktik klinik neonatal, pemeriksaan tanda vital dilakukan segera setelah lahir dan secara berkala selama periode observasi postpartum. Sebagai contoh, denyut jantung rendah (< 100 bpm) pada neonatal awal merupakan sinyal bahwa bayi mungkin memerlukan intervensi pernapasan (resusitasi).

1. Komponen Pemeriksaan Tanda Vital Ibu

a. Tekanan darah (Blood Pressure — BP)

Teknik: duduk atau berbaring setengah-diri; gunakan cuff ukuran yang sesuai (lengan atas). Jika di kanan lengan tidak memungkinkan, gunakan lengan kiri. Kalibrasi alat secara berkala.

Frekuensi: pada kunjungan antenatal minimal setiap kunjungan; pada intrapartum dan 24 jam postpartum lebih sering (setiap 15–30 menit saat kritis/kontraksi kuat atau sesuai protokol RS). WHO & ACOG menekankan pengukuran BP rutin pada setiap kontak layanan antenatal dan saat persalinan.

Interpretasi: pada kehamilan, hipertensi didefinisikan jika $\geq 140/90$ mmHg (tergantung guideline untuk gestasional vs kronik; ACOG Practice Bulletin 2020 memberi pedoman diagnosis preeklampsia/severe features). Nilai $\geq 160/110$ mmHg dianggap hipertensi berat yang memerlukan intervensi segera. Perhatikan pula kenaikan tekanan darah relatif (mis. kenaikan >30 mmHg sistolik atau >15 mmHg diastolik) walau masih $<140/90$ jika disertai gejala.

b. Denyut jantung (Heart Rate — HR / Pulse)

Teknik: palpasi arteri radialis atau auskultasi jantung; hitung selama 60 detik bila perlu.

Nilai normal & fisiologi kehamilan: selama kehamilan HR cenderung meningkat 10–20 bpm di atas baseline prekehamilan (karena volume darah dan kebutuhan metabolik meningkat). Jadi takikardia ringan bisa fisiologis; namun takikardia signifikan (>110 – 120 bpm) perlu dievaluasi untuk anemia, hipovolemia, sepsis, thyrotoxicosis, atau perdarahan.

c. Frekuensi napas (Respiratory Rate — RR)

Teknik: hitung gerakan dada/abdomen selama 60 detik (atau $30s \times 2$). Catat adanya kerja napas (retraksi, stridor), rasa sesak.

Interpretasi: RR >20–24 rpm pada ibu hamil dapat menandakan penyakit paru, emboli, sepsis, atau kompensasi metabolik; karena kehamilan memengaruhi kapasitas paru, penilaian gejala pernapasan penting. Pedoman pengelolaan sepsis maternal dan toolkit QI menekankan pemantauan RR sebagai parameter sensitif untuk diagnosis dini.

d. Suhu tubuh (Temperature)

Teknik: aksila atau oral sesuai standar fasilitas; rektal jarang digunakan pada ibu hamil. Interpretasi: demam (>38.0 °C) selama kehamilan atau di masa nifas adalah tanda merah—mencurigakan infeksi (chorioamnionitis intrapartum, sepsis puerperal). Namun, ingat demam ringan pascapersalinan dapat berhubungan dengan transfusi cairan atau stress. Jika demam disertai takikardia dan perubahan BP, segera evaluasi sepsis.

e. Saturasi oksigen (SpO₂)

Teknik: pulse oximeter—jari tangan; pastikan perfusi baik.

Interpretasi: target saturasi pada ibu hamil biasanya ≥95% (pada pasien dengan COVID-19/hipoksemik tujuan sering ≥94–95% tergantung protokol). Penurunan saturasi memerlukan pencarian penyebab: emboli paru, edema paru kardiogenik, pneumonia, atelectasis, atau hipoventilasi labor analgesia.

f. Nyeri & status kesadaran

Nyeri hebat, gangguan kesadaran, kebingungan, atau agitasi bisa menjadi tanda perdarahan masif, emboli, atau sepsis. Pemeriksaan mental status dimasukkan dalam protokol pemantauan maternal.

Tabel 3.1: Tanda Vital Ibu

Komponen	Metode Pengukuran	Nilai Normal	Interpretasi Klinis
Suhu tubuh	Oral/Aksila	36,5–37,5°C	Hipertermia dapat mengindikasikan infeksi postpartum.
Nadi	Palpasi arteri radialis	60–100 x/menit	Takikardi dapat menandakan anemia atau dehidrasi.
Tekanan darah	Sfigmomanometer	110/70–140/90 mmHg	Hipertensi >140/90 menandakan risiko preeklampsia.
Pernapasan	Observasi dada	16–24 x/menit	Pernapasan cepat menandakan infeksi atau kecemasan.
Saturasi O ₂	Pulse oximetry	≥95%	Penurunan saturasi menunjukkan gangguan respirasi.

2. Komponen Pemeriksaan Tanda Vital Bayi

a. Denyut Jantung & Respon Transisi

Denyut jantung bayi segera setelah lahir menunjukkan efektivitas transisi kardiorespirasi dari kehidupan intrauterin ke ekstrauterin. HR < 100 bpm pada menit awal adalah prediktor bahwa bayi mungkin mengalami depresi respirasi atau membutuhkan resusitasi. Sebagai penelitian terkini, penggunaan metode cepat seperti stethoscope digital atau ECG berbelt bisa meningkatkan kecepatan dan akurasi pengukuran HR pada newborn dibandingkan auskultasi klasik.

b. Frekuensi Napas & Distress Pernapasan

RR tinggi atau adanya retraksi, grunt, stridor menunjukkan distress pernapasan. Kondisi seperti sindrom aspirasi mekonium, pneumonia, atau gangguan transisi paru memerlukan evaluasi cepat. Sebuah studi menggunakan perekaman suara dada dengan stethoscope digital dalam 1 menit pertama lahir menunjukkan bahwa fitur suara dada dapat membantu prediksi neonatal respiratory distress (akurasi ~81,8 %).

c. Suhu & Termoregulasi

Bayi baru lahir mudah kehilangan panas melalui radiasi, konveksi, evaporasi. Oleh karena itu pengukuran suhu dan pengaturan lingkungan hangat sangat penting agar tidak terjadi hipotermia. Sebuah studi baru (2025) menunjukkan bahwa suhu rata-rata bayi meningkat dalam 2–3 jam pertama dan kembali meningkat kembali sekitar 15–20 jam setelah lahir, menunjukkan pentingnya pemantauan suhu awal.

d. Perfusi dan Refill Kapiler

Refill kapiler yang lambat menunjukkan perfusi perifer buruk dan bisa menunjukkan sirkulasi yang terganggu atau hipotensi. Kombinasi HR, perfusi, dan tekanan darah (jika tersedia) memberi gambaran keseluruhan dari output jantung dan tekanan sirkulasi bayi.

Tabel 3.2: tanda vital bayi

Komponen	Metode Pengukuran	Nilai Normal Neonatus	Interpretasi Klinis
Suhu tubuh	Aksila	36,5–37,4°C	Hipotermia menandakan kehilangan panas atau infeksi.
Nadi	Auskultasi apeks jantung	100–160 x/menit	<100 x/menit menunjukkan bradikardi.
Pernapasan	Observasi pergerakan dada	30–60 x/menit	Irama tidak teratur bisa fisiologis, tapi perlu pemantauan.
Tekanan darah	Manset neonatal	60–80/40–50 mmHg	Hipotensi dapat menunjukkan sepsis atau dehidrasi.
Saturasi O₂	Pulse oximetry	≥90%	<85% menunjukkan hipoksemia (WHO, 2023).

3. Waktu Pemantauan Tanda Vital Ibu

- Antenatal rawat jalan: BP dan suhu setiap kunjungan; denyut jantung/keluhan pernapasan dikaji. Perhatikan frekuensi kunjungan sesuai WHO/ACOG.
- Intrapartum (persalinan aktif): setidaknya setiap 30–60 menit jika persalinan normal dan tidak berisiko; lebih sering (15–30 menit) jika ada anestesi epidural, perdarahan, hipertensi, infeksi, atau komplikasi lain. WHO Labour Care Guide merekomendasikan pemantauan berkala terhadap tanda vital, urine output, dan keadaan ibu.
- Postpartum awal (24 jam pertama): pemantauan ketat — immediate postpartum tiap 15 menit selama satu jam pertama (tergantung protokol), lalu setiap 30–60 menit hingga stabil; lebih sering jika perdarahan atau komplikasi. Toolkits untuk maternal sepsis/perdarahan menekankan pemantauan ketat di 24 jam pertama.

4. Waktu Pemantauan Tanda Vital Bayi

- Segera setelah lahir: Denyut jantung, pernapasan, warna, tonus dievaluasi dalam hitungan detik–menit (ini adalah bagian dari penilaian Apgar).
- Menit ke-1 dan ke-5: Penilaian Apgar (yang sebagian menggunakan tanda vital seperti HR & respirasi) dilakukan.
- Dalam 24 jam pertama: Vital signs dicatat secara berkala — setiap 4 jam selama 24 jam pertama jika bayi stabil; jika ada gangguan, frekuensi lebih sering.
- Setelah 24 jam: Jika bayi tetap stabil, pemeriksaan vital dilakukan setiap 8 jam atau sesuai protokol RS.

- e. Jika ada kondisi klinis (misalnya asfiksia, prematur, penyakit konsisi), frekuensi bisa lebih tinggi atau secara kontinu menggunakan monitor

5. Faktor yang Mempengaruhi Tanda Vital Ibu (Maternal)

- a. Perubahan fisiologis kehamilan

Mekanisme & efek: Selama kehamilan terjadi peningkatan volume darah, cardiac output, dan penurunan resistensi perifer → nadi ibu cenderung meningkat 10–20 bpm; tekanan darah dapat turun pada trimester kedua lalu kembali naik di trimester ketiga. Pemahaman perubahan fisiologis penting untuk membedakan antara normal kehamilan dan patologi (mis. preeklampsia).

- b. Hipertensi gestasional / preeklampsia

Pengaruh: Naiknya tekanan darah ($\geq 140/90$ mmHg; $\geq 160/110$ mmHg = berat) jelas mengubah tanda vital; disertai gejala sistemik (takikardia kompensatorik, dispnea bila edema paru). Preeklampsia juga memerlukan pemantauan BP & tanda vital lebih ketat.

- c. Perdarahan (antepartum/intrapartum/postpartum)

Pengaruh: Hipovolemia menimbulkan takikardia, hipotensi, oliguria; pada perdarahan masif dapat terjadi syok. Kecepatan penurunan tekanan darah dan kompensasi jantung bergantung pada jumlah kehilangan darah dan kondisi awal ibu.

- d. Infeksi / sepsis maternal

Pengaruh: Demam, takikardia, takipnea, hipotensi (sepsis) — vital sign berubah cepat dan memerlukan bundle manajemen sepsis. Maternal sepsis juga dikaitkan dengan hasil neonatal buruk (preterm, LBW).

- e. Kondisi kardiovaskular / penyakit kronis

Pengaruh: Penyakit jantung, penyakit paru kronik, gagal jantung, atau aritmia dapat memodifikasi HR, RR, dan satO_2 ; pasien dengan penyakit dasar memerlukan monitoring ketat saat kehamilan/persalinan.

- f. Obesitas & usia ibu

Pengaruh: Obesitas dikaitkan risiko hipertensi, sleep apnea dan gangguan kardiometabolik → perubahan RR/HR/BP; usia lanjut (≥ 35) meningkatkan risiko komplikasi kardiovaskular dan mortalitas maternal. (Sumber: laporan kebijakan dan studi epidemiologi).

- g. Anemia / status hematologis

Pengaruh: Anemia berat → takikardia kompensatorik, mungkin intoleransi aktivitas; pengukuran Hb diperlukan saat interpretasi takikardia.

- h. Obat & anestesi (analgesia epidural, oksitosin, β -agonis, antihipertensi)

Pengaruh: Contoh: epidural/anestesi umum dapat menurunkan tekanan darah; oksitosin IV pada persalinan dapat mempengaruhi hemodinamik; β -agonis tocolytic dapat menaikkan HR/menurunkan BP. Catat obat yang sedang dipakai saat interpretasi vital.

- i. Keadaan lingkungan & infrastruktur (ruang kelahiran, suhu, akses oksigen)

Pengaruh: Kondisi lingkungan yang ekstrim (panas/dingin) atau fasilitas yang buruk dapat mempersulit manajemen pasien dan memengaruhi tanda vital (mis. dehidrasi, heat stress, hypothermia pada ibu dengan perdarahan).

- j. Faktor sosial & keterlambatan tawaran perawatan

Pengaruh tidak langsung: Keterlambatan mencari layanan, diskriminasi, atau kualitas layanan (mis. tidak diukur tanda vital secara teratur) memperburuk hasil—lihat literatur tentang pengaruh kualitas layanan pada mortalitas maternal.

6. Faktor yang Mempengaruhi Tanda Vital Bayi

- a. Usia gestasi (prematuritas vs term)

Pengaruh: Prematur memiliki kapasitas termoregulasi lebih buruk, paru-paru immatur → RR/HR dan saturasi lebih rentan, serta risiko apnea/patologi pernapasan. Prematur juga lebih rentan terhadap hipotermia yang memengaruhi HR dan glukosa.

- b. Suhu lingkungan & termoregulasi

Pengaruh: Ambient temperature yang tidak sesuai → hipotermia atau hipertermia pada neonatus; kedua kondisi ini mengubah RR, HR, dan metabolisme (hipotermia meningkatkan risiko hipoglikemia dan bradikardia). Studi ekologi menegaskan suhu ekstrem meningkatkan risiko mortalitas neonatal.

- c. Persalinan & transisi perinatal (asfiksia, mekonium, resusitasi)

Pengaruh: Asfiksia atau kebutuhan resusitasi awal memengaruhi HR (sering menurun), RR (tidak efektif), dan saturasi. Intervensi resusitasi sendiri (ventilasi, oksigen) mengubah profil tanda vital awal.

- d. Infeksi neonatal / sepsis

Pengaruh: Sepsis neonatorum sering menyebabkan perubahan suhu (baik demam maupun hipotermia), takikardia atau bradikardia, perubahan RR, dan penurunan perfusi. Hubungan maternal sepsis ↔ outcome neonatal juga dilaporkan.

- e. Hipoglikemia / metabolic instability

Pengaruh: Hipoglikemia pada neonatus dapat menunjukkan atau menyebabkan letargi, bradikardia, apnea — sehingga glukosa darah

memengaruhi tanda vital. Faktor risiko: prematur, ibu diabetes, gangguan nutrisi.

f. Mode persalinan & penanganan tali pusat (delayed cord clamping)

Pengaruh: Mode persalinan (sectio caesarea vs vaginal) dan waktu penjepitan tali pusat memengaruhi darah sirkulasi awal bayi (volume sirkulasi), yang dapat memodulasi HR dan tekanan darah neonatal.

g. Paparan maternal (obat, analgesia, narkotika)

Pengaruh: Obat yang diberikan pada ibu intrapartum (opioid, sedatif, anestesi umum) dapat menekan pernapasan neonatal dan menurunkan tonus/HR akhir lahir; ini memengaruhi penilaian Apgar dan kebutuhan monitoring.

h. Lingkungan perawatan & teknologi monitoring

Pengaruh: Ketersediaan pemantauan kontinu (pulse oximetry, ECG) dan teknologi baru (wearables, non-contact sensors) dapat meningkatkan deteksi dini perubahan vital; sebaliknya ketidaktersediaan monitoring meningkatkan risiko terlambat terdeteksi. Literatur membahas kemajuan teknologi monitoring neonatal.

i. Sosiodemografis & determinan kesehatan masyarakat

Pengaruh: Faktor seperti kemiskinan, paparan polusi/heat stress, akses layanan, dan status nutrisi ibu berkontribusi pada kondisi bayi saat lahir yang lalu tercermin pada tanda vital (mis. prematuritas, LBW). Laporan nasional dan studi ekologis menunjukkan efek iklim & lingkungan pada kesehatan neonatal.

D. Pemeriksaan Neurologi Pada Ibu Dan Bayi

Pemeriksaan neurologis pada ibu dan bayi bertujuan mendeteksi gangguan sistem saraf pusat dan perifer, menilai status neurologis awal, memantau perubahan (mis. setelah kejang atau trauma), dan menentukan kebutuhan intervensi/rujukan. Untuk ibu: mendeteksi kondisi akut (stroke, eklampsia, sepsis with encephalopathy, kompresi saraf, eksaserbasi penyakit neurologis kronik). Untuk bayi: menilai tingkat kematangan neurologis, mendeteksi ensefalopati hipoksik-iskemik, cedera intraventrikular, kelainan bawaan, atau gangguan perkembangan dini.

1. Pemeriksaan Neurologis Pada Ibu

a. Prinsip & konteks

Lakukan anamnesa fokus: onset gejala (kepala — sakit kepala berat, aura, muntah), kelemahan fokus / hemiparese, kelumpuhan wajah, gangguan penglihatan, kehilangan kesadaran/kejang, nyeri/paresthesia (saraf perifer),

riwayat penyakit neurologis (epilepsi, MS), obat yang dipakai (anti-kejang, antikoagulan), dan faktor risiko vaskular (hipertensi, diabetes). Ingat perubahan fisiologis kehamilan (volume darah, koagulabilitas) yang mempengaruhi presentasi dan manajemen neurologis.

b. Komponen pemeriksaan fisik (urutan praktis)

Status umum & tanda vital — tekanan darah (kunci untuk preeklampsia/eclampsia), kesadaran (GCS jika perlu), saturasi, gula darah. Pemeriksaan mental status — orientasi waktu/tempat/orang, memori singkat, perhatian, bahasa (afasia). Cranial nerves (I–XII) — penglihatan (acuity/field), pupil (simetri, reaktif), gerakan ekstraokular, fasialis, refleks kornea/gag, pendengaran.

Motorik — tonus, kekuatan (skor 0–5), distribusi kelemahan (fokal vs global), pemeriksaan berjalan (gait) jika memungkinkan. Sensorik — nyeri, sentuhan, propiosepsi; pola dermatomal vs perifer. Refleks dalam & patologis — tendon reflex, Babinski, clonus. Koordinasi & cerebellar — finger-nose, heel-shin, romberg. Leher & tanda meningisme — kaku kuduk, fotofobia. Catat temuan baseline untuk monitoring selanjutnya.

c. Pemeriksaan neurologis yang spesifik untuk kehamilan / nifas

Tanda preeklampsia/eklampsia: sakit kepala hebat, gangguan visual (scotomata, diplopia), hiperrefleksia, edema jaringan, dan perubahan kesadaran → jika ada, lakukan pemeriksaan BP berulang, pemeriksaan urine protein, evaluasi laboratorium segera dan pertimbangkan magnesium sulfat bila ada kejang/risiko eklampsia.

Stroke & tromboemboli: onset mendadak kelemahan unilateral, disfagia, gangguan penglihatan atau bicara — tindakan emergensi (stroke code), CT head tanpa kontras / MRI jika perlu, kerja sama neurosurgery/kardiologi. Kehamilan meningkatkan risiko trombosis tertentu — manajemen memerlukan tim multidisiplin.

Keadaan kejang / epilepsi: tanyakan riwayat epilepsi, obat antikonvulsan (keamanan kehamilan), frekuensi kejang, dan manajemen akut apabila terjadi kejang peripartum. Kejang pada ibu (eclampsia vs epilepsi primer) perlu dibedakan; manajemen termasuk stabilisasi ABC, pengobatan anti-kejang yang aman, dan pertimbangan untuk persalinan cepat bila indikasi obstetri.

d. Tanda bahaya (red flags) yang memerlukan rujuk atau tindakan segera

Penurunan kesadaran mendadak, kejang berulang, tanda fokal progresif (paresis hemifacial/hemiparesis), sakit kepala paling hebat (thunderclap),

diplopia/penurunan penglihatan progresif, demam tinggi disertai tanda neurologi → tinjau di IGD/ruang perawatan intensif dan imaging emergensi.

e. Dokumentasi & follow-up

Dokumentasikan temuan, waktu onset, perkembangan, obat yang diberikan, serta rencana (imaging, lab, rujukan). Untuk pasien dengan penyakit neurologis kronik (mis. MS), konsult neurology antenatal dan rencanakan follow-up postpartum.

2. Pemeriksaan Neurologis Pada Bayi

- a. Kondisi kesadaran / reseptivitas — tingkat respons terhadap rangsangan, period awake/sleep.
- b. Postur & tonus — fleksor/ekstensor tone, simetri; catat hypo- atau hypertonia.
- c. Gerakan spontan — kualitas gerak (menggeliat, fluent, jerky), asimetri gerakan.
- d. Refleks primitif (survival reflexes) — rooting, sucking, grasp, Moro, tonic neck, stepping; keberadaan/ketidakhadiran dan kualitasnya. Refleks primitif muncul sesuai usia dan hilang pada pola tertentu; ketidakhadiran atau asimetri reflek seperti sucking/rooting sering mengindikasikan keterlibatan batang otak atau gangguan neurologis umum. Dokumentasikan kuantitatif (ada/lemah/abnormal) agar bisa dipantau.
- e. Cranial nerves function — respons pupil, penutupan kelopak mata, refleks kornea, tangkep hisap, gag reflex.
- f. Korelasi dengan tonus kepala & fontanel — peningkatan tegangan atau sunken fontanel memberi petunjuk tekanan intrakranial/hidrasi.
- g. Refleks patologis — abnormal Babinski pada usia neonatus perlu penafsiran konteks (pada neonatus positif Babinski bisa normal; pola lain perlu evaluasi).
- h. Skoring & tools — gunakan HNNE/HINE untuk assessment sistematis dan dokumentasi yang bisa memprediksi outcome (mis. risiko cerebral palsy pada follow up). Sarnat staging menilai tingkat keparahan ensefalopati hipoksik-iskemik (ringan → sedang → berat) berdasarkan kesadaran, tonus, postur, refleks, autonomi dan kejang. Sarnat mendukung keputusan untuk terapi hipotermia (therapeutic hypothermia) bila memenuhi kriteria; evaluasi serial penting karena HIE berevolusi.

E. Pemeriksaan Penunjang Pada Ibu Dan Bayi

Mendukung temuan klinis, menambah data kuantitatif, memperkuat diagnosis, membantu pemantauan perkembangan atau respons terapi.

1. Pemeriksaan Penunjang Ibu

- a. Laboratorium dasar antenatal (kunjungan pertama & follow-up)

Tes: Hb/Hct, golongan darah & Rh, rubella/HBsAg/HIV/sifilis (RPR/VDRL), urine rutin + urine culture bila simptom, glukosa puasa/OGTT sesuai pedoman.

Indikasi: skrining risiko anemia, infeksi menular, status imunisasi, dan diabetes gestasional. ACOG/WHO merekomendasikan pemeriksaan ini pada kunjungan awal antenatal.

Interpretasi & tindakan: Hb <11 g/dL (selama kehamilan) menandakan anemia → tindak lanjut (ferrous sulfate, evaluasi penyebab). HBsAg/HIV positif → rujuk ke protokol pencegahan transmisi vertikal.

b. Pemeriksaan hematologi/koagulasi pada perdarahan & preeklampsia/HELLP

Tes: CBC (trombosit), PT/INR, aPTT, fibrinogen, AST/ALT, bilirubin, albumin, kreatinin.

Indikasi: perdarahan antepartum/postpartum, preeklampsia berat, HELLP. Fibrinogen rendah dan trombosit turun mengindikasikan DIC/koagulopati.

Catatan: perubahan kehamilan fisiologis (mis. volume plasma meningkat) memengaruhi nilai laboratorium — must interpret in pregnancy reference ranges. Studi besar juga menelusuri dinamika 76 tes lab selama kehamilan; penting memakai range yang tepat.

c. Investigasi infeksi intrapartum (Group B Streptococcus — GBS)

Tes: Swab vaginal–rectal GBS pada 35–37 minggu (kebijakan lokal) atau intrapartum intrapartum prophylaxis (IAP) bila positif. Jika IAP tidak dilakukan dan terdapat faktor risiko (PROM >18 jam, demam ibu), neonatal sepsis risk meningkat.

d. Imaging maternal

Ultrasonografi (USG obstetri & Doppler): pemeriksaan dasar untuk dating, anatomi janin, plasenta, dan cairan amnion; Doppler untuk perfusi. ISUOG dan pedoman lain memberikan panduan teknis; USG aman selama kehamilan.

Fetal MRI: digunakan bila USG tidak memadai (mis. anatomi otak janin yang kompleks).

CT/CTPA dan radiologi lain: dapat dipertimbangkan bila dicurigai emboli paru atau patologi yang mengancam nyawa; ACOG menegaskan: bila diperlukan untuk keselamatan ibu, imaging CT boleh dilakukan dengan perlindungan janin karena manfaat melebihi risiko pada kondisi emergensi.

e. Investigasi kardiak maternal

Tes: ECG, troponin jika dicurigai iskemia, echocardiography bila dicurigai peripartum cardiomyopathy (PPCM) atau gagal jantung. PPCM diidentifikasi pada akhir kehamilan/awal postpartum — echo penting untuk diagnosis dan penatalaksanaan.

f. Investigasi pada suspek trombosis/embolus

Tes & imaging: D-dimer (dibatasi interpretasinya selama kehamilan karena naik fisiologis), USG doppler vena untuk TVP, CT pulmonary angiography (CTPA) bila mencurigai PE. Diagnosis PE pada kehamilan memerlukan pertimbangan khusus; imaging emergensi diizinkan bila indikasi kuat.

g. Teknik pengambilan & praktik terbaik

Kirim sampel sebelum pemberian antibiotik bila memungkinkan (contoh: blood culture pada ibu demam intrapartum). Gunakan lab yang punya rentang rujukan kehamilan jika tersedia. Dokumentasikan waktu pengambilan, posisi pasien (untuk BP), dan kondisi klinik

2. Pemeriksaan Penunjang Bayi

a. Skrining Newborn (Neonatal Bloodspot Screening / NBS)

Tes: bloodspot heel-prick (Guthrie card) — panel bervariasi menurut program nasional: fenilketonuria, hipotiroid kongenital, beberapa inborn errors of metabolism; program sedang berekspansi (genomics/NGS pilot di beberapa pusat). Waktu: tipikal 24–72 jam setelah lahir; interpretasi dipengaruhi oleh prematuritas dan transfusi darah. Catatan: perlu follow-up konfirmasi untuk hasil abnormal (biochemical/genetic confirmatory testing). Keterbatasan: false positives pada bayi prematur/ sakit → perlu protokol tindak lanjut.

b. Investigasi neonatal sepsis / infeksi

Tes utama: blood culture (gold standard), CBC (hitung leukosit, neutrofil), CRP, procalcitonin (pCT), sepsis PCR panels (jika tersedia), urine culture (jika indikasi), CSF analysis & culture bila meningitis dicurigai. Waktu & teknik: blood culture harus diambil sebelum antibiotik bila memungkinkan; volume darah optimal sangat penting (lebih volume → sensitivitas lebih baik). Protocols seperti “EOS consensus guidelines” merekomendasikan stratifikasi risiko dan kapan melakukan kultur/ terapi empiris.

Marker inflamasi: CRP berguna untuk monitoring respons terapi (naik setelah onset, muncul beberapa jam), pCT menunjukkan performa diagnostik lebih baik pada beberapa studi; namun tidak menggantikan kultur darah.

c. Gas darah & metabolic

Tes: arterial/capillary blood gas (pH, pCO₂, base excess), lactate, glukosa. Indikasi: bayi dengan asfiksia, HIE, gangguan pernapasan, atau gangguan perfusi. pH <7.0 dan base deficit signifikan → indikator asfiksia berat; ini mempengaruhi keputusan terapi hipotermia.

d. Bilirubin & hematologi

Tes: total serum bilirubin (TSB) dan/atau transcutaneous bilirubinometry; CBC untuk hemolisis (retikulosit, darah tepi). Indikasi: ikterus klinis; gunakan kurva treatment threshold (usia jam hidup × grafis) untuk keputusan fototerapi/pertukaran transfusi. AAP & pedoman nasional memberikan threshold berbasis usia dan faktor risiko.

e. Imaging neonatal

Cranial ultrasound (USG kepala): cepat, bedside, ideal untuk prematur (IVH detection), hidrocefalus, stroke neonatal suspicion. Chest X-ray: untuk kasus respiratory distress (RDS, TTN, pneumonia, MAS). Echocardiography (neonatal): bila murmur persisten, sianosis, atau kegagalan sirkulasi dicurigai (PDA, kongenital jantung). MRI kepala: gold standard untuk penilaian lesi parenkim (HIE, malformasi) — digunakan pada penilaian lanjutan.

f. Neurophysiology monitoring

aEEG/EEG: pada ensefalopati/kejang yang suspek; aEEG berguna untuk monitoring terus menerus dan memandu terapi hipotermia. EEG diperlukan untuk konfirmasi kejang subklinikal.

g. Teknik sampling & catatan praktis

Untuk blood culture neonatal, pastikan volume menjadi praktik optimal (meskipun kecil, ambil volume sesuai protokol lokal) dan antiseptik yang tepat. Heel-prick untuk NBS harus dilakukan saat bayi cukup umur jam hidup sesuai pedoman (umumnya >24 jam kecuali strategi lokal lain). Catat bila bayi menerima transfusi → pengaruh pada NBS

F. Latihan Soal

1. Pada ibu hamil, jika tekanan darah sistolik ≥ 140 mmHg atau diastolik ≥ 90 mmHg setelah 20 minggu gestasi, ini mengindikasikan:
 - A. Anemia gestasional
 - B. Hipertensi kronik

- C. Hipertensi gestasional / preeklampsia
 - D. Hipotensi ortostatik
 - E. Infeksi saluran urine
2. Pemeriksaan tonus otot ekstremitas bawah dan atas, serta refleks patella, termasuk ke dalam pemeriksaan:
- A. Tanda vital
 - B. Neurologis
 - C. Penunjang
 - D. Inspeksi umum
 - E. Auskultasi
3. Pada bayi baru lahir, saturasi oksigen (SpO₂) yang dianggap normal setelah 10 menit pasca lahir kira-kira:
- A. 50–60 %
 - B. 60–70 %
 - C. 70–80 %
 - D. 80–90 %
 - E. 90–100 %
4. Dalam praktik kebidanan, pemeriksaan palpasi Leopold dilakukan untuk:
- A. Menentukan denyut jantung janin
 - B. Menilai posisi janin, presentasi, dan bagian terendah janin
 - C. Mengukur kadar cairan ketuban
 - D. Memeriksa plasenta
 - E. Diagnostik kelainan struktur janin
5. Dalam sistem peringatan dini maternal (MEWS), kombinasi abnormal dari tekanan darah, nadi, dan saturasi oksigen dapat memicu:
- A. Rujukan segera ke puskesmas
 - B. Monitoring lebih jarang
 - C. Tindakan intervensi lanjutan / evaluasi intensif
 - D. Pemberian vitamin
 - E. Penundaan tindakan

Jawaban

- 1. C
- 2. B
- 3. E
- 4. B
- 5. C

Soal Essay

1. Jelaskan secara sistematis langkah-langkah pemeriksaan fisik ibu hamil dari kepala ke kaki, termasuk apa yang diperhatikan di setiap area.
2. Seorang bayi baru lahir pada menit ke-1 mendapat skor APGAR sebagai berikut: Appearance = 1, Pulse = 2, Grimace = 1, Activity = 2, Respiration = 1. Jelaskan arti skor tersebut dan tindakan kebidanan yang harus dilakukan.
3. Anda menemukan pada kunjungan nifas (hari ke-3) seorang ibu dengan suhu 38,5 °C, denyut nadi 110 bpm, perdarahan lochia sangat banyak, dan fundus uteri tidak berkontraksi kuat. Jelaskan langkah intervensi kebidanan yang Anda lakukan dan alasan di balik intervensi tersebut
4. Apa tujuan skrining laboratorium pada pemeriksaan penunjang ibu hamil? Berikan contohnya.
5. Seorang ibu hamil dengan baseline tekanan darah 110/70 mmHg saat trimester kedua tiba-tiba menunjukkan tekanan 140/95 mmHg saat pemeriksaan antenatal. Jelaskan langkah yang harus dilakukan bidan dan interpretasi klinis dari kenaikan tersebut.

Pembahasan

1. Inspeksi umum: status kesadaran, ekspresi, postur, warna kulit, edema. Kepala & leher: lesi kulit, pembesaran kelenjar, tiroid, muka (simetri). Thoraks / dada: inspeksi bentuk dada, pernapasan, simetri gerakan; auskultasi paru & jantung. Abdomen: inspeksi bentuk, lemak, hernia; palpasi Leopold (presentasi, posisi janin, bagian terendah); palpasi untuk massa lain; auskultasi denyut jantung janin; perkusi (jika relevan). Genitalia eksternal: edema, varises vulva, lesi, kebersihan Ekstremitas: edema tungkai, varises, trombosis, refleks tendon (patella, achilles) Neurologis ringkas: kekuatan otot, refleks tendon bawah, sensoris pada tangan/kaki jika ada keluhan.

Pembahasan: Pemeriksaan harus sistematis agar tidak ada bagian yang terlupakan. Leopold digunakan untuk menilai kedudukan janin. Auskultasi DJJ memberi data denyut jantung janin. Neurologis ringkas penting jika ibu mengeluh gejala seperti parestesia atau kelemahan.

2. Skor total = 1 + 2 + 1 + 2 + 1 = 7

Interpretasi: skor 7 pada menit ke 1 umumnya dianggap dalam rentang "respon baik, tetapi perlu pengamatan lanjut". Tindakan: monitor intensif status pernapasan bayi, suhu, oksigenasi; jika skor pernapasan atau saturasi tidak membaik, siapkan intervensi suportif (resusitasi ringan, oksigenasi). Evaluasi lagi

pada menit ke-5, jika skor tetap rendah, lanjutkan tindakan resusitasi sesuai protokol neonatal.

3. Dugaan: infeksi postpartum + atonia uteri → perdarahan postpartum. Intervensi:
 - a. Segera lakukan evaluasi lebih lanjut (tanda vital, hemoglobin, hitung perdarahan lochia)
 - b. Menelepon dokter atau siapkan rujukan darurat
 - c. Tekan fundus secara lembut (uterine massage) untuk merangsang kontraksi
 - d. Beri oksitosin (jika di wewenang/melibatkan dokter)
 - e. Pemberian cairan IV jika diperlukan
 - f. Pemeriksaan laboratorium (CBC, kultur urin, CRP) untuk mendeteksi infeksi
 - g. Observasi ketat lochia, kontraksi uterus, kondisi umum ibu

Alasan: demam menunjukkan kemungkinan infeksi (endometritis), atonia uterus menyebabkan perdarahan, tindakan segera diperlukan untuk mencegah syok hipovolemik.

4. Mendeteksi dini masalah seperti anemia (Hb), proteinuria (preeklamsia), infeksi (HIV, sifilis).
5. Langkah dan interpretasi klinis:
 - a. Interpretasi: kenaikan tekanan ke $\geq 140/90$ mmHg dapat mengindikasikan hipertensi gestasional atau onset preeklamsia, khususnya jika disertai proteinuria atau gejala lain.
 - b. Langkah bidan:

Ulangi pengukuran dengan teknik tepat (posisi istirahat, manset ukuran sesuai), Evaluasi proteinuria (tes urin), edema, gejala lain (sakit kepala, penglihatan kabur), Monitor tekanan darah berkala atau lebih sering, Rujuk ke dokter obstetri jika persistensi atau disertai komplikasi, Dokumentasi dan tindak lanjut sesuai protokol pelayanan antenatal.

Tujuannya adalah mendeteksi atau mencegah komplikasi (preeklamsia, gangguan organ, risiko ibu–janin)

G. Glosarium

Istilah	Definisi
Anamnesa	Wawancara terarah untuk memperoleh informasi subjektif mengenai kondisi kesehatan pasien.
APGAR Score	Skala penilaian cepat terhadap kondisi bayi baru lahir berdasarkan lima komponen: Appearance, Pulse, Grimace, Activity, Respiration.
Bradikardi	Denyut jantung lebih lambat dari nilai normal fisiologis.

Hipertensi	Tekanan darah melebihi 140/90 mmHg pada orang dewasa.
Hipotermia	Penurunan suhu tubuh di bawah 36,5°C pada bayi baru lahir.
Homeostasis	Keadaan keseimbangan dinamis yang dipertahankan oleh sistem tubuh.
Nifas (Puerperium)	Masa setelah persalinan yang berlangsung sekitar 6 minggu hingga organ reproduksi kembali seperti semula.
Oksimetri Nadi (Pulse Oximetry)	Alat pengukur noninvasif untuk menentukan kadar oksigen dalam darah.
Takikardi	Denyut jantung melebihi nilai normal fisiologis.
Vital Signs (Tanda Vital)	Indikator fungsi dasar tubuh meliputi suhu, nadi, pernapasan, tekanan darah, dan saturasi oksigen.
Istilah	Definisi
IMD (Inisiasi Menyusu Dini)	Proses menyusui segera setelah bayi lahir dengan menempatkan bayi di dada ibu untuk merangsang ikatan dan produksi ASI.
MEOWS (Modified Early Obstetric Warning Score)	Sistem penilaian dini untuk mendeteksi tanda bahaya dan perubahan kondisi klinis pada ibu hamil atau nifas berdasarkan tanda vital.
MOEWS (Modified Obstetric Early Warning Score)	Versi adaptasi MEOWS yang digunakan untuk pemantauan dini pada ibu hamil dengan risiko komplikasi obstetri.
Preeklamsia	Komplikasi kehamilan yang ditandai oleh tekanan darah tinggi ($\geq 140/90$ mmHg) dan adanya protein dalam urin setelah usia kehamilan 20 minggu.
Refleks Primitif	Gerakan otomatis bayi baru lahir yang menunjukkan integritas sistem saraf, seperti refleks moro, rooting, sucking, dan grasp.
Refleks Moro	Gerakan mengejut khas bayi baru lahir saat mendengar suara keras atau perubahan posisi mendadak; biasanya hilang pada usia 4–6 bulan.
Saturasi O ₂ (SpO ₂)	Persentase oksigen yang terikat dalam hemoglobin darah; indikator penting status oksigenasi tubuh.
Takipnea	Kondisi peningkatan frekuensi napas melebihi batas normal, misalnya >60 kali/menit pada bayi baru lahir.
Sianosis	Warna kebiruan pada kulit dan mukosa akibat kadar oksigen rendah dalam darah.

Fundus Uteri	Puncak bagian atas rahim yang dapat dipalpasi melalui dinding abdomen untuk menilai tinggi dan posisi uterus.
Lochia	Cairan atau darah yang keluar dari vagina setelah persalinan, merupakan proses fisiologis pembersihan rahim.
Refleks Rooting	Refleks bayi untuk mencari puting saat pipinya disentuh; penting untuk proses menyusui.
Vital Sign (Tanda Vital)	Indikator dasar fungsi tubuh meliputi suhu, nadi, respirasi, tekanan darah, dan saturasi oksigen.
Neonatus	Bayi berusia 0–28 hari setelah kelahiran.
Asfiksia Neonatorum	Kondisi bayi baru lahir yang gagal bernapas spontan dan teratur segera setelah lahir, menyebabkan gangguan pertukaran oksigen dan karbon dioksida.
ANC (Antenatal Care)	Pelayanan kesehatan selama masa kehamilan yang bertujuan memantau dan memelihara kesehatan ibu serta janin, mencegah komplikasi, dan memberikan edukasi kesehatan.
ASI Eksklusif	Pemberian hanya air susu ibu tanpa tambahan makanan atau minuman lain (termasuk air putih) sejak lahir hingga bayi berusia 6 bulan.
BBL (Bayi Baru Lahir)	Bayi yang berusia 0–28 hari setelah dilahirkan
EDD (Estimated Date of Delivery)	Perkiraan tanggal persalinan yang dihitung berdasarkan hari pertama haid terakhir (HPHT) atau hasil ultrasonografi
GTPAL	Klasifikasi riwayat obstetri yang mencakup jumlah kehamilan (Gravida), kelahiran cukup bulan (Term), kelahiran prematur (Preterm), abortus (Abortion), dan jumlah anak hidup (Living).
PROM (Premature Rupture of Membranes)	Pecahnya ketuban sebelum proses persalinan dimulai.

H. Daftar Pustaka

- American Academy of Pediatrics. (2023). Guidelines for perinatal care (9th ed.). Elk Grove Village, IL: American Academy of Pediatrics.
- American Academy of Pediatrics. (2024). Bright Futures: Guidelines for health supervision of infants, children, and adolescents (4th ed., Periodicity schedule updates). American Academy of Pediatrics. <https://www.aap.org>
- American College of Obstetricians and Gynecologists. (2017; reaffirmed). Guidelines for diagnostic imaging during pregnancy and lactation. ACOG Committee

Opinion. <https://www.acog.org/clinical/clinical-guidance/committee-opinion/articles/2017/10/guidelines-for-diagnostic-imaging-during-pregnancy-and-lactation>

American College of Obstetricians and Gynecologists. (2020). Gestational hypertension and preeclampsia: ACOG Practice Bulletin No. 222. Obstetrics & Gynecology. <https://www.acog.org/clinical/clinical-guidance/practice-bulletin/articles/2020/06/gestational-hypertension-and-preeclampsia>

Arnolds, D. E., et al. (2022). Comparison of early warning scores for predicting clinical deterioration in obstetric patients. BMC Pregnancy and Childbirth, 22, (review/komparasi MEWS & skor terkait).

Boemer, F., et al. (2025). Population-based first-tier genomic newborn screening in a public program: feasibility & outcomes (BabyDetect pilot). Nature Medicine / 2025. <https://www.nature.com/articles/s41591-024-03465-x>

Carlson, S., & colleagues. (2023). Peripartum cardiomyopathy: Risks, diagnosis and management. Journal / PMC, 2023. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10164389/>

Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2023). Vital signs: maternal care experiences & indicators. MMWR. (statistik dan standar kualitas perawatan maternitas, termasuk pemantauan)

Chavez-Valdez, R., et al. (2021). Therapeutic hypothermia modulates relationships between clinical scores and outcomes in neonatal encephalopathy. Frontiers in Neurology, 2021. <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fneur.2021.748150/full>

Chawanpaiboon, S., Vogel, J. P., & Lumbiganon, P. (2021). Global and regional estimates of preterm birth rates: Systematic review and meta-analysis. Reproductive Health, 18(1), 35. <https://doi.org/10.1186/s12978-021-01057-9>

Chen, H. H., et al. (2024). Analysis of the impact of maternal sepsis on pregnancy outcomes and neonatal health. Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11295718/>

Chimwaza, Y., et al. (2024). Early warning systems for identifying severe maternal morbidity: a review. eClinicalMedicine / The Lancet (2024).

CMQCC / MOPQC. (2024). Maternal sepsis resource workbook / Sepsis in obstetric care toolkit. California Maternal Quality Care Collaborative (CMQCC) / Maternal Opioid and Perinatal Quality Collaborative. (Toolkit implementasi untuk deteksi & pengelolaan sepsis maternal).

Consensus Clinical Guidelines for Early Onset Sepsis (EOS) — UCSF/Berkeley/Consortiums. (2023). EOS risk stratification & management guidance. (institutional consensus). <https://medconnection.ucsfbenioffchildrens.org/news/consensus-clinical->

[guidelines-for-early-onset-sepsis-eos-screening-and-management-in-infants-greater-than-or-equal-to-34-weeks-ga](#)

- Cunningham, F. G., Leveno, K. J., Bloom, S. L., Dashe, J. S., Hoffman, B. L., Casey, B. M., & Sheffield, J. S. (2022). *Williams obstetrics* (27th ed.). New York, NY: McGraw-Hill Education.
- Darmstadt, G. L., et al. (2023). New WHO recommendations and approaches to newborn care: implications for perinatal assessment and follow-up. *Maternal and Child Health Reviews*, 2023. (review of WHO updates and integrated newborn care).
- Dimitrova, A., et al. (2024). Temperature-related neonatal deaths attributable to non-optimal ambient temperatures. *Nature Communications*, 2024. <https://www.nature.com/articles/s41467-024-49890-x>
- Evans, C. (2021). History taking and the newborn examination. *Infant Journal*, 17(4), 130–136. <https://doi.org/10.12968/inf.2021.17.4.130>
- Fadilah, A., et al. (2022). Attitudes towards the neurological examination in an unwell neonate: a qualitative study. *BMC Pediatrics*, 2022. <https://bmcpediatr.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12887-022-03616-4>
- Gantan, E. F., Baker, M. D., & Masino, A. J. (2023). Neonatal evaluation. In StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK563213/>
- Gerry, S., et al. (2024). Development of a national maternity early warning score. *BMJ Medicine*, 3(1), e000748. <https://doi.org/10.1136/bmjmed-2023-000748>
- Graham, E. L., et al. (2024). Practical considerations for managing pregnancy in women with neurological disease. *Continuum: Lifelong Learning in Neurology (Neurology)*, 2024. <https://www.neurology.org/doi/10.1212/CPJ.0000000000200253>
- Harjpal, P., et al. (2023). Promoting survival and primitive reflexes to prevent brain injury: A review. *Frontiers in Pediatrics*, 2023. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10506688/>
- ISUOG Practice Guidelines. (2023). Performance of fetal magnetic resonance imaging. *Ultrasound in Obstetrics & Gynecology*, 61, 278–287. <https://doi.org/10.1002/uog.26129>
- Kapil, N., et al. (2024). Hammersmith Infant Neurological Examination subscores and outcome prediction. *Early Human Development / Developmental Medicine & Child Neurology*, 2024. (HINE/HNNE recent validations).
- Karrar, S. A., Mohammed, A., & Khan, F. A. (2023). Initial antepartum care. In StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK554376/>

- Kokori, E., et al. (2024). Maternal and fetal neurocognitive outcomes in preeclampsia and eclampsia: a review. *European Journal of Medical Research*, 2024. <https://eurjmedres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40001-024-02070-5>
- Krbec, B. A., et al. (2024). Emerging innovations in neonatal monitoring: wearables and non-contact sensors. *Frontiers in Pediatrics*, 2024.
- Kyokan, M., et al. (2023). Early detection of cold stress to prevent hypothermia in neonates. *Journal / BMC Pediatrics* (2023). <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10184202/>
- Lawn, J. E., Kinney, M. V., Bianchi-Jassir, F., & Graham, W. J. (2021). Reducing stillbirths and neonatal deaths: An integrated approach. *The Lancet Global Health*, 9(2), e144–e156. [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(20\)30374-2](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(20)30374-2)
- Mietzsch, U., et al. (2024). Evolution of the Sarnat exam and association with 2-year outcome. *Pediatric Neurology*, 2024. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC11031347/>
- Modrell, A. K. (2023). Primitive Reflexes. In StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK554606/>
- Molina, R. L., & Paladine, H. L. (2022). Prenatal care: Initial assessment and routine visits. *American Family Physician*, 105(5), 491–500.
- O'Donnell, M., & Raghavan, R. (2022). Social determinants of maternal and neonatal health outcomes: A global perspective. *BMJ Global Health*, 7(6), e008212. <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2021-008212>
- Olney, R. S., et al. (2023). APHL/ISNS Newborn Screening Symposium — advances and implementation. *Public Health Reports / PMC*. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10594449/>
- Rabe, H., et al. (2021). Antenatal and perinatal factors influencing neonatal blood pressure and early physiology: a systematic review. *Journal of Perinatology / Reproductive Health* (2021). <https://www.nature.com/articles/s41372-021-01169-5>
- Raturi, A., & colleagues. (2024). Neonatal sepsis: Aetiology, pathophysiology, diagnostic approaches and management. *Journal of Neonatal-Perinatal Medicine*, 2024. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11452898/>
- Riaz, M., Ahmed, S., & Khan, S. (2024). Perinatal history taking and neonatal risk assessment: A comprehensive review. *Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine*, 37(5), 873–882. <https://doi.org/10.1080/14767058.2023.2245516>
- Romeo, D. M., et al. (2024). Neurological assessment tool for screening infants during early life. *Developmental Medicine & Child Neurology*, 2024. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/dmcn.15871>

- Shields, A. D., et al. (2023). Society for Maternal-Fetal Medicine Consult Series #67: Sepsis in pregnancy. *American Journal of Obstetrics and Gynecology*. (konsultasi & ringkasan manajemen sepsis pada kehamilan).
- Sturrock, S., et al. (2023). Improving the treatment of neonatal sepsis in resource-limited settings: diagnostics & implementation. *Frontiers in Pediatrics / PMC*, 2023. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10728307/>
- Sutan, R., Ahmad, N., & Azimah, M. N. (2020). Psychosocial assessment in antenatal care: Screening for perinatal mental health risks. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 20(1), 357. <https://doi.org/10.1186/s12884-020-03097-5>
- Tataranno, M. L., et al. (2021). Precision medicine in neonates: A tailored approach to neurological disease. *Frontiers in Pediatrics*, 2021. <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fped.2021.634092/full>
- Therrell, B. L., et al. (2024). Current status of newborn bloodspot screening worldwide. *International Journal of Neonatal Screening*, 2024. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC11203842/>
- U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2023). Vital Signs: Maternity care experiences — PN View Moms survey analysis. *MMWR* (2023). <https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/72/wr/mm7235e1.htm>
- Wojcieszek, A. M., et al. (2023). Strengthening the maternal–newborn care continuum: evidence and programmatic implications. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 2023. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9887708/>
- World Health Organization. (2018/updated guidance referenced 2020–2024). Labour care guide — recommendations for monitoring labour including maternal vital signs. World Health Organization. (lihat ringkasan: Normal Labor: Physiology, Evaluation, and Management).
- World Health Organization. (2022). Essential newborn care (WHO MNCAH e-handbook). World Health Organization. <https://www.who.int/teams/maternal-newborn-child-adolescent-health-and-ageing/newborn-health/essential-newborn-care>

BAB 4

PEMERIKSAAN ABDOMEN PADA KEHAMILAN DAN PERSALINAN

Tujuan Intruksional:

Mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan abdomen pada ibu hamil dan ibu dalam persalinan dengan benar, sistematis, dan sesuai prosedur untuk menilai keadaan ibu dan janin.

Tujuan Instruksional Khusus:

1. Menjelaskan prinsip dan tujuan pemeriksaan abdomen pada kehamilan.
2. Melakukan inspeksi abdomen untuk menilai bentuk, ukuran, dan perubahan fisiologis kehamilan.
3. Melakukan palpasi dengan manuver leopold I-IV untuk menentukan tinggi fundus uteri, letak, posisi, dan presentasi janin, dan penurunan kepala janin ke panggul.
4. Melakukan auskultasi untuk menilai denyut jantung janin (DJJ).
5. Mengidentifikasi hasil pemeriksaan sesuai usia kehamilan dan mendeteksi adanya kelainan.

Capaian Pembelajaran:

Mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan konsep pemeriksaan abdomen pada ibu hamil dan ibu bersalin.
2. Menguraikan prinsip, indikasi, dan tujuan pemeriksaan abdomen.
3. Menganalisis hasil pemeriksaan abdomen dalam kaitannya dengan usia kehamilan, presentasi janin, dan kemajuan persalinan.
4. Melakukan pemeriksaan abdomen pada ibu hamil secara sistematis.
5. Melakukan pemeriksaan abdomen pada ibu dalam persalinan untuk menilai kontraksi, penurunan bagian terendah janin, serta kondisi janin.
6. Menginterpretasikan hasil pemeriksaan untuk mendukung pengambilan keputusan klinis pada kehamilan dan persalinan.
7. Menunjukkan sikap empati, komunikasi terapeutik, dan menjaga kenyamanan ibu saat pemeriksaan.
8. Mempraktikkan pemeriksaan abdomen dengan menjunjung tinggi etika profesi, keselamatan pasien, serta menjaga privasi ibu.

9. Bekerjasama dalam tim interprofesional dalam memberikan asuhan kehamilan dan persalinan.

Sub CPMK;

1. Menjelaskan tujuan pemeriksaan abdomen pada ibu hamil dan ibu bersalin.
2. Menyebutkan langkah-langkah pemeriksaan abdomen.
3. Mendeskripsikan tanda-tanda hasil pemeriksaan abdomen normal pada kehamilan sesuai usia gestasi.
4. Menguraikan tanda-tanda hasil pemeriksaan abdomen pada persalinan.
5. Menganalisis hasil pemeriksaan abdomen untuk mendeteksi kelainan/ penyulit kehamilan maupun persalinan.
6. Melakukan inspeksi abdomen dengan benar untuk menilai perubahan fisiologis kehamilan.
7. Melakukan palpasi Leopold I-IV secara sistematis dan benar untuk menentukan letak, posisi, presentasi, serta penurunan bagian terendah janin.
8. Melakukan auskultasi denyut jantung janin (DJJ) dengan menggunakan Doppler atau Stetoskop Laennec.
9. Mengamati dan mencatat kontraksi uterus pada ibu dalam persalinan.
10. Mendokumentasikan hasil pemeriksaan abdomen sesuai standar format pencatatan asuhan kebidanan.
11. Menunjukkan sikap sopan, ramah dan empati kepada ibu saat pemeriksaan abdomen.
12. Menjaga kenyamanan dan privasi ibu dengan informed consent dan penggunaan draping.
13. Melaksanakan pemeriksaan sesuai prinsip etika profesi, keselamatan pasien, dan komunikasi terapeutik.
14. Menunjukkan sikap percaya diri, disiplin dan tanggungjawab dalam praktik pemeriksaan abdomen.

A. Prinsip Dasar Pemeriksaan Fisik

Pemeriksaan fisik atau pemeriksaan klinis adalah sebuah proses dari seorang ahli medis memeriksa tubuh pasien untuk menemukan tanda klinis penyakit. Hasil pemeriksaan akan dicatat dalam rekam medis. Rekam medis dan pemeriksaan fisik akan membantu dalam penegakkan diagnosis dan perencanaan perawatan pasien.

Biasanya, pemeriksaan fisik dilakukan secara sistematis, mulai dari bagian kepala dan berakhir pada anggota gerak yaitu kaki. Pemeriksaan secara sistematis tersebut disebut teknik Head to Toe. Setelah pemeriksaan organ utama diperiksa dengan inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi, beberapa tes khusus mungkin diperlukan seperti test neurologi. Dalam Pemeriksaan fisik daerah abdomen pemeriksaan dilakukan dengan sistematis inspeksi, auskultasi, palpasi, dan perkusi.

Dengan petunjuk yang didapat selama pemeriksaan riwayat dan fisik, ahli medis dapat menyusun sebuah diagnosis diferensial, yakni sebuah daftar penyebab yang mungkin menyebabkan gejala tersebut. Beberapa tes akan dilakukan untuk meyakinkan penyebab tersebut.

Sebuah pemeriksaan yang lengkap akan terdiri dari penilaian kondisi pasien secara umum dan sistem organ yang spesifik. Dalam prakteknya, tanda vital atau pemeriksaan suhu, denyut jantung, tekanan darah selalu dilakukan pertama kali.

B. Anamnesa

Salah satu keterampilan yang paling penting saat berhadapan dengan pasien adalah kemampuan anamnesa dan melakukan pemeriksaan fisik, sehingga bisa menyingkirkan different diagnosis (dd) yang kemudian menegakkan diagnosis. Ketidakmampuan dalam mencari informasi ketika meng-anamnesa pasien membuat kita tidak bisa menentukan pemeriksaan fisik yang diperlukan untuk menyingkirkan different diagnosis. Kesalahan mendiagnosis juga berarti kesalahan melakukan terapi yang tepat. Perlu diingat lagi bahwa keterampilan anamnesa sudah memenuhi 70% dalam penegakan diagnosis. Untuk itu buat kita yang bekerja di perifer dengan keterbatasan alat pemeriksaan penunjang, ada baiknya mempelajari lagi bagaimana menganamnesa pasien yang baik dan bagaimana melakukan pemeriksaan fisik yang diperlukan untuk menyingkirkan different diagnosis.

Beberapa hal yang perlu dipersiapkan ketika melakukan anamnesa kepada pasien adalah sebagai berikut:

1. **Identitas Pasien**, sebelum memulai anamnesa kepada seorang pasien, pastikan bahwa identitasnya sesuai dengan catatan medis yang dibawa. Sebenarnya ini hal

yang sepele, tetapi sering terjadi kesalahan fatal dan terkadang berakhir ke meja hijau karena melakukan tindakan medis kepada orang yang salah. Ada baiknya juga memperkenalkan diri, walau hal ini jarang dilakukan oleh dokter di Indonesia.

2. **Privasi pasien** yang berhadapan dengan kita merupakan orang terpenting saat itu. Oleh karena itu, pastikan bahwa anamnesa dilakukan ditempat yang tertutup dan menjaga kerahasiaan pasien. Terlebih ketika kita melakukan pemeriksaan fisik pada bagian tertentu.
3. **Pendamping**, hadirkan pendamping pasien dan pendamping kita (paramedis). Hal ini dibutuhkan untuk menghindari hal-hal yang mungkin kurang baik untuk pasien dan juga untuk kita terutama ketika pemeriksa dan pasiennya berlainan jenis kelamin. Selain itu, pendamping pasien juga bisa membantu memperjelas informasi yang kita butuhkan (terutama pasien lansia dan anak-anak yang susah diajak berkomunikasi).
4. **Aseptic dan disinfeksi**, tangan adalah perantara penularan kuman dari satu pasien ke pasien yang lain. Untuk itu, sebaiknya kita mencuci tangan sebelum atau sesudah memeriksa seorang pasien agar tidak terjadi penularan antar pasien. Pastikan juga stetoskop dan pakaian, seperti jas , didisinfeksi secara teratur.

C. Teknik Pemeriksaan Fisik

1. 4 Teknik dalam Pemeriksaan Fisik

a. Inspeksi

Adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan cara melihat bagian tubuh yang diperiksa melalui pengamatan. Cahaya diperlukan agar perawat dapat membedakan warna, bentuk dan kebersihan tubuh klien. Fokus inspeksi pada setiap bagian tubuh meliputi : ukuran tubuh, warna, bentuk, posisi, simetris. Dan perlu dibandingkan hasil normal dan abnormal bagian tubuh satu dengan bagian tubuh lainnya. Contoh : mata kuning (ikterus), terdapat struma di leher, kulit kebiruan (sianosis), dan lain-lain.

b. Palpasi

Palpasi adalah suatu teknik yang menggunakan indera peraba. Tangan dan jari-jari adalah instrumen yang sensitif digunakan untuk mengumpulkan data, misalnya tentang : temperatur, turgor, bentuk, kelembaban, vibrasi, ukuran.

Langkah-langkah yang perlu diperhatikan selama palpasi:

- 1) Ciptakan lingkungan yang nyaman dan santai.
- 2) Tangan perawat harus dalam keadaan hangat dan kering
- 3) Kuku jari perawat harus dipotong pendek.

4) Semua bagian yang nyeri dipalpasi paling akhir.

Misalnya : adanya tumor, oedema, krepitasi (patah tulang), dan lain-lain.

c. Perkusi

Perkusi adalah pemeriksaan dengan jalan mengetuk bagian permukaan tubuh tertentu untuk membandingkan dengan bagian tubuh lainnya (kiri kanan) dengan tujuan menghasilkan suara.

Perkusi bertujuan untuk mengidentifikasi lokasi, ukuran, bentuk dan konsistensi jaringan. Perawat menggunakan kedua tangannya sebagai alat untuk menghasilkan suara.

Adapun suara-suara yang dijumpai pada perkusi adalah :

- 1) Sonor: suara perkusi jaringan yang normal.
- 2) Redup: suara perkusi jaringan yang lebih padat, misalnya di daerah paru-paru pada pneumonia.
- 3) Pekak: suara perkusi jaringan yang padat seperti pada perkusi daerah jantung, perkusi daerah hepar.
- 4) Hipersonor/timpani: suara perkusi pada daerah yang lebih berongga kosong, misalnya daerah caverna paru, pada klien asthma kronik.

d. Auskultasi

1) Adalah pemeriksaan fisik yang dilakukan dengan cara mendengarkan suara yang dihasilkan oleh tubuh. Biasanya menggunakan alat yang disebut dengan stetoskop. Hal-hal yang didengarkan adalah : bunyi jantung, suara nafas, dan bising usus.

Suara tidak normal yang dapat diauskultasi pada nafas adalah:

- a) Rales: suara yang dihasilkan dari eksudat lengket saat saluran-saluran halus pernafasan mengembang pada inspirasi (rales halus, sedang, kasar). Misalnya pada klien pneumonia, TBC.
- b) Ronchi: nada rendah dan sangat kasar terdengar baik saat inspirasi maupun saat ekspirasi. Ciri khas ronchi adalah akan hilang bila klien batuk. Misalnya pada edema paru.
- c) Wheezing: bunyi yang terdengar "ngiii...k". bisa dijumpai pada fase inspirasi maupun ekspirasi. Misalnya pada bronchitis akut, asma.
- d) Pleura Friction Rub: bunyi yang terdengar "kering" seperti suara gosokan amplas pada kayu. Misalnya pada klien dengan peradangan pleura.

2. Pendekatan Pengkajian Fisik Dapat Menggunakan :

a. Head to toe (kepala ke kaki)

- Pendekatan ini dilakukan mulai dari kepala dan secara berurutan sampai ke kaki. Mulai dari : keadaan umum, tanda-tanda vital, kepala, wajah, mata,

telinga, hidung, mulut dan tenggorokan, leher, dada, paru, jantung, abdomen, ginjal, punggung, genetalia, rectum, ekstremitas.

b. ROS (Review of System atau sistem tubuh)

- Pengkajian yang dilakukan mencakup seluruh sistem tubuh, yaitu : keadaan umum, tanda vital, sistem pernafasan, sistem kardiovaskuler, sistem persyarafan, sistem perkemihan, sistem pencernaan, sistem muskuloskeletal dan integumen, sistem reproduksi. Informasi yang didapat membantu perawat untuk menentukan sistem tubuh mana yang perlu mendapat perhatian khusus.

c. Pola fungsi kesehatan Gordon, 1982

- Pemeriksa mengumpulkan data secara sistematis dengan mengevaluasi pola fungsi kesehatan dan memfokuskan pengkajian fisik pada masalah khusus meliputi : persepsi kesehatan-penatalaksanaan kesehatan, nutrisi-pola metabolisme, pola eliminasi, pola tidur-istirahat, kognitif-pola perseptual, peran-pola berhubungan, aktifitas-pola latihan, seksualitas-pola reproduksi, coping-pola toleransi stress, nilai-pola keyakinan.

d. Doengoes (1993)

- Mencakup : aktivitas atau istirahat, sirkulasi, integritas ego, eliminasi, makanan dan cairan, hygiene, neurosensori, nyeri atau ketidaknyamanan, pernafasan, keamanan, seksualitas, interaksi sosial, penyuluhan atau pembelajaran.

D. Pemeriksaan Fisik per Sistem

1. Pemeriksaan fisik per sistem meliputi:

- Keadaa Umum :
- Kesadaran, Tanda Vital (TD, HR, RR, Suhu), Pemeriksaan Antropometri (BB, TB, LILA)
- Kepala dan muka→ inspeksi dan palpasi
Simetris, rambut, bengkak, lembab, lesi dan bau.
- Mata → inspeksi
Gerakan bola mata, simetris atau tidak , kelainan bentuk atau penglihatan, sekret, keadaan sclera, konjungtiva, atau pupil.
- Hidung → inspeksi dan palpasi
Bentuk, masalah pada sinus, trauma, epistaksis (mimisan), hidung tersumbat
- Telinga → inspeksi dan palpasi
Bentuk, canalis bersih atau tidak, tinitus (keluar cairan putih dari lubang telinga), kehilangan pendengaran
- Mulut → inspeksi dan palpasi

Bibir → warna, simetris, lesi, kelembaban, pengelupasan dan bengkak Rongga mulut → stomatitis, kemampuan menggigit, mengunyah dan menelan Gusi → warna dan edema Gigi → karang gigi, caries, sisa gigi Lidah → kotor, warna, kesimetrisan, kelembaban, luka, bercak dan pembengkakan Kerongkongan → tonsil, peradangan, lender atau sekret

- Leher → inspeksi dan palpasi
Pembesaran kelenjar gondok dan limfe, nyeri tekan, kaku pada leher.
- Payudara:
benjolan, nyeri tekan atau rasa tidak nyaman
- Pernafasan
batuk, sputum, asma, bronkhitis, sesak napas, pilek, batuk darah
- Jantung:
tekanan darah tinggi, masalah – masalah jantung, nyeri dada, palpitasi, dispnea, ortopnea, edema
- Gastrointestinal:
Kembung, mual, muntah, nyeri tekan, kolik, obstipasi (sembelit di rektum dapat menyebabkan sulit BAB), konstipasi (sembelit di kolon), regurgitasi, salah cerna, perdarahan rektal sehingga feses berwarna hitam/melena, diare, sendawa berlebihan, pengeluaran gas berlebihan
- Genetalia
Genetalia pria : hernia, sakit pada penis, nyeri testicular atau teraba massa pada testis. Genetalia wanita : menstruasi, haid, benjolan, sakit, nyeri tekan, PMS, Leukhorea, gejala klimakterium, HPHT .
- Perkemihan
frekuensi berkemih, poli uria, nokturia, rasa sakit seperti terbakar saat berkemih, inkontinensia, prostatitis.
- Vaskular perifer
Keram pada tungkai, varises vena, pembekuan pada vena.
- Muskuloskeletal
Nyeri otot atau sendi, kekakuan, artritis, nyeri.
- Neurologis
pingsan, kejang, kesemutan, tremor atau gerakan involunter lain.
- Hematologis
anemia, berdarah, memar, kemungkinan reaksi tranfusi .
- Endokrin
masalah thyroid, intoleransi terhadap panas atau dingin, keringat berlebihan, diabetes, haus dan lapar berlebihan.
- Psikiatri: kegelisahan, tegang, depresi .

E. Konsep Dasar Pemeriksaan Fisik

Pemeriksaan fisik atau pemeriksaan klinis adalah sebuah proses dari seorang ahli medis memeriksa tubuh pasien untuk menemukan tanda klinis penyakit. Hasil pemeriksaan akan dicatat dalam rekam medis. Rekam medis dan pemeriksaan fisik akan membantu dalam penegakkan diagnosis dan perencanaan perawatan pasien.

Biasanya, pemeriksaan fisik dilakukan secara sistematis, mulai dari bagian kepala dan berakhir pada anggota gerak. Setelah pemeriksaan organ utama diperiksa dengan inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi, beberapa tes khusus mungkin diperlukan seperti test neurologi.

Dengan petunjuk yang didapat selama pemeriksaan riwayat dan fisik, ahli medis dapat menyusun sebuah diagnosis diferensial, yakni sebuah daftar penyebab yang mungkin menyebabkan gejala tersebut. Beberapa tes akan dilakukan untuk meyakinkan penyebab tersebut.

Sebuah pemeriksaan yang lengkap akan terdiri dari penilaian kondisi pasien secara umum dan sistem organ yang spesifik. Dalam prakteknya, tanda vital atau pemeriksaan suhu, denyut dan tekanan darah selalu dilakukan pertama kali.

1. Tanda vital:

a. Suhu

Pemeriksaan suhu akan memberikan tanda suhu inti yang secara ketat dikontrol karena dapat dipengaruhi oleh reaksi kimiawi.

Pemeriksaan suhu tubuh dapat dilakukan di beberapa tempat yaitu ketiak, mulut, dan anus.

Nilai standar untuk mengetahui batas normal suhu tubuh manusia dibagi menjadi empat yaitu :

- * Hipotermi, bila suhu tubuh kurang dari 36°C
- * Normal, bila suhu tubuh berkisar antara 36 - 37,5°C
- * Febris atau pireksia, bila suhu tubuh antara 37,5 - 40°C
- * Hipertermi, bila suhu tubuh lebih dari 40°C

b. Tekanan darah

Tekanan darah dinilai dalam dua hal, sebuah tekanan tinggi sistolik yang menandakan kontraksi maksimal jantung dan tekanan rendah diastolik atau tekanan istirahat.

Pemeriksaan tekanan darah biasanya dilakukan pada lengan kanan, kecuali pada lengan tersebut terdapat cedera. Perbedaan antara tekanan sistolik dan diastolik disebut tekanan denyut. Di Indonesia, tekanan darah biasanya diukur dengan tensimeter air raksa.

Tidak ada nilai tekanan darah 'normal' yang tepat, namun dihitung berdasarkan rentang nilai berdasarkan kondisi pasien. Tekanan darah amat dipengaruhi oleh kondisi saat itu, misalnya seorang pelari yang baru saja melakukan lari maraton, memiliki tekanan yang tinggi, namun ia dalam nilai sehat. Dalam kondisi pasien tidak bekerja berat, tekanan darah normal berkisar 120/80 mmHg. Tekanan darah tinggi atau hipertensi diukur pada nilai sistolik 140-160 mmHg. Tekanan darah rendah disebut hipotensi.

c. Denyut

Denyut merupakan pemeriksaan pada pembuluh nadi atau arteri. Ukuran kecepatannya diukur pada beberapa titik denyut misalnya denyut arteri radialis pada pergelangan tangan, arteri brachialis pada lengan atas, arteri karotis pada leher, arteri poplitea pada belakang lutut, arteri dorsalis pedis atau arteri tibialis posterior pada kaki. Pemeriksaan denyut dapat dilakukan dengan bantuan stetoskop.

Denyut sangat bervariasi tergantung jenis kelamin, jenis pekerjaan, dan usia. Bayi yang baru dilahirkan (neonatus) dapat memiliki denyut 130-150 denyut per menit. Orang dewasa memiliki denyut sekitar 60-80 per menit.

d. Kecepatan pernapasan

Beraneka ragam tergantung usia. Batas normalnya sekitar 12-16 kali penarikan napas per menit.

Biometrika dasar:

1) Tinggi

Tinggi merupakan salah satu ukuran pertumbuhan seseorang. Tinggi dapat diukur dengan stadiometer atau tongkat pengukur. Pasien akan diminta untuk berdiri tegak tanpa alas kaki. Anak-anak berusia dibawah 2 tahun diukur tingginya dengan cara dibaringkan.

2) Berat atau massa

Berat atau massa tubuh diukur dengan pengukur massa atau timbangan. Indeks massa tubuh digunakan untuk menghitung hubungan antara tinggi dan massa sehat serta tingkat kegemukan.

3) Nyeri

Pengukuran nyeri bersifat subjektif namun penting sebagai tanda vital. Dalam klinik, nyeri diukur dengan menggunakan skala FACES yang dimulai dari nilai '0' (tidak dirasakan nyeri pada pasien dapat dilihat dari ekspresi wajah pasien), hingga '5' (nyeri terburuk yang pernah dirasakan pasien).

2. Struktur dalam penulisan riwayat pemeriksaan:

a. Tampilan umum

- 1) Kondisi yang jelas tertangkap ketika pasien masuk ke ruangan konsultasi dan berkomunikasi dengan dokter. (misalnya: pasien terlihat pincang atau pasien mengalami ketulian sehingga sulit berkomunikasi)
- 2) JACCOL, sebuah jembatan keledai, untuk tanda kekuningan (Jaudience), kemungkinan tanda pucat pada kulit atau konjungtiva (Anaemia), tanda kebiruan pada bibir atau anggota gerak (Cyanosis), kelainan bentuk pada kuku jari (Clubbing), pembengkakan (Oedema atau Edema), dan, pemeriksaan pada nodus limfatikus (Lymph nodes) pada leher, ketiak, dan lipatan paha.

b. Sistem organ

- 1) Sistem kardiovaskular
 - Tekanan darah, denyut nadi, irama jantung
 - Tekanan vena jugularis atau Jugular veins preassure (JVP), edema perifer, dan bukti edema pulmonaris atau edema paru.
- 2) Pemeriksaan jantung
- 3) Paru-paru
 - Kecepatan pernapasan, auskultasi paru-paru
- 4) Dada dan payudara
- 5) Abdomen
 - Pemeriksaan abdomen misalnya pendeteksian adanya pembesaran organ (contohnya aneurisma aorta)
 - Pemeriksaan rektum
- 6) Sistem reproduksi
- 7) Sistem otot dan gerak
- 8) Sistem saraf, termasuk pemeriksaan jiwa
- 9) Pemeriksaan kepala, leher, hidung, tenggorokkan, telinga (THT)
- 10) Kulit
 - Pemeriksaan pada pertumbuhan rambut
 - Pemeriksaan tanda klinis pada kulit

F. Pemeriksaan Fisik Pada Ibu Hamil

1. Tujuan dalam pemeriksaan fisik ini yaitu untuk menilai kondisi kesehatan ibu dan bayinya serta tingkat kenyamanan fisik ibu bersalin informasi dari hasil pemeriksaan fisik dan anamnesa untuk membuat keputusan klinik, menegakkan diagnosis, dan mengembangkan rencana asuhan yang paling sesuai dengan kondisi ibu.

Langkah – langkah melakukan Pemeriksaan Fisik:

- a. Cuci tangan

- b. Tunjukkan sikap ramah
- c. Minta ibu mengosongkan kandung kemih
- d. Nilai kesehatan dan tingkat kenyamanan ibu.
- e. Nilai TTV ibu.
- f. Lakukan pemeriksaan abdomen
- g. Lakukan pemeriksaan dalam
- h. Cuci tangan

Pemeriksaan Abdomen, tujuannya yaitu :

- a. Menentukan tinggi fundus uteri
- b. Menantau kontraksi uterus
- c. Memantau DJJ
- d. Menentukan presentasi
- e. Menentukan penurunan bagian terbawah janin

2. Yang Perlu di Perhatikan Dalam Pemeriksaan Fisik Kala 1

a. Menentukan Tinggi Fundus

Pastikan pengukuran dilakukan pada saat uterus tidak sedang berkontraksi. Ukur tinggi fundus dengan menggunakan pita pengukur. Mulai dari tepi atas simpisis pubis kemudian rentangkan pita pengukur hingga ke puncak fundus mengikuti aksis atau linea medialis dinding abdomen. Lebar pita harus menempel pada dinding abdomenn ibu. Jarak antara tepi atas simpisis pubis dan puncak fundus uteri adalah tinggi fundus.

b. Memantau Kontraksi Uterus

Gunakan jarum detik yang ada pada jam untuk memantau kontraksi uterus letakkan tangan penolong pada atas uterus dan palpasi jumlah kontraksi yang terjadi dalam waktu 10 menit. Tentukan durasi setiap kontraksi yang terjadi. Pada fase aktif minimal terjadi 2 kontraksi dalam 10 menit dan lama kontraksi adalah 40 detik atau lebih. Diantara 2 kontraksi akan terjadi relaksasi dinding uterus.

c. Memantau DJJ

Gunakan laennec atau dopler untuk mendengarkan DJJ dan menghitung DJJ per menit. Lakukan penilaian DJJ pada lebih dari 1 kontraksi. Gunakan jarum detik (jam) nilai DJJ selama dan segera setelah kontraksi uterus. Dengar DJJ min 60 detik, dengarkan sampai sedikitnya 30 kontraksi. Gangguan kondisi kesehatan janin dicerminkan dari DJJ yang kurang dari 120 atau lebih dari 160 kali per menit. Kegawatan janin ditunjukkan dari DJJ yang kurang dari 100 atau lebih dari 180 kali per menit. Bila demikian baringkan ibu ke sisi kiri dan anjurkan ibu untuk relaksasi. Nilai kembali DJJ setelah 5 menit dari

pemeriksaan sebelumnya, kemudian simpulkan perubahan yang terjadi. Jika DJJ tidak mengalami perbaikan maka siapkan ibu untuk segera di rujuk.

Pemeriksaan abdomen selama kehamilan dan persalinan meliputi auskultasi untuk mendengarkan bising usus dan detak jantung janin menggunakan Doppler, bukan Laennec, yang merupakan stetoskop monoaural. Doppler digunakan untuk mendeteksi detak jantung janin secara efektif, sementara stetoskop biasa atau auskultasi abdomen fokus pada perubahan bising usus.

Auskultasi Abdomen bertujuan untuk mendengarkan suara bising usus dan suara lainnya di perut dengan menggunakan stetoskop.

- Pada Kehamilan: Perubahan bising usus dapat terjadi, dan deteksi gerakan janin juga dapat membantu mengkonfirmasi kehamilan.
- Pada Persalinan: Mengamati adanya kontraksi dan memastikan janin bergerak.
- Pemeriksaan Nifas: Memeriksa bising usus pascapersalinan, dan mengamati adanya perubahan bising.

Penggunaan Doppler bertujuan untuk mendeteksi dan mendengarkan detak jantung janin (DJJ).

- Pada Kehamilan: Doppler sangat penting untuk memantau kesehatan dan perkembangan janin.
- Pada Persalinan: Digunakan secara terus menerus untuk memantau kondisi janin selama persalinan.
- Pada Nifas: Digunakan untuk memeriksa detak jantung janin yang masih ada atau berkembang

Penggunaan Laennec: digunakan sebagai stetoskop monoaural untuk memeriksa bising usus bukan alat yang tepat untuk memeriksa detak jantung janin.

d. Menentukan Presentasi

Untuk menentukan presentasi bayi :

- 1) Berdiri disamping dan menghadap ke kepala ibu.
- 2) Dengan ibu jari dan jari tengah dari 1 tangan pegang bagian terbawah janin.
- 3) Jika bagian terbawah janin belum masuk maka bagian tersebut masih dapat digerakan.
- 4) Untukkan presentasi kepala atau bokong maka perhatikan bentuk, ukuran dan kepadatannya.

e. Menentukan Penurunan Bagian Terbawah Janin

Penilaian penurunan kepala janin dilakukan dengan menghitung proporsi bagian terbawah janin yang masih berada diatas tepi atas simpisis dan dapat

diukur dengan 5 jari tangan pemeriksa. Bagian diatas simpisis adalah proporsi yang belum masuk PAP dan sisanya menunjukkan sejauh mana bagian terbawah janin telah masuk kedalam rongga panggul.

Penurunan bagian terbawah dengan metode 5 jari adalah :

- 1) 5/5 jika bagian terbawah seluruh teraba diatas simpisis pubis.
- 2) 4/5 jika sebagian terbawah janin telah masuk PAP
- 3) 3/5 jika sebagian telah memasuki rongga panggul
- 4) 2/5 jika hanya sebagian terbawah janin masih berada diatas simpisis
- 5) 1/5 jika hanya 1 dari 5 jari masih dapat meraba bagian bawah janin yang berada diatas simpisis.
- 6) 0/5 jika bagian terbawah janin tidak dapat teraba dari pemeriksaan luar.

f. Periksa Dalam

Sebelum melakukan pemeriksaan dalam cuci tangan dengan sabun dan air bersih, kemudian keringkan dengan handuk kering dan bersih. Minta ibu untuk berkemih dan mencuci area genitalia dengan sabun dan air.

Jelaskan pada ibu setiap langkah yang akan dilakukan selama pemeriksaan. Tentramkan hati dan anjurkan ibu untuk rileks. Pastikan privasi ibu terjaga selama pemeriksaan dilakukan. Langkah – langkah dalam melakukan pemeriksaan dalam :

- 1) Tutupi badan ibu dengan selimut
- 2) Minta ibu berbaring telentang dengan lutut ditekuk
- 3) Gunakan handscoon
- 4) Gunakan kasa yang di celupkan ke larutan anti septik
- 5) Periksa genetalia eksterna
- 6) Nilai cairan vagina
- 7) Pisahkan labia mayora dg jari manis dan ibu jari
- 8) Nilai vagina
- 9) Nilai pembukaan dan penipisan servik
- 10) Pastikan tali pusat tidak teraba
- 11) Nilai penurunan bagian terbawah janin
- 12) Jika bagian terbawah adlh kepala pastikan penunjuknya
- 13) Jika pemeriksaan sudah lengkap keluarkan kedua jari pemeriksa
- 14) Cuci tangan
- 15) Bantu ibu untuk mengambil posisi yang nyaman
- 16) Jelaskan hasil pemeriksaan pada ibu

G. Pemeriksaan Fisik pada Ibu Bersalin

1. Definisi

Persalinan adalah proses dimana bayi, plasenta dan selaput ketuban keluar dari uterus ibu. Persalinan dianggap normal jika prosesnya terjadi pada usia kehamilan cukup bulan (setelah 37 Minggu) tanpa disertai penyulit. Persalinan dimulai (inpartu) sejak uterus berkontraksi dan menyebabkan perubahan pada serviks (membuka dan menipis) dan berakhir dengan lahirnya plasenta secara lengkap. Ibu belum dapat dikategorikan inpartu jika kontraksi uterus tidak mengakibatkan perubahan atau pembukaan serviks.

Tanda dan gejala inpartu termasuk:

- a. Kontraksi uterus yang mengakibatkan perubahan serviks (frekuensi minimal 2 kali dalam 10 menit)
- b. Penipisan dan pembukaan serviks
- c. Cairan lendir bercampur darah melalui vagina

Tahapan Persalinan

a. Kala 1: Kala pembukaan

Definisi Kala I ialah waktu untuk pembukaan serviks sampai menjadi pembukaan lengkap (10 cm) atau dimulai sejak kontraksi uterus yang teratur dan meningkat yaitu frekuensi serta kekuatannya 6 hingga terjadinya pembukaan lengkap atau pembukaan 10 cm. Dalam kala pembukaan dibagi menjadi 2 fase:

1) Fase laten

- Dimulai sejak awal kontraksi yang menyebabkan penipisan dan pembukaan serviks secara bertahap
- Pembukaan kurang dari 4 cm
- Biasanya berlangsung antara 6 - 8 jam

2) Fase aktif

- Frekuensi dan lama kontraksi uterus umumnya meningkat (kontraksi adekuat / 3 kali atau lebih dalam 10 menit dan berlangsung selama 40 detik atau lebih)
- Serviks membuka dari 4 ke 10, biasanya dengan kecepatan 1cm/lebih perjam hingga pembukaan lengkap (10)
- Terjadi penurunan bagian terbawah janin
- Berlangsung selama 6 jam

2. Manajemen Asuhan Kala Satu

- a. Identifikasi Masalah Identifikasi dilakukan terhadap permasalahan yang mungkin ditemukan pada persalinan kala satu.

- 1) Riwayat kesehatan Dalam hubungannya dengan diagnosis persalinan, perlu menilai kapan mulai adanya his/kontraksi, berapa lama dan berapa sering kontraksi timbul, adanya perdarahan pervaginam atau air ketuban jika sudah pecah. Menanyakan 7 mengenai kesehatannya secara umum dan kesejahteraannya selama kehamilan.
 - 2) Pengkajian fisik maternal Pemeriksaan fisik pada ibu meliputi keadaan umum, tanda vital, dan pemeriksaan head to toe. Pada abdomen diperiksa pola kontraksi, tinggi fundus uteri, pengukuran lingkar abdomen jika dicurigai kehamilan kembar atau polihidramnion. Pemeriksaan pelviks diperlukan untuk mengetahui penipisan dan pembukaan serviks, posisi serviks, dan penurunan kepala berdasarkan hodge. Pada ekstremitas diperiksa adanya edema dan reflek patella.
 - 3) Pengkajian fisik janin Dalam mengkaji status janin dilakukan pemeriksaan denyut jantung janin, normalnya 120-160 kali per menit. Taksiran berat janin dapat dihitung dari Tinggi Fundus Uteri (TFU). Letak dan presentasi janin dapat diketahui dari hasil pemeriksaan palpasi abdomen maupun pemeriksaan dalam, sedangkan untuk posisi janin dapat diketahui dari hasil pemeriksaan dalam.
- b. Penentuan Diagnosis-Diagnosis ditentukan berdasarkan data-data yang diperoleh, yaitu apakah ibu sedang dalam inpartu kala satu fase laten atau fase aktif.
 - c. Penilaian kemajuan persalinan Informasi pada poin-poin berikut ini digunakan dalam evaluasi kemajuan persalinan yang berkelanjutan, yaitu penipisan serviks, pembukaan serviks, stasion (penurunan kepala/bagian terendah janin), pola kontraksi (frekuensi, durasi, intensitas), perubahan perilaku ibu, tanda dan gejala transisi dan menjelang kala dua persalinan, posisi nyeri punggung bawah, posisi lokasi denyut jantung janin.
 - d. Rencana Asuhan Kala Satu Asuhan kala I dapat direncanakan berdasarkan analisis masalah. Rencana dan penatalaksanaan dibuat agar dapat memantau perubahan tubuh ibu untuk menentukan apakah persalinan dalam kemajuan yang normal, memeriksa perasaan ibu dan respons fisik terhadap persalinan, memeriksa bagaimana janin bereaksi saat persalinan, membantu memahami apa yang sedang terjadi sehingga ibu dapat berperan serta aktif dalam menentukan asuhan, membantu keluarga dalam merawat ibu selama proses persalinan, mengenali masalah secepatnya dan mengambil keputusan yang tepat.
- 1) Pemanatauan kesejahteraan ibu dan janin (partograf) Partograf adalah alat untuk mencatat hasil observasi dan pemeriksaan fisik ibu dalam proses

persalinan serta merupakan alat utama dalam mengambil keputusan klinik khususnya pada persalinan kala Satu.

- 2) Dukungan emosional Asuhan yang sifatnya mendukung selama persalinan merupakan ciri dari asuhan kebidanan. Asuhan yang mendukung artinya kehadiran yang aktif dan ikut serta dalam kegiatan yang sedang berlangsung. Menganjurkan pada suami dan atau anggota keluarga untuk mendampingi ibu selama proses persalinan. Seorang teman yang mendukung merupakan sumber kekuatan yang besar dan memberikan kesinambungan dukungan yang tidak dapat digantikan oleh orang lain.
- 3) Pengendalian nyeri Salah satu kebutuhan ibu dalam proses persalinan adalah pengurangan rasa sakit. Persepsi rasa sakit, cara yang dirasakan oleh individu dan reaksi terhadap rasa sakit yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain:
 - Rasa sakit atau kecemasan akan meningkatkan respons individual terhadap rasa sakit. Takut terhadap hal yang belum diketahui, sendirian tanpa pendamping pada proses persalinan, takut terjadi kegagalan dalam persalinan, dapat meningkatkan kecemasan. Pengalaman yang buruk pada persalinan sebelumnya juga akan menambah kecemasan.
 - Kepribadian ibu juga mempunyai peran yang penting dalam pengendalian nyeri. Ibu yang rileks dan tenang 10 lebih mampu menghadapi nyeri persalinan dibandingkan ibu merasa tegang dan cemas.
 - Ibu yang kelelahan karena istirahatnya terganggu dengan ketidaknyamanan pada akhir kehamilan akan kurang mampu mengendalikan rasa nyeri.
 - Social dan budaya masyarakat setempat mempunyai peranan penting terhadap persepsi ibu menghadapi rasa nyeri persalinan. Beberapa budaya mengharapkan stoitisme (sabar dan membiarkannya), sedangkan budaya lain mendorong keterbukaan untuk menyatakan perasaan.
 - Pengharapan akan menimbulkan perbedaan pada pengalaman persalinan. Ibu yang realistis dalam pengharapannya mengenai persalinan dan tanggapannya mengenai hal tersebut merupakan persiapan terbaik dalam menghadapi persalinan, selama mempunyai kepercayaan diri akan bantuan serta dukungan yang dibutuhkannya pada proses persalinan. Cara untuk mengurangi rasa sakit pada proses persalinan adalah mengurangi rasa sakit langsung dari sumbernya, memberikan rangsangan alternatif yang kuat, mengurangi reaksi fisik dan mental negatif, serta emosional ibu terhadap rasa sakit. Pemijatan secara

lembut akan membantu ibu merasa lebih rileks, segar dan nyaman selama persalinan. Hal ini terjadi karena pijat merangsang tubuh melepaskan senyawa endorfin yang merupakan pereda sakit alami. Endorfin juga dapat menciptakan perasaan nyaman dan enak. Dalam persalinan, pijat juga membantu ibu merasa lebih dekat dengan orang yang merawatnya.

- 4) Posisi dan Mobilitas Anjurkan ibu untuk mencoba posisi yang nyaman selama persalinan dan anjurkan pendamping untuk membantu ibu berganti posisi. Ibu boleh berjalan, berdiri, duduk, jongkok, berbaring miring atau merangkak.
- 5) Pencegahan infeksi Kepatuhan dalam menjalankan praktik pencegahan infeksi yang baik akan melindungi ibu, penolong, dan keluarga dari infeksi.

b. Kala II: Kala pengeluaran janin

Kala dua persalinan dimulai dari pembukaan lengkap dengan kekuatan his ditambah kekuatan mengejan mendorong janin hingga keluar dan berakhir dengan lahirnya bayi (Kurniarum, 2016) Pada kala II ini memiliki ciri khas:

- 1) His terkoordinir, kuat, cepat dan lebih lama kira-kira 2-3 menit sekali
- 2) Kepala janin telah turun masuk ruang panggul dan menimbulkan rasa ingin mengejan
- 3) Meningkatnya pengeluaran lendir bercampur darah 12
- 4) Tekanan pada rectum atau vagina seperti ibu merasa ingin BAB
- 5) Perineum menonjol
- 6) Vulva dan sfingter ani membuka

c. Kala III: Kala Pengeluaran Plasenta

Kala pengeluaran plasenta yaitu waktu pelepasan dan pengeluaran uri (plasenta)/dimulai setelah bayi lahir dan berakhir dengan lahirnya plasenta dan selaput ketuban. Setelah bayi lahir kontraksi rahim berhenti sebentar, uterus teraba keras dengan fundus uteri setinggi pusat. Beberapa saat kemudian timbul his pengeluaran dan pelepasan uri, dalam waktu 1 – 5 menit plasenta terlepas terdorong kedalam vagina dan akan lahir spontan atau dengan sedikit dorongan. Dan pada pengeluaran plasenta biasanya disertai dengan pengeluaran darah kira – kira 100-200cc. Pada kala III persalinan, otot uterus berkontraksi mengikuti penyusutan volume rongga uterus setelah bayi lahir. Penyusutan ukuran ini menyebabkan berkurangnya ukuran tempat perlekatan plasenta. Karena tempat perlekatan menjadi semakin kecil, sedangkan ukuran plasenta tidak berubah maka plasenta akan terlipat, menebal dan kemudian lepas dari dinding uterus. Setelah lepas plasenta akan turun ke bagian bawah uterus atau ke dalam vagina.

Tanda – tanda pelepasan plasenta

- 1) Perubahan tinggi dan bentuk fundus
- 2) Tali pusat memanjang
- 3) Semburan darah mendadak dan singkat

Manajemen aktif kala III Tujuan Manajemen Aktif Kala III ialah membuat uterus berkontraksi lebih efektif sehingga dapat mempersingkat waktu, mencegah perdarahan dan mengurangi kehilangan darah selama kala III persalinan.

Manajemen Aktif Kala III terdiri dari

- 1) Pemberian suntikkan oksitosin dalam 1 menit pertama setelah bayi lahir
- 2) Melakukan PTT/ penegangan tali pusat terkendali
- 3) Masase fundus uteri

d. Kala IV: Kala pengawasan

Kala IV yaitu waktu setelah bayi lahir dan uri selama 1-2 jam dan waktu dimana untuk mengetahui keadaan ibu terutama terhadap bahaya perdarahan post partum. Pengawasan kala 4 ini dilakukan setelah ibu merasa nyaman. Observasi yang dilakukan adalah:

- 1) Tingkat kesadaran penderita
- 2) Pemeriksaan tanda-tanda vital, tekanan darah, nadi, dan pernapasan
- 3) Kontraksi uterus
- 4) Terjadi perdarahan

H. Pemeriksaan Saat Ibu Nifas

Masa nifas (puerperium) dimulai setelah plasenta lahir dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil. Masa nifas berlangsung kira-kira 6 minggu.

Ada 2 kejadian penting dalam masa nifas, yaitu:

1. Involusi
2. Laktasi

Periode Nifas

1. Immediate Puerperium

Adalah keadaan yang terjadi pada permulaan persalinan sampai 24 jam sesudah persalinan

2. Early Puerperium

Adalah keadaan yang terjadi pada permulaan persalinan (waktu 1 hari sampai dengan 7 hari setelah persalinan)

3. Late Puerperium

Adalah waktu seminggu sampai dengan 6 minggu setelah persalinan.

Lochea

Adalah cairan pertama yang keluar dari vagina pada hari pertama nifas:

1. Pada hari ke-1 dan 2 masa nifas berupa darah (lochea rubra)
2. Pada 3-4 hari darah yang keluar encer (lochea serosa)
3. -Pada hari ke-10 menjadi cairan putih atau kekuningan (lochea alba).

I. Latihan

1. Tujuan utama pemeriksaan abdomen pada kehamilan adalah ...
 - a. Menentukan jumlah janin
 - b. Menilai pertumbuhan dan perkembangan janin
 - c. Menentukan usia kehamilan berdasarkan TFU
 - d. Menentukan kelainan rahimKunci: b
2. Manuver Leopold II dilakukan untuk ...
 - a. Menentukan tinggi fundus uteri
 - b. Menentukan bagian terbawah janin
 - c. Menentukan posisi punggung janin
 - d. Menentukan seberapa jauh kepala masuk panggulKunci: c
3. Seorang ibu hamil 36 minggu dilakukan pemeriksaan abdomen. Hasil palpasi: fundus uteri setinggi 3 jari di bawah processus xifoideus, bagian terbawah teraba bulat keras dan melenting, DJJ terdengar di bawah pusat bagian kiri. Interpretasi yang tepat adalah ...
 - a. Letak kepala, punggung kiri, kepala sudah masuk PAP
 - b. Letak bokong, punggung kanan, DJJ normal
 - c. Letak kepala, punggung kanan, kepala belum masuk PAP
 - d. Letak bokong, punggung kiri, kepala masih tinggiKunci: a
4. Pada persalinan, pemeriksaan abdomen terutama dilakukan untuk ...
 - a. Menentukan usia kehamilan
 - b. Menilai jumlah cairan ketuban
 - c. Menilai kontraksi uterus dan penurunan kepala
 - d. Mengetahui adanya kelainan rahimKunci: c
5. Seorang ibu bersalin kala I fase aktif, kontraksi 3 kali dalam 10 menit, masing-masing berlangsung 45 detik. DJJ terdengar 140x/menit sebelum dan sesudah kontraksi. Interpretasi hasil pemeriksaan abdomen adalah ...
 - a. Kontraksi tidak adekuat, DJJ normal

- b. Kontraksi adekuat, DJJ normal
- c. Kontraksi adekuat, DJJ bradikardi
- d. Kontraksi tidak adekuat, DJJ takikardi

Kunci: b

J. Rangkuman Materi

Pemeriksaan fisik atau pemeriksaan klinis adalah sebuah proses dari seorang ahli medis memeriksa tubuh pasien untuk menemukan tanda klinis penyakit. Biasanya, pemeriksaan fisik dilakukan secara sistematis, mulai dari bagian kepala dan berakhir pada anggota gerak. Setelah pemeriksaan organ utama diperiksa dengan inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi, beberapa tes khusus mungkin diperlukan seperti test neurologi.

Dengan petunjuk yang didapat selama pemeriksaan riwayat dan fisik, ahli medis dapat menyusun sebuah diagnosis diferensial, yakni sebuah daftar penyebab yang mungkin menyebabkan gejala tersebut. Beberapa tes akan dilakukan untuk meyakinkan penyebab tersebut. Sebuah pemeriksaan yang lengkap akan terdiri dari penilaian kondisi pasien secara umum dan sistem organ yang spesifik.

K. Glosarium

Abdomen → Bagian perut, area tubuh antara dada dan panggul.

TFU (Tinggi Fundus Uteri) → Jarak dari tepi atas simfisis pubis ke puncak rahim, digunakan untuk memperkirakan usia kehamilan dan pertumbuhan janin.

Manuver Leopold → Empat teknik palpasi abdomen untuk menentukan letak, posisi, presentasi, dan penurunan bagian terbawah janin.

Presentasi → Bagian janin yang berada di bawah dan akan lahir terlebih dahulu (umumnya kepala).

Letak janin → Posisi sumbu panjang janin terhadap sumbu panjang ibu (letak memanjang, melintang, atau miring).

Posisi janin → Hubungan punggung janin dengan sisi kanan atau kiri ibu (misalnya punggung kiri atau punggung kanan).

Engagement → Masuknya bagian terbawah janin (kepala/bokong) ke pintu atas panggul (PAP).

DJJ (Denyut Jantung Janin) → Detak jantung janin yang normalnya 110–160 kali per menit.

Auskultasi → Pemeriksaan dengan mendengarkan suara, dalam kebidanan biasanya untuk mendengar DJJ dengan stetoskop Laennec atau Doppler.

Kontraksi Uterus → Tegangnya otot rahim secara ritmik pada persalinan, dinilai frekuensi, durasi, dan intensitasnya.

Frekuensi kontraksi → Berapa kali kontraksi terjadi dalam 10 menit.

Durasi kontraksi → Lamanya satu kontraksi dalam hitungan detik.

Intensitas kontraksi → Kekuatan kontraksi (ringan, sedang, kuat).

Informed consent → Persetujuan ibu setelah mendapatkan penjelasan tentang prosedur pemeriksaan.

Draping → Menutup tubuh ibu dengan kain untuk menjaga privasi saat pemeriksaan.

Kala Persalinan → Tahapan persalinan:

Kala I : pembukaan serviks,

Kala II : bayi lahir,

Kala III : plasenta lahir,

Kala IV : pemantauan 2 jam post partum.

L. Referensi

Cunningham, F.G., Leveno, K.J., Bloom, S.L., Dashe, J.S., Hoffman, B.L., Casey, B.M., Spong, C.Y. (2022). *Williams Obstetrics* (26th ed.). New York: McGraw-Hill.

JNPK-KR. (2017). *Pedoman Pelayanan Antenatal, Persalinan, Nifas, dan Bayi Baru Lahir*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

Kementerian Kesehatan RI. (2020). *Pedoman Pelayanan Antenatal Terpadu*. Jakarta: Kemenkes RI.

Lowdermilk, D.L., Perry, S.E., Cashion, K., Alden, K.R. (2021). *Maternity & Women's Health Care* (13th ed.). St. Louis: Elsevier.

Manuaba, I.B.G. (2018). *Ilmu Kebidanan, Penyakit Kandungan dan Keluarga Berencana*. Jakarta: EGC.

Saifuddin, A.B. (2020). *Ilmu Kebidanan*. Jakarta: Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.

Varney, H. (2019). *Varney's Midwifery* (6th ed.). Burlington: Jones & Bartlett Learning.

WHO (2016). *WHO Recommendations on Antenatal Care for a Positive Pregnancy Experience*. Geneva: World Health Organization.

BAB 6

PEMERIKSAAN DASAR PADA KEHAMILAN, PERSALINAN DAN NIFAS

Deskripsi Pembelajaran

Topik pembelajaran ini akan memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk dapat memahami tentang pemeriksaan dasar pada kehamilan, persalinan dan nifas.

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari topik ini diharapkan mahasiswa mampu:

1. Memahami tentang optimalisasi posisi fetus
2. Memahami tentang pemeriksaan dalam dan penggunaan spekulum
3. Memahami tentang perbaikan perinium.

Capaian Pembelajaran

Mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis ilmu kebidanan, manajemen asuhan kebidanan, keputusan klinis, model praktik kebidanan, dan etika profesi secara mendalam dalam optimalisasi posisi fetus, pemeriksaan dalam dan penggunaan spekulum, dan tentang perbaikan perinium.

Uraian Materi

Pada materi kali ini saudara akan belajar mengenai pembelajaran optimalisasi posisi fetus, pemeriksaan dalam dan penggunaan spekulum dan perbaikan perinium pada ibu. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan sebagai berikut:

A. Optimalisasi Posisi Fetus

Optimalisasi posisi fetus menurut teori Optimal Fetal Positioning (OFP), yang dikembangkan oleh Jean Sutton dan Pauline Scott, menekankan pentingnya gerakan dan posisi tubuh ibu selama kehamilan untuk mendorong bayi memposisikan diri secara optimal, yaitu presentasi kepala (kepala bayi di bawah) menghadap punggung ibu dengan dagu menempel di dada. Praktik seperti berjalan, membungkuk, dan menggunakan bola persalinan dapat membantu bayi menempati posisi yang menguntungkan untuk kelahiran.

Optimalisasi posisi fetus merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengurangi nyeri saat kontraksi persalinan dan mengoptimalkan posisi bayi dalam proses persalinan.

Optimalisasi posisi janin adalah suatu metode yang digunakan untuk mengoptimalkan posisi janin yang dapat dilakukan sebelum dan saat proses persalinan berlangsung agar proses persalinan dapat berlangsung dengan nyaman, aman, cepat, mudah, dan minim trauma.

Posisi janin yang optimal adalah posisi anterior dimana kepala janin berada di bawah dan wajahnya menghadap ke punggung. Namun, jika usia kandungan masih di bawah 36 minggu dan posisi janin masih belum optimal tidak perlu khawatir, karena dibawah 36 minggu janin masih memiliki banyak ruang kosong untuk bergerak sehingga membuat posisinya masih berubah ubah.

Memasuki usai 36minggu sebaiknya janin sudah berada di posisi optimal/anterior agar memudahkan proses persalinan.

1. Macam-macam Posisi Fetus dalam Kandungan

a. Posisi Anterior

Ini adalah posisi janin terbaik untuk melahirkan. Kepalanya dibawah, wajahnya menghadap punggung ibu. Dagu bayi menempel di dadanya dan kepala bayi siap untu masuk pelvis. Adapun posisi janin anterior seperti pada gambar berikut:



Gambar 6.1: Posisi Janin Anterior

b. Posisi Janin Posterior

Posisi bayi dalam kandungan ini dikenal juga dengan *back to back position*. Kepala dan wajah bayi menghadap perut ibu, dan punggungnya mengarah ke bawah. Posisi bayi ini akan menyulitkan bayi untuk mendorong kepalanya keluar, sehingga proses persalinanpun sedikit terhambat. Proses persalinan menjadi lebih lambat dan lebih lama, dibandingkan saat bayi berada pada posisi anterior. Selain itu juga dapat menyebabkan sakit punggung. Posisi bayi ini dapat terjadi apabila ibu duduk atau berbaring terlalu lama.

Adapun posisi janin posterior seperti pada gambar berikut:



Gambar 6.2: Posisi Janin Posterior

c. Posisi Janin Melintang

Posisi dalam kandungan ini terjadi saat bayi berbaring secara horizontal di dalam rahim ibu. Seperti namanya, janin membentuk posisi yang melintang dengan kepala dan kaki terdapat pada sisi kanan dan kiri perut ibu. Bila posisi bayi ini terjadi jauh sebelum hari persalinan, maka tidak menjadi masalah karena masih ada kemungkinan bayi dapat bergerak menuju posisi normal. Namun, bila janin masih dalam posisi melintang menjelang persalinan, kemungkinan besar diperlukan operasi caesar untuk persalinan.

Melahirkan bayi dengan posisi melintang dengan cara normal akan menyebabkan robeknya jalan lahir dan membahayakan, baik nyawa ibu maupun janin. Namun, posisi ini tidak banyak ditemukan pada masa kehamilan. Namun jika bayi tetap pada posisi ini pada hari menjelang kelahiran, operasi caesar merupakan satu-satunya cara yang bisa ibu pilih karena jika tidak melalui operasi caesar ditakutkan bayi akan terlilit tali pusat.

Adapun posisi janin melintang seperti pada gambar berikut :



Gambar 6.3: Posisi Janin Melintang

d. Posisi Janin Sungsang

Adalah yaitu kepala bayi terdapat di atas dan kaki di bawah. Posisi janin seperti ini sangat menyulitkan ibu untuk melahirkan secara normal. Posisi bayi ini juga jarang ditemukan namun bisa terjadi pada ibu. Meski banyak kasus dimana bayi dengan posisi ini lahir secara sehat, tidak jarang juga cacat lahir menjadi resiko dari posisi persalinan ini. Resiko lainnya, bayi dapat terlilit tali pusat ketika lahir. Karena itu, kebanyakan kasus bayi dengan posisi sungsang selalu dilahirkan melalui operasi caesar.

1) Footling Breech

Posisi bayi sungsang dalam kandungan digambarkan dengan satu

kaki ke bawah, satu kaki ke atas, atau di dekat jalan lahir. Sungsang jenis *footdink breech* juga disebut sungsang tidak sempurna.

2) Frank Breech

Sungsang jenis *frank breech* digambarkan dengan posisi bokong janin berada di bagian bawah, dan tungkainya berada di atas hampir menyentuh telinga. Nah, *frank breech* adalah jenis posisi sungsang yang paling umum terjadi pada bumil.

3) Complete Breech

Terakhir adalah jenis *complete breech* atau sungsang sempurna. Posisi ini digambarkan dengan posisi bokong bayi yang berada di atas mulut rahim. Sementara itu, kedua kakinya terlipat dengan sempurna. Adapun posisi Sungsang seperti pada gambar berikut :



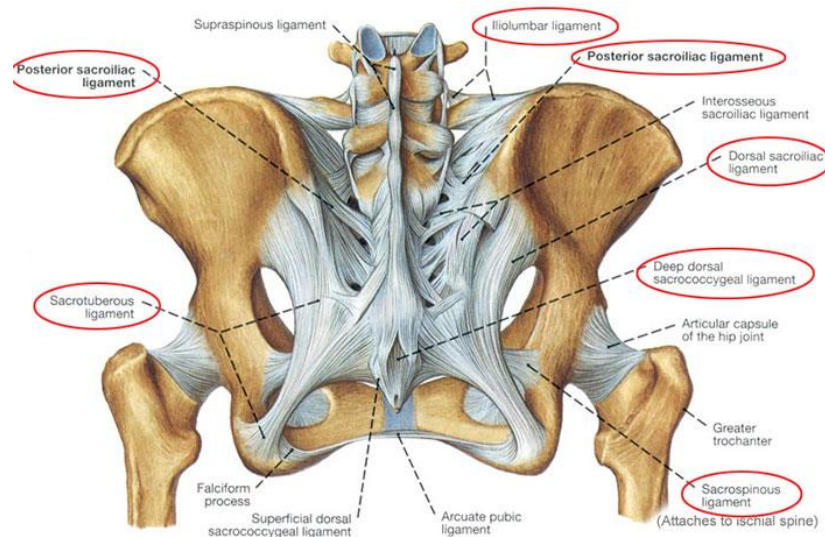
Gambar 6.4: Posisi Janin Sungsang

2. Cara Mengubah Posisi Bayi dalam Kandungan

a. Bergerak (gravitasi) / Berjalan

Gravitasi akan berguna dengan baik saat kita bergerak atau dilakukan dengan Gerakan. Bergerak seperti berjalan akan membuat gaya gravitasi bekerja dengan baik sehingga membuat janin berada di posisi optimal (turun). Berjalan yang di maksud disini bukan jalan pagi yang pelan pelan, tetapi jalan cepat.

Berjalan cepat membuat semua otot psoas dan ligament di area panggul akan semakin terlatih. Otot psoas akan lebih kuat tapi lentur dan fleksibel, penurunan kepala akan terjadi lebih baik karena otot panggul dan tulang belakang menjadi lebih selaras. Frekuensi : minimal 5 kali dalam seminggu. Durasi : lakukan secara bertahap mulai dari 500 m sampai 4-5 km. (sesuai kemampuan tubuh Anda)



Gambar 6.5: Anatomi Panggul

Jika mengalami SPD (Symphysis Pubic Dysfunction) atau rasa sakit di area syphysis, gunakan pregnancy belt, atau menunggu sampai sakit nya berkurang atau hilang, baru mulai berjalan dengan ritme yang lebih lambat. Jika memiliki perut gantung, gunakan pregnancy belt juga senyamannya (jangan terlalu kencang)

b. Prenatal Yoga

Yoga merupakan bentuk seni ilmu pengetahuan kuno dan perawatan kesehatan tertua yang berasal dari India. Prenatal yoga merupakan senam yoga dasar yang selanjutnya akan dikembangkan dan disesuaikan prosedurnya dengan kondisi ibu hamil. Prenatal yoga merupakan olah raga yang berguna dalam menstabilkan masalah fisik, pikiran, dan mental yang sangat membantu ibu hamil dalam melenturkan persendian dan merilekskan pikiran terutama pada ibu hamil. Gerakan pada prenatal yoga juga dibuat dengan tempo yang lebih lambat agar dapat menyesuaikan dengan kapasitas ruang gerak ibu hamil (Wagiyo& Putrono,2016 dalam Wulandari et al., 2020).

Yoga prenatal (yoga kehamilan) adalah versi perbaikan dari yoga klasik, disesuaikan dengan kondisi fisik ibu hamil, dan dilakukan dengan intensitas yang lebih ringan sehingga lebih aman dilakukan oleh ibu hamil. Trimester pertama adalah masa kehamilan yang paling rentan, karena embrio tidak stabil dan risiko keguguran tinggi (Muria, 2017).

Manfaat Prenatal Yoga Sindhu dalam Muria (2017) menyebutkan terdapat beberapa manfaat jika melakukan yoga selama kehamilan, yaitu:

- 1) Dapat meningkatkan stamina dan tubuh saat hamil
- 2) Memperlancar sirkulasi darah sekaligus asupan oksigen ke janin
- 3) Mengatasi sakit punggung dan pinggang, konstipasi (sembelit), saluran urine yang lemah, sendi yang pegal dan bengkak

- 4) Melatih otot perineum agar lebih kuat sehingga dapat mempermudah proses melahirkan
- 5) Mempersiapkan mental ibu agar tidak cemas dapat menghadapi persalinan
- 6) Sebagai bentuk menjalin komunikasi antara ibu dan anak yang ada dikandungnya
- 7) Pemulihan fisik lebih cepat dan dapat mengatasi stress pascapersalinan

Prinsip Prenatal Yoga Menurut Muria (2017) terdapat beberapa prinsip dalam tindakan prenatal yoga, yaitu :

- 1) Napas dengan penuh kesadaran Napas dalam yang dilakukan secara teratur dapat menenangkan. Dengan teknik napas dalam yang benar, ibu dapat merilekskan tubuhnya sehingga dapat mengontrol tubuh dan pikirannya dengan baik
- 2) Gerakan yang lembut dan perlahan Gerakan yang lembut dapat membuat tubuh ibu lebih lentur sekaligus menjadi lebih kuat. Gerakan prenatal yoga lebih berfokus pada beberapa bagian, yaitu otot-otot panggul, pinggul, paha dan punggung.
- 3) Relaksasi dan meditasi Ketika ibu melakukan relaksasi dan meditasi, ibu dapat mengontrol tubuh dan pikirannya dalam keadaan yang tenang dan damai



Gambar 6.6: Relaksasi dan Meditasi

- 4) Ibu dan bayi Dengan prenatal yoga, ibu dan bayi yang dikandungnya dapat membentuk bonding yang kuat. Sehingga ketika ibu merasa senang dan rileks, bayi pun akan merasakan hal yang sama dengan sang ibu.
- c. Metode Rebozo Sifting (Rebozo Mantecada)

Rebozo merupakan syal atau syal tenun yang besar dan sangat Panjang yang dibuat oleh wanaita untuk wanita. Dalam budaya Aztec, tradisi yang merupakan rebozo yang di transmisikan dari ibu ke anak perempuan dan bidan ke bidan. Rebozo berarti selendang dalam Bahasa Spanyol dan merupakan selendang tradisional Meksiko.

Dalam persalinaan teknik rebozo digunakan untuk memberikan kenyamanan dan kesejahteraan bagi ibu melalui teknik yang lembut dan ritme berirama. Teknik rebozo paling populer yang dilakukan oleh bidan tradisional Meksiko yang disebut "Manteada" (mengayunkan perut dengan rebozo). Teknik ini dilakukan dengan menggoyang-goyangkan bagian abdomen dengan rebozo



Gambar 6.7 Metode Rebozo Sifting

Dilakukan pada usia kandungan kurang dari 36 minggu bisa dilakukan 5 menit per sesi per hari (pagi dan malam), untuk usia kandungan lebih dari 36 minggu bisa dilakukan 20 menit per sesi per hari.

d. Forward Leaning Inversion

gerakan *forward leaning inversion* merupakan teknik peregangan otot yang lembut dan relaks. Ketika posisi tegak kembali akan membuat ligamen menjadi relaks. Mengulangi peregangan berkali-kali untuk melepaskan ketegangan yang mungkin ada atau mengurangi kondisi asimetri pada ligamen ibu dan memungkinkan kepala bayi agar optimal dengan lebih mudah selama proses persalinan.

FLI bisa dilakukan pada kehamilan di atas 32 minggu, dilakukan selama 3x hitungan/siklus nafas dan bisa dilakukan 2x sehari.



Gambar 6.8: Gerakan Forward Leaning Inversion

Gerakan ini berpotensi untuk memberi dukungan pada ligamen untwists ke segmen bawah rahim dan leher rahim, serta sangat bermanfaat untuk ligament uterosakrum dan ligamen di area leher rahim. Ketika ibu tegak kembali maka ligamen ini akan bersantai / rileks.

Lakukan peregangan berkali-kali dapat membantu untuk melepaskan ketegangan yang mungkin ada atau mengurangi kondisi asimetri pada ligament dan memungkinkan kepala bayi agar optimal dengan lebih mudah selama persalinan. Lakukan dengan pendampingan, Gunakan sofa, atau lainnya. Yang penting SAFETY First.

Tidak boleh dilakukan lakukan jika Anda memiliki sakit maag (sedang kumat), glaucoma, hipertensi atau beresiko stroke, anemia. ketuban anda terlalu banyak (hasil usg) jika terasa sakit sekali di perut saat melakukan ini.

jangan lakukan untuk sementara. Jika ragu, coba dengan menggunakan pregnancy belt dulu dan gunakan permukaan yang stabil dan rata.

e. Sidelying Release

Teknik Side Lying Release (SLR) adalah metode peregangan statis yang dilakukan dengan posisi berbaring miring dan kaki atas menggantung ke bawah untuk sementara memperluas dan melunakkan panggul. Teknik ini bertujuan mengendurkan ligamen panggul dan otot-otot di sekitarnya, menciptakan lebih banyak ruang bagi bayi untuk bergerak turun dan berputar saat persalinan, serta mengurangi hambatan dan rasa sakit.

Gerakan ini bertujuan untuk merilekskan ketegangan otot. Dan membuka panggul lebih lebar sehingga ruang untuk bayi berputar lebih luas. Gerakan ini juga bisa dilakukan untuk mempercepat proses persalinan. Bisa dilakukan di usia kandungan di atas 32 minggu 10 menit setiap sisi ya moms.

Sidelying Release (SLR) menggunakan prinsip "stretch statis" untuk sementara, dengan sedikit membesar dan melembutkan panggul. Peregangan pada otot panggul ini mampu memperpanjang otot-otot panggul selama kurang lebih 1-4 jam.

Manfaat Sidelying Release: Memberikan mobilitas yang lebih pada panggul, Melepaskan kekejangan otot di sekitar panggul dan pinggang sehingga ibu menjadi lebih mudah untuk tidur di masa kehamilan (terutama trimester 3), dan mampu mengurangi rasa ketidaknyamanan saat kontraksi datang di masa persalinan, Meringankan rasa sakit pada kehamilan dan proses kelahiran, Membuat dan memberi ruang untuk bayi sehingga janin bisa berubah menjadi posisi yang lebih baik, Otot-otot dasar panggul menjadi lebih lembut untuk bayi sehingga memudahkannya bergerak melewatinya selama proses kelahiran.

Dapat diulang setiap 4-6 jam, karena manfaat yang bersifat sementara Bermanfaat pada saat : Persalinan Macet (kontraksinya kuat dan intens namun tidak ada penambahan pembukaan atau awalnya kontraksi terasa kuat, namun tiba tiba kontraksi berkurang bahkan berhenti, dan proses

pembukaanpun terhenti), Dirasakan nyeri punggung dan pinggul (masa kehamilan maupun saat proses persalinan), Bayi dalam posisi sungsang, lintang, miring dan posisi posterior, Kontraksi dengan tidak ada kemajuan, Kepala atau bayi asinklitik (miring).



Gambar 6.9: Teknik Sidelying Release

f. Maternal Positioning

Perilaku kebiasaan sehari-hari yang harus diperhatikan ibu hamil. Ketika ibu duduk, upayakan:

- 1) Lutut lebih rendah dari pinggul
- 2) Perut lebih rendah dari pinggul (jadi agak condong ke depan)
- 3) Biarkan perut menjadi tempat tidur gantung untuk bayi / janin.
- 4) Bila menggunakan bola pastikan pinggul tidak lebih rendah dari lutut
- 5) Duduk di tulang duduk dengan punggung tegak. Jangan duduk di tulang ekor.
- 6) Jika duduk di mobil, usahakan di ganjal bola kecil agar bisa tetap bergerak dengan dinamis.

g. Rest Smart

- 1) Tidur miring dengan posisi kaki tetap terbuka, ganjal kaki menggunakan beberapa bantal, pastikan panggul sejajar
- 2) Gunakan peanut ball untuk membantu membuka panggul

h. Relaksasi Dan Komunikasi Janin

- 1) Relaksasi dan komunikasi janin sangat penting selama masa kehamilan. Dengan melakukan dua hal ini setiap hari bisa membuat kita lebih dekat lagi dengan calon anak .
- 2) Sering beri afirmasi positif karena percayalah dia bisa mendengarkan kita sebagai ibunya.
- 3) Komunikasikan kepada bayi untuk berada di posisi yang optimal saat waktunya tiba (36 minggu).

B. Pemeriksaan dalam dan penggunaan spekulum

Pemeriksaan dalam adalah pemeriksaan ginekologi untuk menilai organ panggul, sementara spekulum adalah alat yang digunakan untuk membuka vagina agar dokter dapat melihat serviks dan dinding vagina. Teori pemeriksaan ini melibatkan observasi visual untuk mendeteksi kelainan, sedangkan penggunaan spekulum adalah cara untuk mempermudah visualisasi tersebut untuk tujuan seperti Pap smear, biopsi, atau pemasangan IUD.

Tujuan Utama: Pemeriksaan dalam bertujuan untuk mengevaluasi kesehatan sistem reproduksi wanita, termasuk vagina, serviks, rahim (uterus), dan ovarium. Macam-macam pemeriksaan dalam:

1. Pemeriksaan Dalam (*Vagina Toucher*)

Pemeriksaan dalam adalah pemeriksaan genitalia bagian dalam mulai dari vagina sampai serviks menggunakan dua jari, yang salah satu tekniknya adalah menggunakan skala ukuran jari (lebar satu jari berarti 1 cm) untuk menentukan diameter dilatasi serviks (pembukaan serviks atau portio). Pemeriksaan ini dikerjakan dengan cara memasukkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan ke vagina sesuai dengan aksis vagina dan dikerjakan secara perlahan-lahan dan sehalus mungkin. Sebelumnya telunjuk dan jari tengah yang akan digunakan untuk memeriksa dapat diolesi dengan lubrikan atau desinfektan, posisi tangan kanan dan kiri bisa terbalik tergantung kebiasaan pemeriksa.

Tangan yang ada di abdomen dimanfaatkan sepenuhnya untuk mengarahkan organ mana yang diperiksa. Perabaan dilakukan mulai dari vagina hingga fornices, serviks uteri, uterus, adneksa atau parametrium, dan keseluruhan rongga panggul. Sesudah tangan pemeriksa ditarik dari vagina, dilakukan perabaan pada daerah luar genital (vulva dan sekitarnya). Pemeriksaan harus dilakukan secara sistematis, untuk itu perabaan harus urut dan tidak boleh ada yang terlewatkan. Memasukkan tangan ke dalam jalan lahir ibu bersalin untuk memantau perkembangan proses persalinan atau lazim disebut VT (vaginal toucher atau vaginal touse atau periksa dalam dan sejenisnya) bukanlah sesuatu yang mudah. Selain perlu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, tetapi juga butuh perasaan. Karena jari pemeriksa masuk, maka jari itu tidak boleh dikeluarkan sebelum pemeriksaan dalam selesai.

Tujuan Pemeriksaan Dalam, Pemeriksaan dalam dilakukan dengan tujuan yaitu :

- a. Untuk menentukan apakah penderita benar dalam keadaan inpartu
- b. Untuk menentukan faktor janin dan panggul

- c. Menentukan ramalan persalinan
- d. Untuk menilai vagina (terutama dindingnya), apakah ada bagian yang menyempit
- e. Untuk menilai keadaan serta pembukaan serviks
- f. Untuk menilai ada atau tidaknya tumor pada jalan lahir
- g. Untuk menilai sifat flour albus dan apakah ada alat yang sakit, misalnya bartholinitis
- h. Untuk mengetahui pecah tidaknya selaput ketuban.
- i. Untuk mengetahui presentasi janin
- j. Untuk mengetahui turunnya kepala dalam panggul
- k. Untuk mengetahui penilaian besarnya kepala terhadap panggul
- l. Untuk mengetahui apakah proses persalinan telah dimulai serta kemajuan persalinan.

Indikasi dan Kontraindikasi Pemeriksaan Dalam

- a. Indikasi: Selama kehamilan, seharusnya pemeriksaan dalam dilakukan dua kali, yakni:

1) Trimester awal

Saat ibu hamil pertama kali datang ke dokter kandungan untuk memastikan kehamilan umumnya akan dilakukan pemeriksaan dalam secara keseluruhan. Jika memang ada kehamilan akan teraba adanya pembesaran rahim dan tanda hegar (terabanya antara mulut rahim dan badan rahim seolah terpisah).

Pemeriksaan di awal ini juga bertujuan untuk mengevaluasi jalan lahir apakah ada kelainan atau tidak semisal ada varises di vagina, infeksi keputihan, polip atau tumor di mulut rahim, yang bisa memengaruhi kehamilan ibu. Maka itu, pemeriksaan dalam harus dilakukan di awal kehamilan. Bila ada kelainan bisa diketahui dan ditangani segera. Setelah itu baru dilakukan pemeriksaan USG. Ada kalanya, selama tak ada keluhan, dokter akan melewatkan pemeriksaan dalam dan langsung pada pemeriksaan USG.

Hal ini akan lebih mempercepat, memudahkan pemeriksaan dan tidak menimbulkan rasa risih pada pasien.

2) Trimester akhir

Tepatnya saat kehamilan usia 36 minggu, pemeriksaan dalam dibutuhkan untuk mengevaluasi kondisi jalan lahir bila memang direncanakan persalinan normal. Jadi akan diperiksa apakah mulut rahim sudah siap dan apakah kapasitas panggul ibu cukup luas untuk dilalui bayi. Jika tak ada masalah maka per-salinan dapat ditunggu sampai usia

maksimal 42 minggu.

3) Selain di trimester awal dan akhir

Pemeriksaan dalam bisa dilakukan di trimester kedua bila memang ada indikasi. Contoh, ibu mengalami keputihan dalam jumlah banyak, yang berubah warna, berbau dan menyebabkan gatal. Atau ibu hamil mengalami perdarahan berupa bercak. Dalam kasus ini pemeriksaan dalam dilakukan untuk membantu menegakkan diagnosis serta memastikan sejauh mana masalah tadi membahayakan kehamilan ibu. Setelah itu barulah dilakukan pengobatan.

Pemeriksaan dalam juga dilakukan saat ibu bersalin, Pemeriksaan ini dilakukan pada saat memasuki kala I persalinan, saat ada gejala mulas-mulas dan ibu mengalami his secara teratur 2 kali dalam 15 menit sebagai tanda akan melahirkan. Pemeriksaan dalam ini dengan kepentingan untuk menentukan awal dan kemajuan dari persalinan. Khusus untuk memeriksa kemajuan persalinan, maka pemeriksaan dilakukan setiap 4 jam di fase laten (pembukaan mulut rahim 4 cm) dan setiap 2 jam di fase aktif (pembukaan mulut rahim 4- 10 cm). Sedangkan penilaiannya meliputi pembukaan jalan lahir, turunnya kepala janin, apakah sudah memutar atau belum dan sampai mana putaran tersebut, karena kondisi ini akan menentukan jalannya persalinan. Contoh, bila ubun-ubun kecil sudah menghadap ke depan, berarti sudah turun mencapai pembukaan lengkap (10 cm) dan bayi sudah siap untuk dilahirkan.

Jika dalam tenggang waktu 8 jam setelah pemeriksaan dalam kala I bayi belum juga lahir atau masih tetap pembukaan 3-4 cm maka perlu tambahan stimulasi (pacuan). Tentu akan diakhiri dengan segera dilahirkan atau kalau tindakan ini juga "tak mempan" berarti harus operasi sesar.

b. Kontraindikasi

Pemeriksaan dalam tidak dapat dilakukan pada beberapa kasus, seperti:

- 1) Perdarahan
- 2) Plasenta previa
- 3) Ketuban pecah dini
- 4) Persalinan preterm
- 5) Hymen intake
- 6) Infeksi vagina

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan dalam

a. Keadaan Perineum

Pada primipara perineum utuh dan elastis. Pada multipara tidak utuh, longgar dan lembek. Untuk menentukan dengan menggerakkan jari dalam vagina ke bawah dan ke samping. Dengan cara ini juga diketahui otot levator ani normal teraba elastis.

b. Sistokel Dan Rektokel

Sistokel adalah benjolan pada dinding depan vagina yg disebabkan oleh kelemahan dinding belakang kandung kemih. Rektokel adalah benjolan pada dinding belakang vagina disebabkan oleh kelemahan dinding depan rektum. Diakibatkan oleh persalinan yang berulang terutama ada robekan perineum atau bersamaan dengan prolapsus uteri.

c. Pengeluaran pervaginam

- 1) Cairan putih kekuningan akibat rarang serviks atau monilia vaginitas, cairan hijau kekuningan karena trikhomonas.
- 2) Lendir campur darah
- 3) Cairan ketuban
- 4) Darah berasal dari robekan jalan lahir, plasenta previa, solutio plasenta
- 5) Mekoneum

d. Serviks

Perlu diperhatikan pembukaan, penipisan, robekan serviks dan kekakuan serviks.

- 1) Pembukaan ditentukan & diukur dg kedua jari. Kalau pemb > 6 cm lebih muda diukur dari fornix lateralis dg cara berapa cm lebar yg masih tersisa.
- 2) Menentukan penipisan kadang sukar terutama kalau serviks menempel di bag bawah janin.
- 3) Keadaan normal serviks lembut & elastis

e. Ketuban

- 1) Tentukan ketuban utuh atau tidak, diketahui bila pemeriksaan dilakukan selagi ada his.
- 2) Bagaimana keadaan ketuban

f. Presentasi, titik penunjuk dan posisi

- 1) Presentasi kepala diketahui bila teraba bagian bulat dan keras, tulang parietal, sutura sagitalis, ubun-ubun besar atau ubun-ubun kecil.
- 2) Presentasi belakang kepala titik penunjuk (denominator) ubun-ubun kecil, presentasi bokong sakrum
- 3) Posisi kepala yg perlu ditentukan adalah letak ubun-ubun kecil terhadap panggul ibu

g. Turunnya kepala

Untuk menentukan di mana turunnya kepala diperkirakan dengan pemeriksaan luar dan dipastikan dengan pemeriksaan dalam. Untuk menentukan sampai di mana turunnya kepala ditentukan dengan bidang Hodge.

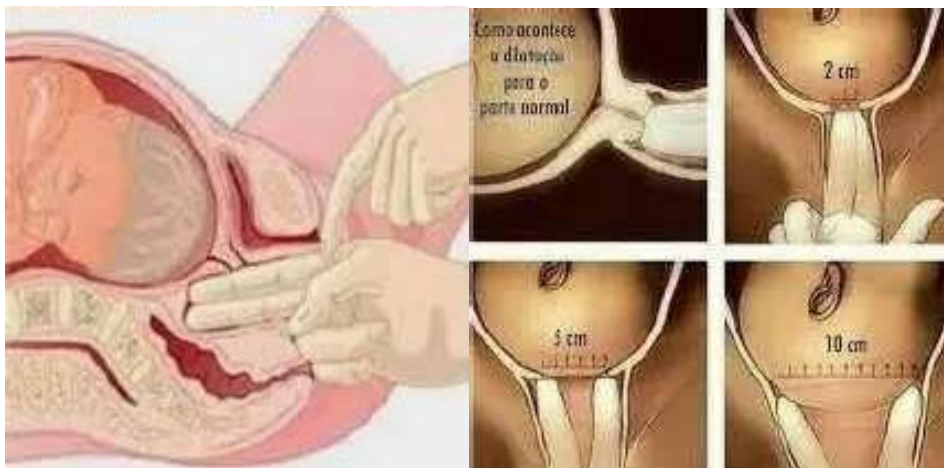
h. Pemeriksaan panggul

Perlu diperhatikan bentuk dan ukuran panggul. Untuk ukuran perlu diperhatikan :

- 1) Apakah promontorium teraba
- 2) Apakah linea inominate teraba seluruhnya, sebagian / beberapa bag
- 3) Apakah kecekungan sakrum cukup
- 4) Dinding sampng panggl lurus/miring
- 5) Spina iskhiadika runcing / tumpul
- 6) Arkus pubis sudut runcing/tumpul
- 7) Dasar panggul kaku, tebal atau elastis

i. Tumor jalan lahir

Perlu diperhatikan apakah ada tumor pada jalan lahir yang kiranya mengganggu proses persalinan. Tumor dapat bersifat neoplastik atau tumor radang. Berikut gambar pemeriksaan dalam atau *vagina toucher* untuk mengetahui pembukaan jalan lahir:



Gambar 6.10: Pemeriksaan dalam

2. Penggunaan Speculum

Spekulum merupakan suatu alat medis yang biasanya terbuat dari bahan *stainless steel* untuk membuka lubang vaginal dan mulut rahim. Alat tersebut memiliki kegunaan untuk diagnosis dan penyembuhan kelainan vagina dan rahim. Spekulum akan membuka vagina sehingga mulut rahim dan dinding vagina dapat dilihat oleh pemeriksa. Spekulum vagina terdiri atas

sekrup yang tersambung pada pengait dan pengait yang menempel pada bahan alat yang berbentuk setengah lingkaran. Speculum sejak abad 18 digunakan untuk memeriksa vagina dan juga leher rahim. Bentuknya sejak dulu tidak pernah berubah. Jenis-jenis Speculum Vagina.

- a. Speculum Sims adalah speculum yang digunakan dalam bidang kebidanan dan kandungan untuk membuka lubang vaginal depan, guna memungkinkan pemeriksa melihat bagian vaginal belakang dan mulut rahim. Banyak digunakan untuk pemeriksaan kanker serviks, pap smear, pemeriksaan kandungan dan vaginal.



Gambar 6.11: Spekulum Sim

- b. Speculum Graves (Cocor Bebek)

Merupakan alat bantu pembuka vulva pada pemeriksaan kebidanan, karena bentuknya yang mirip cocor bebek sehingga disebut speculum cocor bebek. Speculum cocor bebek berfungsi untuk membuka vaginal atau serviks uteri (leher rahim), sebagai alat bantu untuk mengetahui perobekan pada serviks uteri dan untuk memudahkan pengambilan lendir pada pemeriksaan kanker serviks.



Gambar 6.12: speculum graves (cocor bebek)

- c. Cara Pemasangan Speculum

- 1) Cara pemasangan speculum sims

Tangan kiri pemeriksa menyibakkan labium majus dan tangan

kanan memegang daun spekulum yang bawah. Daun spekulum yang bawah dimasukkan ke dalam vagina secara perlahan-lahan dalam posisi miring. Setelah daun spekulum mencapai 2/3 panjang vagina, daun spekulum diputar 90 derajat ke bawah, dan daun spekulum dimasukkan sepenuhnya hingga mencapai forniks posterior. Selanjutnya, tangan kiri pemeriksa memegang daun spekulum bawah yang sudah terpasang, sedangkan tangan kanan memegang daun spekulum atas.

Daun spekulum atas dimasukkan ke vagina secara mendatar, hingga mencapai forniks anterior. Jika melakukan tindakan, maka pembantu diminta memegang daun spekulum atas, dan tangan kiri pemeriksa memegang daun spekulum yang bawah. Pemasangan dianggap sudah benar jika serviks uteri bisa terlihat dengan jelas. Apabila visualisasi serviks uteri dan fornices vagina terhalang oleh akumulasi *discharge*, maka vagina dibersihkan dengan larutan desinfektan atau salin.

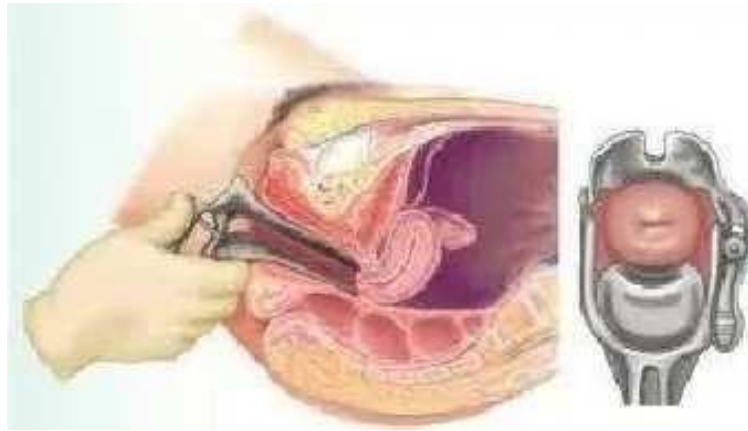


Gambar 6.13: Pemasangan Spekulum Sim

2) Cara Pemasangan Spekulum Graves (Cocor Bebek)

Labia majus disibakkan ke kanan kiri dengan jari telunjuk dan ibu jari tangan kiri. Tangan kanan memegang spekulum graves yang sudah disterilkan secara miring, sedemikian rupa sehingga daun spekulum pada posisi kirikanan. Apabila akan mengganti sediaan sitologis, maka spekulum tidak perlu dilumuri dengan lubrikan atau dibasahi dengan desinfektan. Spekulum dimasukkan ke vagina secara halus dan perlahan, dalam kedudukan kedua daun spekulum tertutup. Perhatikan arah spekulum yang harus sejajar dengan sumbu panjang vagina, kira-kira 2/3 daun spekulum masuk ke dalam vagina, pegangan spekulum diputar secara perlahan-lahan 90 derajat hingga sendok spekulum pada posisi atas bawah, dan secara perlahan-lahan

daun spekulum dibuka. Setelah bisa memvisualisasi serviks, maka daun spekulum dimasukkan sepenuhnya ke vagina, sehingga daun spekulum mencapai forniks anterior dan posterior.



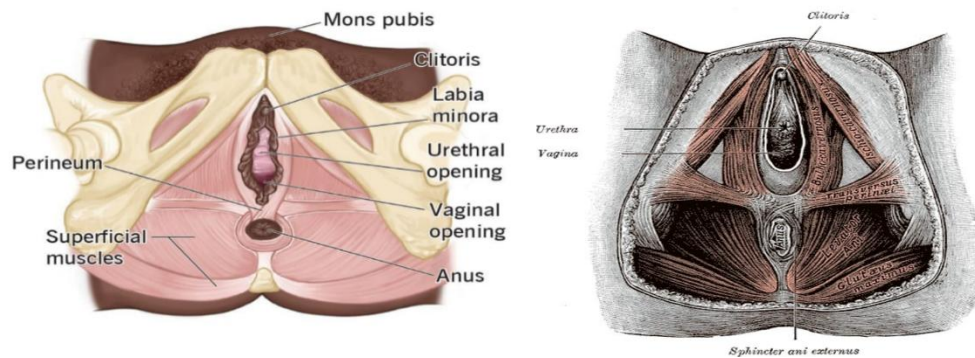
Gambar 6.14: Pemasangan Spekulum Graves (Cocor Bebek)

C. Perbaikan Perinium

Perineum adalah area antara hymen/vagina dan anus yang menahan beban dan ikut berperan pada kontinensia. Trauma perineal dapat berupa robekan spontan atau karena episiotomi. Perbaikan perineum yang dilakukan secara benar oleh tenaga terlatih mengurangi komplikasi akut dan kronik (review klinis, 2023).

Perineum adalah otot, kulit, dan jaringan yang ada diantara kelamin dan anus. Jaringan yang utama menopang perineum adalah diafragma pelvis dan urogenitale. Diafragma pelvis terdiri dari musculus levator ani dan musculus koksigeus di bagian posterior serta selubung fasia dari otot-otot ini. Musculus levator ani membentuk sabuk otot lebar yang berorigo dari permukaan posterior ramus pubis superior, dari permukaan dalam spina iskiadika, dan dari fasia obturatoria yang terletak di antara keduanya.

Anatomi singkat (relevan untuk perbaikan) Perineal body (titik sentral perineum) dan otot-otot yang berhubungan (bulbospongiosus, transversus perinei superficial, eksternal anal sphincter) sangat penting untuk menilai dan memperbaiki robekan. Identifikasi lapisan (vagina mukosa, otot perineal, kulit, dan jika ada—kompleks sfingter ani) menentukan teknik jahitan.



Gambar 6.15: Anatomi Perinium

Rupture adalah luka pada perineum yang diakibatkan oleh rusaknya jaringan secara alamiah karena proses desakan kepala janin atau bahu pada saat persalinan. Bentuk rupture biasanya tidak teratur sehingga jaringan yang robek sulit dilakukan penjahitan. Perineum merupakan bagian permukaan dari pintu bawah panggul yang terletak dari vulva dan anus, dengan panjang kira-kira 4 cm. Perineum terdiri dari otot dan fascia urogenitalis serta diafragma pelvis. Perineum merupakan dasar pelvis dan struktur sekitarnya yang menempati pintu bawah panggul, disebelah anterior dibatasi oleh tube iskiadikum, disebelah posterior dibatasi oleh tulang koksigeou.(Saifudin, 2018)

Rupture perineum adalah robeknya perineum pada saat bayi lahir secara spontan maupun dengan alat atau tindakan, terjadi hampir pada semua persalinan pertama dan tidak jarang juga pada persalinan berikutnya, tempat yang paling sering mengalami perlukaan akibat persalinan adalah perineum.(Shinta, 2019).

Rupture perineum merupakan salah satu dari komplikasi persalinan kala II yang dapat menyebabkan disfungsi organ reproduksi wanita yaitu perdarahan dan laserasi. Rupture perineum adanya perlukaan jalan lahir yang terjadi pada saat persalinan spontan atau menggunakan alat. Robekan jalan lahir sering terjadi pada primipara maupun multipara karena pada saat proses persalinan tidak mendapatkan tekanan yang kuat sehingga menyebabkan robekan perineum.(Shinta, 2019)

Perineum lunak dan elastis serta cukup lebar, umumnya tidak memberikan kesukaran dalam kelahiran kepala janin. Jika terjadi robekan hanya sampai rupture perineum tingkat I atau II, perineum kaku dan tidak elastis akan menghambat persalinan kala II dan dapat meningkatkan risiko terhadap janin dan dapat menyebabkan rupture perineum yang luas atau tingkat III. Hal ini sering ditemui pada primipara yaitu primigravida berumur 35 tahun, dan perineum sempit akan mudah terjadi robekan-robekan di jalan lahir.(Wiknjosastro H, 2018)

Jenis rupture perineum Menurut Fatimah dan Lestari (2019), jenis rupture perineum setelah melahirkan, yaitu:

1. Ruptur perineum spontan Ruptur adalah luka pada perineum yang disebabkan rusaknya jaringan secara alami karena adanya desakan kepala janin atau bahu ketika proses persalinan. Biasanya bentuk luka tidak teratur dan penjahitan sulit dilakukan. Luka yang tidak dirawat dengan baik dapat menyebabkan terjadinya infeksi
2. Ruptur perineum yang disengaja (Episiotomi) Episiotomi ialah sayatan yang disengaja dibuat pada perineum berfungsi untuk memperbesar jalan lahir yang dilakukan tepat sebelum keluarnya bayi. Episiotomi merupakan tindakan yang sengajadilakukan saat vagina dalam keadaan meregang. Episiotomi dilakukan jika perineum diperkirakan akan robek teregang oleh kepala janin.
Menurut Wiknjosastro (2018) rupture perineum dibagi menjadi empat tingkat, yaitu:
 - a. Derajat I: robekan hanya terjadi pada selaput lendir vaginadengan atau tanpa mengenai kulit perineum sedikit. Rupture derajat satu biasanya tidak memerlukan penjahitan.
 - b. Derajat II: robekan yang terjadi lebih dalam yaitu selain mengenai selaput lendir vagina juga mengenai muskulus perinei transversalis, tapi tidak mengenai sfingter ani.
 - c. Derajat III: robekan yang terjadi mengenai seluruh perineum sampai mengenai otot-otot sfingter ani.
 - d. Derajat IV: robekan mengenai perineum sampai dengan otot sfingter ani dan mukosa rektum.

Penyebab dan Faktor Risiko Ruptur Perineum, Ruptur perineum terjadi ketika lubang vagina tidak dapat meregang cukup lebar untuk mengeluarkan seluruh tubuh bayi. Kondisi ini lebih berisiko terjadi pada ibu yang:

1. Menjalani persalinan melalui vagina untuk pertama kali
2. Melahirkan bayi dengan posisi sungsang (kaki bayi keluar terlebih dahulu)
3. Melahirkan dengan bantuan alat khusus, seperti vakum atau forceps
4. Melahirkan bayi dengan berat di atas rata-rata (lebih dari 4 kg)
5. Melahirkan bayi yang pundaknya tersangkut pada tulang panggul ibu
6. Menjalani proses persalinan terlalu lama
7. Pernah mengalami ruptur perineum pada persalinan sebelumnya

Tanda dan gejala rupture perineum Menurut Nungroho (2017), bila perdarahan masih berlangsung meski kontraksi uterus baik dan tidak didapatkan adanya retensio plasenta maupun adanya sisa plasenta, kemungkinan telah terjadi rupture perineum. Tanda dan gejala rupture perineum diantaranya adalah (Triutomo, 2017):

1. Perdarahan segera

2. Darah segar yang mengalir setelah bayi lahir
3. Uterus berkontraksi dengan baik
4. Plasenta normal
5. Pucat
6. Lemah g. Pasien dalam keadaan menggigil

Penanganan rupture perineum Endriani (2016), mengemukakan penanganan rupture perineum di antaranya dapat dilakukan dengan cara melakukan penjahitan luka lapis demi lapis, dan memperhatikan jangan sampai terjadi ruang kosong terbuka kearah vagina yang biasanya dapat dimasuki bekuan-bekuan darah yang akan menyebabkan tidak baiknya penyembuhan luka. Selain itu dapat dilakukan dengan cara memberikan antibiotik yang cukup. Prinsip yang harus di perhatikan dalam menangani ruptur perineum yaitu : (Hera et al., 2019)

Bila seorang ibu bersalin mengalami perdarahan setelah anak lahir, segera memeriksa perdarahan tersebut berasal dari retensio plasenta atau plasenta lahir tidak lengkap. b. Bila plasenta telah lahir lengkap dan kontraksi uterus baik, dapat di pastikan bahwa perdarahan tersebut berasal dari perlukaan pada jalan lahir, selanjutnya dilakukan penjahitan, prinsip melakukan jahitan pada robekan perineum:

1. Reparasi mula-mula dari titik pangkal robekan sebelahdalam/proksimal kearah luar/distal. jahitan dilakukan lapis demi lapis,dari lapis dalam kemudian lapisan luar.
2. Ruptur perineum derajat I Tidak perlu di jahit jika tidak ada perdarahan dan aposisi luka baik, namun jika terjadi perdarahan segera dijahit dengan menggunakan benang catgut secara jelujur atau secara angka delapan.
3. Ruptur perineum derajat II Untuk laserasi derajat I atau II jika di temukan robekan tidak rata atau bergerigi harus di ratakan terlebih dahulu sebelum dilakukan penjahitan. Pertama otot di jahit dengan cutgut secara terputus- putus atau jelujur. Penjahitan mukosa vagina di mulai dari puncak robekan. Kulit perineum di jahit dengan benang catgut secara jelujur.
4. Ruptur perineum derajat III Penjahitan yang pertama pada dinding depan rektum yang robek, kemudian fasia perirektal dan fasia septum rektovaginal di jahit dengan catgut kromik sehingga bertemu kembali.
5. Ruptur perineum derajat IV Ujung-ujung otot sfingter ani yang terpisah karena robekan di klem dengan klem pean lurus, kemudian dijahit antara 2-3 jahitan catgut kromik sehingga bertemu kembali. Selanjutnya robekan di jahit lapis demi lapis seperti menjahit robekan perineum tingkat

D. Latihan Soal

1. Ny. Stela umur 31 tahun baru saja melahirkan anak pertama tanggal 1 juni 2022 jam 12.00 WIB. Jenis kelamin perempuan, bera badan 3800 gr keadaan lahir langsung menangis kuat. Plasenta dan selaput ketuban lahir lengkap dan sudah dilakukan massage. Ny. Stella mengalami robekan jalan lahir sampai dengan otot perineum. Diagnosa pada kasus tersebut adalah kala IV dengan Laserasi?
 - a. Drajad I
 - b. Drajad II
 - c. Drajad III
 - d. Drajad IV
 - e. Drajad V
2. Ny. S usia 28 tahun usia kehamilan 30 minggu, datang ke bidan dari hasil pemeriksaan didapatkan posisi janin letak sungsang. Saran yang tepat untuk Ny. S untuk mengoptimalkan posisi janin dan memungkinkan kepala bayi agar optimal dengan lebih mudah selama proses persalinan. sebelum persalinan perlu dilkukan tindakan yang paling tepat adalah....
 - a. Yoga
 - b. Senam Hamil
 - c. Power Walk
 - d. Fordward Learning Inversion
 - e. Teknik relaksasi
3. Seorang Perempuan usia 29 tahun datang ke bidan mengatakan sering keputihan, berbau, dan gatal. Bidan akan melakukan pemeriksaan dalam untuk melihat porsio . alat apakah yang tepat untuk digunakan?
 - a. Gunting Plaster
 - b. Spekulum
 - c. Sonde uterus
 - d. Mikroskop
 - e. Kapas

Kunci Jawaban:

1. Kunci Jawaban: B
2. Kunci Jawaban: D
3. Kunci Jawaban: B

Tugas

Lakukan Observasi optimalisasi posisi fetus dan penggunaan spekulum dan perbaikan perinium, kemudian refleksikan dengan menggunakan salah satu model refleksi yang mudah menurut saudara!

E. Glosarium

Anterior	: istilah anatomi dan medis yang berarti "bagian depan" atau "permukaan depan" suatu struktur atau tubuh.
Fetus	: keturunan yang belum lahir dari hewan vivipar, seperti manusia, yang merupakan tahap perkembangan setelah menjadi embrio dan sebelum lahir, dimulai dari sekitar minggu ke-9 kehamilan hingga kelahiran.
Ketuban	: air yang keluar dari rahim, mendahului bayi yang akan lahir; tuban-tuban.
Melintang	: terletak menurut lintang suatu bidang; malang, atau bisa juga berarti kiasan untuk menghalangi, seperti dalam ungkapan "aral melintang" yang berarti rintangan atau hambatan.
	OFP : Optimal Fetal Positioning
Perinium	: daerah antara lubang dubur dan bagian alat kelamin (kemaluan) sebelah luar; kerampang.
Persalinan	: proses melahirkan anak atau pengeluaran janin/bayi dari dalam kandungan
Posterior	: istilah teknis yang berarti "belakang" atau "di bagian belakang" tubuh atau objek, dan merupakan kebalikan dari anterior (depan).
Reparasi	: perbaikan atas kerusakan atau perbaikan
Sungsang	: posisi terbalik atau kebalikan dari seharusnya, seperti yang di atas menjadi di bawah, yang di depan menjadi di belakang, atau kepala di bawah dan kaki di atas (dalam konteks kelahiran bayi).
Vagina	: saluran antara leher rahim dan alat kelamin perempuan; liang.

F. Daftar Pustaka

Agiwahyunto Faik, Indriati. *Penyebab Perbedaan Tarif INA- CBGs Pada Kasus Sectio Caesarean Pada Indikasi Malpresentase di RSUD Tegurejo Kota Semarang Tahun 2018*. Visikes: Vol. 19 No. 1. April 2020.

Aprilia Wahyu. *Perkembangan Pada Masa Pranatal dan Kelahiran*. Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini: Vol.4 No. 1. Mei, 2020.

Kemenkes RI. *Pedoman Spesifikasi Alat Kesehatan di Puskesmas*. Jakarta, 2018.

Medical Education Unit. *Buku Blok Keterampilan Medik Dasar 2 Fungsi Normal Reproduksi dan Urinari*. Banjarbaru, 2018.

No.1. Juni, 2021.

Nurasih, Endang Nurochim. *Optimalisasi Posisi Janin Melalui Prenatal Yoga Terhadap Output Persalinan di Puskesmas Wilayah Kota Cirebon*. Jurnal Ilmiah : Vol. 8 No. 3. Cirebon, 2020.

Nusratuddin, Nugrahadkk. *Manual Clinical Skill Lab Pemeriksaan Ginekologi*. Makassar, 2019.

Putri selly, Widya Maya Ningrum. *Gambaran Penyebab Bayi Lahir Mati (Stillbirth) Pada Proses Persalinan*. Midwifery Journal Of Galuh University: Vol. 1 No. 1. Mei, 2019.

Rudiyanti Novita, Nurlaila. *Efek Prenatal Yoga Dalam Merubah Presentase Janin*. Jurnal Kesehatan Metro Sai Wawai: Vol.14

Tahir Mardiah, Retno. *Buku Panduan Keterampilan Pemeriksaan Obstetri*. Universitas Hasanuddin. Makassar, 2017.

BAB 7

PEMERIKSAAN BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK

Tujuan Intruksional Umum:

Mahasiswa mamapu memahami, menerapkan dan melakukan evaluasi pemeriksaan fisik pada pasien berdasarkan *evidencebased* yang ada

Tujuan Instruksiobal Khusus:

- Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir
- Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tanda-tanda vital bayi baru lahir.
- Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan penilaian antropometri dan fisik bayi baru lahir dan anak-anak.

Capaian Pembelajaran:

Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan pemeriksaan fisik bayi baru lahir, tanda-tanda vital bayi, serta pemeriksaan antropometri dan fisik bayi dan anak setelah mempelajari konsep-konsep utama dalam bab ini.v

Pendahuluan:

Masa bayi baru lahir hingga anak merupakan fase kritis yang menentukan kualitas kesehatan di masa depan. Pemeriksaan fisik bayi baru lahir adalah langkah penting dalam deteksi dini kelainan, pemantauan pertumbuhan, dan memastikan adaptasi fisiologis bayi berjalan normal setelah lahir.

Indikator penting termasuk suhu tubuh, detak jantung, dan laju pernapasan dapat dipantau selain pemeriksaan fisik untuk memberikan informasi penting tentang kesehatan organ-organ penting bayi baru lahir atau anak. Perubahan tanda vital dapat mengindikasikan masalah medis yang memerlukan perawatan segera. Antropometri, yang mengukur berat badan, panjang badan, dan lingkar kepala, merupakan metode sederhana namun sangat membantu untuk memantau perkembangan bayi atau anak. Pengukuran antropometri yang sering dilakukan membantu kita menentukan apakah perkembangan anak berada dalam rentang normal dan untuk mendeteksi kelainan pertumbuhan atau masalah pola makan.

Terdapat tiga subtopik dalam bab ini. Subtopik pertama membahas pemeriksaan fisik bayi baru lahir, meliputi pendahuluan, metode pemeriksaan fisik, dan deteksi kelainan. Subtopik kedua membahas prinsip, metode pengukuran, dan interpretasi hasil terkait tanda-tanda vital bayi. Subtopik ketiga membahas prinsip, metode pengukuran, dan interpretasi hasil terkait pemeriksaan fisik dan antropometri pada bayi baru lahir dan anak.

Kami berharap mahasiswa kedokteran, tenaga kesehatan, dan siapa pun yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang kesehatan bayi baru lahir dan anak akan merasakan manfaat buku teks ini. Buku ini menawarkan referensi lengkap tentang pemeriksaan fisik bayi baru lahir, tanda-tanda vital, dan antropometri anak dan bayi.

Uraian Materi

Melalui mata kuliah ini, mahasiswa berkesempatan untuk memahami dasar-dasar teoretis pemeriksaan bayi baru lahir, bayi, dan anak. Materi bab ini mencakup informasi tentang pemeriksaan fisik saat lahir, tanda-tanda vital bayi, serta pemeriksaan antropometri dan fisik bayi dan anak.

A. Pemeriksaan Fisik Bayi Baru Lahir (BBL)

1. Pengertian

Bayi dengan berat antara 2.500 dan 4.000 gram dan lahir antara minggu ke-37 dan ke-42 kehamilan dianggap normal. Bayi yang lahir sungsang dan melalui jalan lahir alami tanpa menggunakan alat bantu juga dianggap normal. (Solehah et al., 2021).

Inspeksi dan observasi digunakan untuk memeriksa kondisi fisik dan perkembangan bayi baru lahir. Kelima indra digunakan dalam prosedur ini, baik secara objektif maupun subjektif, untuk mengumpulkan informasi detail tentang kesehatan bayi. (Marbun, Sahyuni Sari. 2017)

Pemeriksaan fisik bayi baru lahir (BBL) dilakukan untuk menemukan masalah yang mungkin terkait dengan kehamilan, persalinan, atau kelahiran, serta anomali yang perlu segera ditangani. Ada dua tahap dalam pemeriksaan ini. Skor APGAR, yang memperhitungkan penampilan bayi (warna kulit), detak jantung, ekspresi wajah (reaksi terhadap stimulasi), aktivitas (tonus otot), dan upaya pernapasan, digunakan untuk mengevaluasi kemampuan bayi dalam menyesuaikan diri dari kehidupan intrauterin ke dunia luar pada tahap pertama, yang dilakukan segera setelah lahir. Untuk memastikan bayi sehat dan bebas dari anomali, tahap kedua melibatkan penilaian kesehatan menyeluruh (Saputra, Lyndon. 2014)

Tujuan pemeriksaan fisik bayi baru lahir adalah untuk menentukan kondisi kesehatan bayi saat ini, menemukan masalah apa pun, mendapatkan informasi dasar untuk rencana perawatan, menemukan dan mengidentifikasi anomali yang perlu segera diobati, dan mengumpulkan informasi yang tidak bias untuk mendukung riwayat medis klien.

Pemeriksaan BBL memiliki beberapa tujuan penting, antara lain:

a. Menilai Kondisi Bayi

Letakkan bayi baru lahir di atas handuk yang telah disiapkan, bersih, dan kering di perut bagian bawah ibu sesegera mungkin. Kemudian, lakukan evaluasi awal berikut:

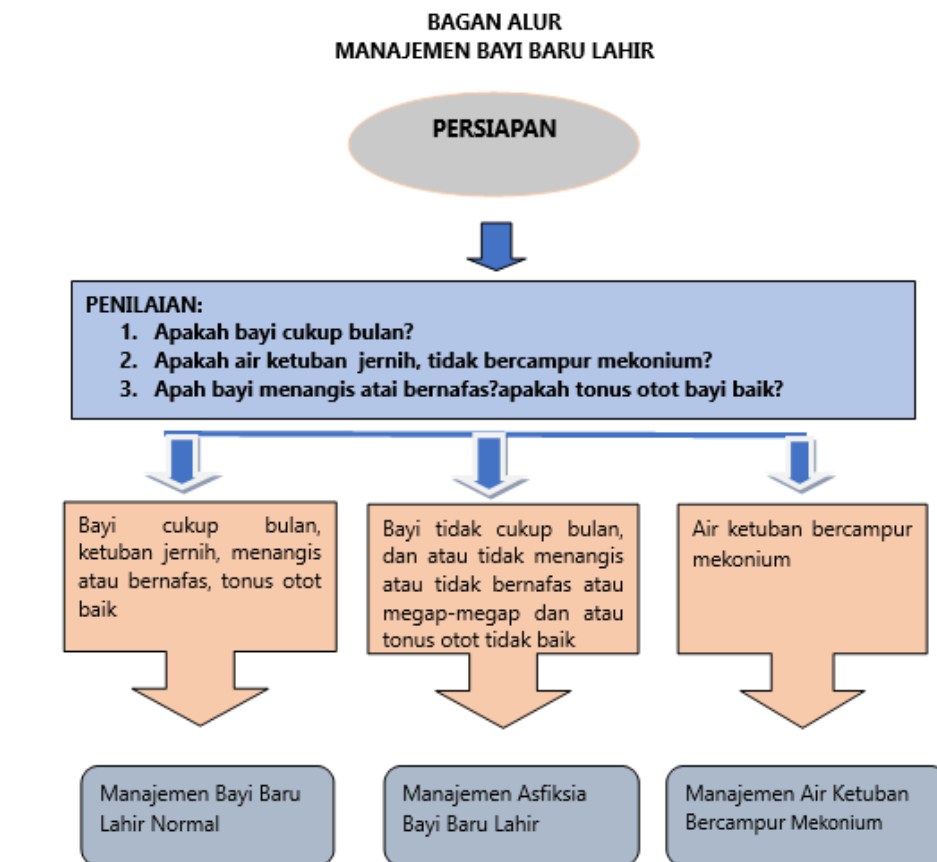
1) Keadaan Umum, yang meliputi:

- a) Pemeriksaan pernapasan antara lain,
 - Apakah bayi merintih?
 - Hitung napas: Apakah 40-60 per menit, bila tidak ulangi kembali
 - Apakah terdapat retraksi dinding dada bawah?
- b) Verifikasi gerakan: apakah tonusnya seimbang dan tepat? Lakukan prosedur resusitasi jika bayi lahir prematur, ketuban mengandung mekonium, bayi tidak menangis, tidak bernapas, tidak megap-megap, atau tonus ototnya buruk.
- 2) Melihat warna kulit.
- 3) Meraba kehangatan: bila teraba dingin atau terlalu panas lakukan pengukuran suhu.
- 4) Melihat adanya hipersalivasi dan/atau muntah.
- 5) Melihat adanya kelainan bawaan.
- 6) Melihat kepala: adakah bengkak atau memar?
- 7) Melihat abdomen: apakah pucat atau perdarahan pada tali pusat
- 8) Memeriksa adanya pengeluaran mekonium dan air seni
- 9) Menimbang bayi
- 10) Menilai cara menyusui

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan fisik bayi baru lahir:

- a. Kondisi bayi saat pemeriksaan
 - Bayi diperiksa dalam keadaan tanpa pakaian agar seluruh tubuh dapat diamati.
 - Perlu diperhatikan risiko hipotermia; oleh karena itu pemeriksaan tidak boleh dilakukan terlalu lama, kecuali jika bayi berada di bawah pemanas.
- b. Prioritas pemeriksaan
 - Pemeriksaan dilakukan berdasarkan prioritas agar lebih efisien dan efektif, terutama saat bayi masih dalam keadaan tenang.
- c. Lingkungan pemeriksaan
 - Suhu ruangan harus hangat dan nyaman, dengan pencahayaan yang cukup.
 - Lingkungan tenang untuk meminimalkan stres pada bayi.
- d. Lingkungan pemeriksa/tenaga kesehatan
 - Sebelum dan sesudah pemeriksaan, tenaga kesehatan wajib mencuci tangan.
 - Jika diperlukan, mereka wajib mengenakan sarung tangan bersih.
 - Pastikan peralatan pemeriksaan steril dan aman digunakan.
- e. Pendekatan terhadap bayi

- Lakukan pemeriksaan secara lembut dan perlahan untuk menghindari ketidaknyamanan.
 - Usahakan pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh tetapi tetap cepat, sesuai kondisi bayi.
- f. Partisipasi orang tua
- Libatkan orang tua dalam proses pemeriksaan agar mereka memahami kondisi bayi.
 - Jelaskan hasil pemeriksaan secara singkat dan komunikatif (Gustina, Irwanti. 2022)



Tabel 7.1: Bagan Alur Manajemen Bayi Baru Lahir

g. Deteksi Kondisi Bayi Baru Lahir

Untuk melindungi mereka dari infeksi yang berpotensi berbahaya dan menjaga kesehatan mereka secara keseluruhan, bayi baru lahir harus diskruining. Skrining memungkinkan deteksi dini dan pengobatan masalah kesehatan yang berpotensi fatal sebelum gejala muncul.

Pemeriksaan fisik digunakan untuk skrining pertama, yang meliputi penentuan jenis kelamin individu, pengukuran tinggi dan berat badan,

evaluasi kulit, dan pemeriksaan mata, telinga, mulut, dan alat kelamin. Agar orang tua dapat memahami kondisi awal anak mereka, sebaiknya tes ini dilakukan dengan didampingi oleh mereka.

Sejumlah tes lain akan dilakukan saat bayi berusia 48 jam untuk mengidentifikasi potensi masalah medis, termasuk:

1) Pemeriksaan Fungsi Tiroid (*Thyroid Stimulating Hormone/TSH*)

Sampel darah diambil dari tumit bayi untuk melakukan evaluasi. Karena kekurangan hormon tiroid dapat mengganggu perkembangan fisik dan mental bayi, diagnosis dini kelainan tiroid sangat penting. Terapi dapat dimulai segera sebelum bayi berusia satu bulan jika masalah terdeteksi.

2) Pemeriksaan Fungsi *Enzim Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase* (G6PD)

Bayi keturunan Asia, terutama yang berasal dari Asia Timur, lebih mungkin mengalami defisiensi enzim G6PD. Sel darah merah dapat lebih mudah pecah akibat gangguan ini, sehingga meningkatkan risiko anemia dan penyakit kuning pada bayi. Untuk memungkinkan tindakan pencegahan yang cepat, pemeriksaan dilakukan sebagai tindakan deteksi dini.

3) Pemeriksaan Kelainan Jantung Bawaan

Dengan mengukur saturasi oksigen tangan atau jari kanan bayi, kelainan jantung bawaan dapat diidentifikasi. Ketika kadar oksigen turun di bawah 90%, pemeriksaan lebih lanjut dengan ekokardiografi diperlukan untuk memastikan diagnosis kelainan struktural jantung.

h. Memberikan Dasar Asuhan

Dalam asuhan bayi baru lahir dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Jagalah agar bayi tetap hangat selama satu jam pertama dengan menjaga kontak kulit ke kulit.
- 2) Jika bayi menunjukkan tanda-tanda siap, dorong ibu untuk mulai menyusui.
- 3) Hindari memberikan makanan apa pun, termasuk dot, tepat sebelum menyusui. Selain itu, susu formula, air gula, dan air putih tidak disarankan.

i. Memantau Tumbuh Kembang

1) Pertumbuhan Fisik Bayi

Pada hari ketiga pascakelahiran, berat badan bayi umumnya mengalami penurunan sekitar 5–7% dari berat lahir. Kondisi ini merupakan proses fisiologis normal, sehingga tidak perlu menimbulkan kekhawatiran apabila berat badan bayi saat dipulangkan lebih rendah dibandingkan saat lahir. Pada hari keempat, berat badan biasanya mulai

meningkat dan dalam kurun waktu 1–2 minggu dapat kembali mencapai berat lahir. Selanjutnya, bayi akan memasuki fase *growth spurt*, yaitu periode percepatan pertumbuhan yang ditandai dengan peningkatan frekuensi menyusu dan perubahan perilaku berupa rewel. Pemberian ASI sebaiknya tetap dilakukan hingga bayi merasa puas untuk memastikan kecukupan asupan nutrisi bagi proses tumbuh kembangnya

2) Pergerakan Fisik Bayi

Karena ketidakmampuan mereka melakukan gerakan motorik terarah, bayi baru lahir sepenuhnya bergantung pada ibu mereka untuk perawatan. Refleks mencari, yang ditandai dengan memutar kepala dan mencari sumber rangsangan ketika pipi atau bibir disentuh, refleks mengisap, yang terjadi ketika suatu benda dimasukkan ke dalam mulut, dan refleks menggenggam, yang terjadi ketika jari ibu diletakkan di telapak tangan, adalah beberapa contoh refleks bawaan yang menunjukkan perkembangan awal. Selain itu, tangan dan kaki bayi bergerak secara proporsional dan kuat, dengan tangan sering mencengkeram erat.

3) Kemampuan sosial dan Emosional Bayi

Bayi belum mampu menenangkan diri sendiri hingga usia 3-4 bulan. Untuk mengungkapkan keinginan atau meminta bantuan, bayi baru lahir menangis sebagai metode komunikasi nonverbal. Untuk memberikan bayi baru lahir rasa aman dan mendorong tumbuhnya rasa percaya diri pada orang lain, ibu harus bereaksi terhadap tangisan mereka secara teratur. Meskipun kemampuan visual mereka masih terbatas, bayi sudah mampu mengidentifikasi suara ibu mereka. Bayi seringkali merasa lebih rileks ketika digendong, dipeluk, atau mendengar suara ibunya saat merasa tidak nyaman. Seperti yang sering diyakini, sering digendong tidak menyebabkan "bau tangan", melainkan meningkatkan ikatan emosional antara ibu dan anak.

j. Pemeriksaan Awal Bayi Baru Lahir yang Prematur

Pada bayi prematur, diperlukan serangkaian pemeriksaan tambahan yang dilakukan secara berulang sesuai kebutuhan klinis, meliputi:

- 1) Rontgen dada untuk mengevaluasi pertumbuhan dan pematangan paru-paru.
- 2) Ultrasonografi kepala untuk mengidentifikasi potensi pendarahan otak.
- 3) Jika USG kepala menunjukkan kelainan, MRI otak akan dilakukan.
- 4) Ultrasonografi jantung untuk mendeteksi masalah pada struktur jantung.

- 5) Pemeriksaan oftalmologis untuk mengevaluasi kesehatan pembuluh darah retina, terutama pada bayi baru lahir yang telah menjalani terapi oksigen.
- 6) Sebelum bayi diperbolehkan pulang dari rumah sakit, tes pendengaran perlu dilakukan.
- 7) Penilaian berkala terhadap pertumbuhan dan perkembangan bayi hingga anak berusia dua tahun.

2. Teknik Pemeriksaan

Pemeriksaan fisik bayi baru lahir terdiri atas beberapa tahap, yaitu pemeriksaan awal, penilaian keadaan umum, pengukuran antropometri, dan pemeriksaan head to toe.

a. Pemeriksaan awal pada bayi baru lahir meliputi:

- 1) Identifikasi adanya kelainan bawaan.
- 2) Penilaian keberhasilan bayi dalam melakukan transisi dari kehidupan intrauterin ke ekstrauterin dengan bernapas menggunakan paru-paru.
- 3) Evaluasi faktor-faktor yang memengaruhi kondisi neonatus selama kehamilan maupun persalinan, termasuk penggunaan analgesik atau paparan anestesi.
- 4) Deteksi adanya tanda-tanda infeksi atau gangguan metabolik (Fatimah & Nuryaningsih, 2018)

b. Pemeriksaan keadaan umum

- 1) Menilai kesadaran bayi (aktif, menangis kuat, atau lemah).
- 2) Mengamati warna kulit (merah muda, pucat, sianosis, atau ikterik).
- 3) Menilai tonus otot (baik, lemah, atau hipotonia).
- 4) Mengevaluasi frekuensi pernapasan dan denyut jantung.

c. Pemeriksaan antropometri

- 1) Berat badan: ditimbang dengan timbangan khusus bayi.
- 2) Panjang badan: diukur dari ujung kepala hingga tumit.
- 3) Lingkar kepala: diukur melingkar melalui dahi dan bagian paling menonjol di belakang kepala.
- 4) Lingkar dada dan lingkar lengan atas: sebagai data tambahan status gizi dan pertumbuhan.

d. Pemeriksaan head to toe (dari kepala hingga kaki)

- 1) Kepala
 - bentuk kepala, ubun-ubun besar dan kecil, serta adanya caput succedaneum atau cephalhematoma, sutura dan molase

- mengukur lingkaran kepala, mulai pertengahan frontotopografi sampai tulang atas telinga atau belakang kepala sampai ke frontalis.
- 2) Mata: simetri, refleksi cahaya, dan kemungkinan kelainan bawaan.
 - Melakukan penyinaran pada pupil bayi untuk memastikan apakah mata bayi bergerak bersama atau tampak normal. Pupil biasanya mengecil saat disinari. Tanda infeksi dapat berupa nanah
 - Periksa apakah ada strabismus atau koordinasi mata buruk. Cek apakah ada tanda glaukoma kongenital.
 - 3) Hidung: kebersihan, adanya sekret, atau sumbatan.
 - Periksa kemampuan bayi untuk bernafas melalui hidung apakah ada kesulitan.
 - 4) Mulut: bibir, langit-langit, lidah, serta refleks menghisap.
 - Periksa bibir dan langit-langit apakah ada refleks hisap, serta observasi kelainan kongenital berupa labiopalatoskizis. (Maryati, Dwi, Sujianti, Tri Budiarti. 2011)
 - 5) Telinga: bentuk, letak, dan respon terhadap suara.
 - Bayangkan sebuah garis melalui kedua mata, untuk mengetahui sindrom down, beberapa bagian telinga biasanya berada di atas garis tersebut. Bayi dengan sindrom Pierre-Robin memiliki daun telinga yang letaknya rendah.
 - 6) Leher: massa, kaku, atau kelainan.
 - Periksa leher kemungkinan ada benjolan atau pembengkakan pada kelenjar tiroid dan vena jugularis.
 - Jika pergerakan leher tidak dapat bergerak bebas maka hal ini menunjukkan terdapat kelainan tulang leher berupa kelainan tiroid, angioma dan sebagainya.
 - Perhatikan refleks tonik leher: kepala terangkat saat ketiak tangan ditarik
 - 7) Dada: gerakan pernapasan, bunyi jantung, serta simetri.
 - Bentuk dada, periksa gerak kesimetrisan saat bernafas, bayi mungkin terdeteksi pneumotoraks, paresis diafragma, juga hernia diafragma jika tidak simetris.
 - Putting susu sudah simetris dan teratur pada bayi cukup bulan
 - Dengan stetoskop, terdengar suara jantung dan suara nafas
 - 8) Abdomen: bentuk perut, bunyi usus, serta kondisi tali pusat.
 - Pemeriksaan perut yang membuncit terindikasi hepatosplenomegali.
 - Periksa auskultasi untuk mengetahui apakah ada bising usus.
 - 9) Genitalia: bentuk, kelengkapan organ, serta adanya kelainan.

- Bayi laki-laki: terdapat 2 testis didalam skrotum, ujung penis berlubang, panjang penis 3-4 cm dan lebar 1,3 cm
 - Bayi perempuan: labia minora biasanya tertutup oleh labia mayora, lubang vagina dan lubang uretra terpisah.
- 10) Ekstremitas: gerakan, panjang, jumlah jari tangan dan kaki.
- 11) Kulit: warna, adanya bercak lahir, ruam, atau ikterus.
- 12) Anus: kelancaran eliminasi mekonium.
- Periksa lubang anus untuk mengidentifikasi adanya kelainan atresia ani

B. Tanda-tanda Vital Pada Bayi

1. Apgar Score

Antara menit pertama dan kelima setelah lahir, evaluasi cepat kesehatan bayi baru lahir dilakukan menggunakan Skor Apgar. Skor ini membantu mengidentifikasi apakah bayi memerlukan bantuan medis segera dan berupaya mengevaluasi kemampuan bayi untuk beradaptasi dari kehidupan di dalam rahim ke dunia luar.

Tabel 7.2: Apgar Score

Komponen	0	1	2
Appearance (warna kulit)	Seluruh tubuh pucat/kebiruan	Tubuh kemerahan, ekstremitas biru	Seluruh tubuh kemerahan
Pulse (denyut jantung)	Tidak ada	< 100 kali/menit	≥ 100 kali/menit
Grimace (respons/refleks)	Tidak ada respons	Wajah meringis / respons lemah	Menangis kuat / batuk / bersin
Activity (tonus otot)	Lemas/tidak bergerak	Fleksi ringan pada tungkai/ekstremitas	Gerakan aktif
Respiration (pernapasan)	Tidak bernapas	Pernapasan lemah / megap-megap tidak teratur	Bernapas baik / menangis kuat

Hasil nilai:

Adaptasi baik: nilai 7-10

Asfiksia ringan hingga sedang: nilai 4-6

Asfiksia berat: nilai nol hingga 3 (Saifuddin. 2006)

2. Refleks

Tabel 7.3: Refleks

Refleks	Rangsangan	Reaksi bayi	Perkembangan
Berkedip	Cahaya, tiupkan udara	Tertutupnya seluruh mata	Menetap
Babinski	Tepuk telapak kaki	Menarik kaki ke dalam dengan jari kaki yang meregang.	Menghilang setelah tiga atau empat bulan
Menggenggam	Sentuh telapak tangan	Genggam erat	Menghilang setelah tiga bulan dan hilang total setelah satu tahun
Moro/ terkejut	Bunyi yang kuat /benda terJatuh	Terkejut, punggung dilengkungkans, kepala diletakkan, lengan juga kaki dikepakkan, juga segera tertutup ke bagian tengah tubuh.	Menghilang setelah tiga atau empat bulan
Tepi saraf	Tepuk dipipi ataupun sentuh sudut mulut	Memalingkan muka, mulut terbuka ada hisapan	Hilang diatas 3 atau 4 bulan
Melangkah	Bayi diletakan di meja dengan kakinya lebih rendah ke arah bawah	Gerakan seolah-olah berjalan	Hilang diatas 3 atau 4 bulan
Hisap	Benda tersentuh mulut	Refleks hisap	Hilang diatas tiga atau empat bulan
Berenang	Wajah bayi diletakan pada air	Harmonisasi gerakan renang	Hilang diatas enam atau tujuh bulan
Tonic neck	Bayi diletakan sejajar	Terbentuk genggaman kedua tangan juga kepalake arah kanan dalam pose yang dinamakan pose berkelahi	Menghilang setelah 2 bulan

Menurut Potter dan Perry (2005) dalam (Pratiwi et al., 2023) pengukuran tanda-tanda vital dilakukan pada saat:

- Masuk ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan: Saat pasien pertama kali datang ke rumah sakit atau klinik, tanda-tanda vital akan diukur.

- b. Pemantauan Rutin: Dilakukan secara berkala di rumah sakit atau fasilitas perawatan sesuai dengan pedoman praktik institusi atau program dokter.
- c. Tes Sebelum dan Sesudah: Diperlukan sebelum dan sesudah tes diagnostik invasif, operasi bedah, atau intervensi keperawatan yang dapat memengaruhi tanda-tanda vital.
- d. Perubahan Kondisi Pasien: Ketika ada perubahan pada kondisi umum fisik klien.
- e. Pemberian Medikasi: Sebelum dan sesudah pemberian obat-obatan yang memengaruhi sistem kardiovaskular, pernapasan, atau kontrol suhu.
- f. Pelaporan Gejala: Ketika pasien melaporkan gejala seperti distress fisik yang tidak spesifik.
- g. Kondisi Gawat Darurat: Dilakukan juga di lokasi darurat medis untuk menilai kondisi secara cepat.
- h. Di Rumah: Tanda-tanda vital juga dapat dipantau di rumah untuk mendeteksi atau memantau masalah medis.

3. Suhu Tubuh

Area aksila digunakan untuk menilai suhu tubuh bayi, yang biasanya berkisar antara 36,5 dan 37,4°C. Bayi mungkin mengalami hipotermia dan membutuhkan lingkungan yang hangat jika suhu turun di bawah ambang batas ini. Karena infeksi atau pendarahan otak dapat menyebabkan ketidakstabilan suhu pada bayi, masalah ini juga perlu dievaluasi lebih lanjut. Menyelidiki faktor risiko, seperti masalah selama kehamilan, persalinan, resusitasi, pecahnya ketuban prematur, atau infeksi maternal, sangatlah penting.

4. Denyut Jantung

Stetoskop digunakan untuk mengukur detak jantung bayi. Denyut jantung normal untuk neonatus adalah antara 95 hingga 160 denyut per menit, tetapi bayi prematur memiliki detak jantung sekitar 80 denyut per menit. Adanya murmur dan keteraturan irama jantung harus diperhatikan selama pemeriksaan (Suryaningsih dkk., 2023). Nilai normal denyut nadi pada bayi berkisar 120-130 kali/menit, sedangkan pada anak berkisar 80–90 kali/menit. Denyut nadi yang melebihi batas normal disebut *takikardi*, sedangkan denyut nadi di bawah normal disebut *bradikardi* (Saifuddin. 2006))

5. Pernafasan

Pemeriksaan pernapasan pada bayi dilakukan dengan menghitung frekuensi napas (*respiration rate/RR*), yang normalnya berada pada kisaran 30–60 kali per menit. Pada pemeriksaan dapat dijumpai pola pernapasan periodik, yaitu jeda singkat selama 5–10 detik yang masih dianggap normal. Namun,

apabila terjadi henti napas (apnea) lebih dari 20 detik, diperlukan pemeriksaan lanjutan untuk memastikan diagnosis.

Tabel 7.4: Nilai Pernapasan Nomal dan Abnormal pada Bayi

Aspek	Nilai Normal	Nilai Abnormal
Frekuensi Napas (RR)	30-60 kali/menit	<30 kali/menit (bradipnea) atau >60 kali/menit (takipnea)
Pola Nafas	Pernafasan periodik dengan jelas 5-10 detik masih dianggap normal	Apnea >20 detik, napas terputus-putus tidak teratur
Usaha Nafas	Pernafasan teratur, tanpa retraksi otot	Cuping hidung atau penggunaan alat bantu
Bunyi Nafas	Tidak ada bunyi tambahan	Grunting, wheezing, atau stridor
Warna Kulit	Merah muda atau pink	Sianosis(kebiruan) atau pucat
Respons Bayi	Bayi aktif, menangis kuat	Lemas, tidak responsif, disertai henti nafas

a. Tekanan darah

Ukuran lengan bayi baru lahir harus dipertimbangkan saat menyesuaikan manset jika tekanan darah diperlukan. Anomali aorta dapat diindikasikan jika perbedaan antara tekanan diastolik dan sistolik lebih dari 10 mmHg (Suryaningsih dkk., 2023). Nilai normal tekanan darah pada bayi baru lahir adalah sistol 70–90 mmHg dan diastol sekitar 50 mmHg. Sementara itu, pada anak nilai normal tekanan darah berkisar pada sistol 80–100 mmHg dan diastol sekitar 60 mmHg (Suryaningsih dkk., 2023)

b. Pulse Oxymetri

Deteksi kelainan jantung bawaan masih menjadi perdebatan, salah satunya melalui pemeriksaan kadar saturasi oksigen (SpO₂) menggunakan *pulse oximetry*. Bayi dengan kondisi sianosis umumnya dapat dikenali secara klinis, namun pada bayi tanpa gejala, kelainan jantung bawaan dapat teridentifikasi melalui pemeriksaan saturasi oksigen. Pada hari kedua setelah kelahiran, nilai saturasi oksigen normalnya berada di atas 95% setelah diukur selama dua menit (Suryaningsih dkk., 2023)

Tabel: 7.5: Tanda-tanda Vital Bayi Baru Lahir

Parameter	Nilai Normal	Catatan Klinis
Suhu Tubuh	36,5 – 37,4 °C	<36,5 °C = hipotermia; >37,5 °C = hipertermia; ketidakstabilan suhu perlu evaluasi
Frekuensi Nafas	30 – 60 kali/menit	Apnea ≤10 detik masih normal; apnea >20 detik perlu pemeriksaan lanjut

Denyut Jantung	95 – 160 kali/menit (bayi baru lahir)	Post-date dapat ± 80 kali/menit; >160 = takikardi; <100 = bradikardi
Denyut Nadi	120 – 130 kali/menit (bayi); 80 – 90 kali/menit (anak)	Periksa irama dan ada tidaknya murmur
Tekanan Darah 36,5 – 37,4 °C	Bayi: sistol 70–90 mmHg, diastol ± 50 mmHg	Jika selisih sistol-diastol >10 mmHg : curiga kelainan aorta
	Anak: sistol 80–100 mmHg, diastol ± 60 mmHg	Gunakan manset sesuai ukuran lengan

C. Pemeriksaan Fisik dan Antropometri pada Bayi dan Anak

Disiplin pengukuran ukuran tubuh untuk mengevaluasi pertumbuhan dan kesehatan gizi dikenal sebagai antropometri. Pengukuran ini biasanya terdiri dari lingkaran kepala, berat badan, dan tinggi badan atau panjang badan. Kesehatan umum anak, identifikasi dini kelainan pertumbuhan termasuk stunting dan masalah gizi lainnya, serta pemantauan perkembangan anak, semuanya bergantung pada pemeriksaan antropometri rutin.

Berat badan dan panjang badan adalah dua karakteristik antropometri utama dalam evaluasi anak, dan keduanya dibagi lagi menjadi empat indeks utama:

1. Berat Badan (BB) menurut umur (BB/U)

Berat badan anak ditentukan dengan mempertimbangkan sejumlah faktor, termasuk:

- a. Timbangan yang telah dikalibrasi secara rutin (terstandarisasi/terkalibrasi) digunakan untuk mengumpulkan hasil pengukuran. Timbangan kaki atau timbangan dacin dapat digunakan.
- b. Timbangan bayi digunakan untuk menimbang bayi saat mereka berbaring. Dacin digunakan untuk mengukur berat badan saat anak berusia 12 tahun duduk. Pengukuran dapat dilakukan sambil berdiri untuk anak-anak di atas usia dua tahun.
- c. Cara pengukuran berat badan anak (menggunakan timbangan injak) yaitu:
 - Lepaskan alas kaki pada anak,
 - Posisikan anak berdiri dengan tenang di atas timbangan
 - Pastikan anak tidak memakai pakaian tebal
 - Pastikan anak tidak membawa benda apa pun atau berpegangan pada alat maupun orang lain.
 - Tunggu hingga jarum timbangan berhenti bergerak atau hingga layar digital menunjukkan angka yang stabil.
 - Bacalah hasil pengukuran dengan cermat, kemudian catat hasil tersebut pada lembar pencatatan.

Rasio berat badan terhadap usia anak dikenal sebagai indeks berat badan terhadap usia (BB/U). Meskipun tidak dapat digunakan untuk mendiagnosis obesitas atau obesitas berat, indeks ini bermanfaat dalam mengevaluasi kondisi gizi anak-anak yang tergolong kurang berat badan atau sangat kurang berat badan. Penting untuk diketahui bahwa anak-anak dengan BB/U rendah rentan terhadap kelainan pertumbuhan, sehingga sebelum memulai intervensi, validasi menggunakan indeks BB/PB, BB/H, atau BMI/U diperlukan.

Timbangan khusus pediatrik digunakan untuk menilai berat badan bayi dengan presisi tinggi. Rumus berikut dapat digunakan untuk menentukan berat badan ideal:

- **Untuk bayi usia 1–6 bulan:** berat badan saat lahir (gram) + (usia × 600 gram)
- **Untuk bayi usia 7–12 bulan:** (usia ÷ 2) + 3 (hasil dalam kilogram)

Indeks berat badan menurut umur (BB/U) anak usia 0-60 bulan digunakan untuk menentukan kategori:

- Berat badan sangat kurang (*severy underweight*)
- Berat badan kurang (*underweight*)
- Berat badan normal
- Risiko berat badan lebih (*obese*)



Gambar 7.1: Penimbangan BBL

2. Panjang Badan/Tinggi Badan menurut umur (PB/U atau TB/U).

An indicator that characterizes a child's development in height or length according to their age is the Height/Age (PB/U) or Height/Age (HB/U) index. Children who are stunted or severely stunted are identified using this index; these conditions are often brought on by chronic malnutrition or recurrent sickness. Additionally, while this problem is uncommon in Indonesia and is often linked to endocrine abnormalities, this score may also detect children who are very tall.

Pengukuran panjang badan digunakan untuk menilai pertumbuhan anak berusia di bawah satu tahun, sedangkan tinggi badan diukur pada anak usia di atas satu tahun. Proses pertumbuhan ini telah dimulai sejak masa kehamilan dan berlangsung hingga anak berusia dua tahun.

Indeks Panjang Badan/Tinggi Badan menurut umur (PB/U atau TB/U) anak usia 0-60mbulan digunakan untuk menentukan kategori:

- ✓ Sangat pendek (*severy stunted*)
- ✓ Pendek (*stunted*)
- ✓ Normal
- ✓ Tinggi

Pengukuran panjang badan bayi dapat menggunakan alat ukur yang disebut *Infantometer Board* atau *Length Board*. Penggunaan *Infantometer Board* atau *Length Board* sangat mudah digunakan dengan cara sebagai berikut:

- a. Letakan *Infantometer* pada bidang yang datar
- b. Setelah itu, letakkan bayi secara hati-hari dengan kepala menempel ke bagian papan "*head*" infantometer
- c. Pastikan posisi tubuh bayi terlentang, kemudian bagian lutut secara perlahan agar posisi kaki dalam keadaan lurus
- d. Gerakan atau geser papan '*feed*' hingga menyentuh ujung kaki bayi yang diukur
- e. Hasil pengukuran panjang bayi dapat dilihat dengan jelas pada skala penandaannya

Dibandingkan dengan alat pengukur panjang badan yang terbuat dari aluminium biasa dengan mekanisme manual, infantometer memiliki keunggulan yaitu lebih akurat.



Gambar 7.2: pengukuran TB/PB Bayi

3. Berat Badan menurut Panjang/Tinggi Badan (BB/PB) atau BB/TB.

Berat badan anak dalam kaitannya dengan perkembangan tinggi badan atau panjang badannya ditunjukkan oleh indeks BB/PB atau BB/T. Anak-anak

yang kekurangan gizi (*wasted*), sangat kekurangan gizi (*severely wasted*), dan berisiko kelebihan berat badan diidentifikasi oleh skor ini. Penyakit dan asupan makanan yang tidak memadai, baik akut maupun kronis, merupakan penyebab utama malnutrisi.

Kelompok-kelompok berikut dapat dibentuk menggunakan indeks BB/T, yang menghitung tinggi dan panjang badan anak usia 0–60 bulan:

- ✓ Gizi buruk (*severy wasted*)
- ✓ Gizi kurang (*wasted*)
- ✓ Gizi baik (normal)
- ✓ Berisiko gizi lebih (*possible risk of everweight*)
- ✓ Gizi lebih (*overweight*)
- ✓ Obesitas (*obese*)

4. Indeks Massa Tubuh menurut Umur (IMT/U)

Gizi kurang, gizi lebih, obesitas, berisiko gizi lebih, dan malnutrisi semuanya diklasifikasikan menggunakan indeks BMI/Usia. Hasil grafik berat badan/tinggi badan atau BMI/Usia seringkali sebanding. Namun, dalam hal memeriksa obesitas dan malnutrisi pada anak, indeks BMI/Usia lebih sensitif. Seorang anak berisiko gizi lebih dan membutuhkan terapi lebih lanjut untuk menghindari obesitas dan gizi lebih jika ambang batas BMI/Usia mereka lebih dari 1 SD.

Anak-anak berusia antara 0 dan 60 bulan dapat dibagi ke dalam kelompok-kelompok berikut menggunakan indeks massa tubuh terhadap usia (BMI/Usia):

- ✓ Gizi buruk (*severy wasted*)
- ✓ Gizi kurang (*wasted*)
- ✓ Gizi baik (normal)
- ✓ Berisiko gizi lebih (*possible risk of everweight*)
- ✓ Gizi lebih (*overweight*)
- ✓ Obesitas (*obese*)

5. Lingkar Kepala (LK) untuk mengukur lingkar kepala, terutama penting pada bayi baru lahir dan anak dibawah 2 tahun.

Selain pengukuran panjang dan berat badan, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan bayi juga memerlukan pengukuran lingkar kepala. Hal ini penting karena kondisi kekurangan protein, asupan ASI yang tidak memadai, maupun malnutrisi kronis dapat tercermin dari ukuran kepala bayi.

Metode pengukurannya cukup sederhana, yaitu menggunakan pita ukur yang lentur namun tidak elastis, sehingga hasil yang diperoleh lebih akurat.

Pengukuran lingkaran kepala sebaiknya dilakukan secara rutin dan berkala sebagai bagian dari pemantauan pertumbuhan serta perkembangan anak.



Gambar 7.3: Pengukuran Lingkaran Kepala Bayi

D. Latihan

Soal Pilihan Ganda

Kerjakan latihan soal dibawah ini dengan memilih salah satu jawaban yang paling benar!

1. Seorang bayi perempuan lahir spontan 1 jam yang lalu di RS kasih Ibu, ditolong oleh bidan, bayi bergerak aktif, menangis kuat, tampak kulit kemerahan, setelah dilakukan IMD selama 1 jam, BBL akan dilakukan pemeriksaan antropometri, alat apakah yang digunakan untuk mengukur panjang/tinggi badan BBL tersebut?
 - A. Timbangan Bayi
 - B. Infantometer
 - C. Metline
 - D. Pita LILA
 - E. Pita Lingkaran Kepala
2. Seorang bayi perempuan lahir spontan 1 jam yang lalu di RS kasih Ibu, ditolong oleh bidan, bayi bergerak aktif, menangis kuat, tampak kulit kemerahan, setelah dilakukan IMD selama 1 jam, BBL akan dilakukan pemeriksaan antropometri, alat apakah yang digunakan untuk mengukur berat badan BBL tersebut?
 - A. Timbangan Bayi
 - B. Infantometer
 - C. Metline
 - D. Pita LILA
 - E. Pita Lingkaran Kepala
3. Berapakah nilai normal suhu tubuh pada bayi?
 - A. 36,5 – 37,4 °C

- B. 36,5 – 37,6 °C
 - C. 35,5 – 36,4 °C
 - D. 35,5 – 37,4 °C
 - E. 36,5 – 37,5 °C
4. Berapakah nilai normal denyut nadi pada bayi?
- A. 110 – 120 kali/menit
 - B. 120 – 130 kali/menit
 - C. 110 – 130 kali/menit
 - D. 125 – 130 kali/menit
 - E. 100 – 130 kali/menit
5. Berapakah nilai sistol normal tekanan darah pada bayi?
- A. 70–80 mmHg
 - B. 70–90 mmHg
 - C. 70–100 mmHg
 - D. 70–120 mmHg
 - E. 70–130 mmHg

Soal Essay

Jawablah soal dibawah ini dengan benar!

1. Sebutkan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan fisik bayi baru lahir?
2. Apa saja tujuan penting dilakukan pemeriksaan fisik pada bayi?
3. Apa saja pemeriksaan tambahan yang diperlukan pada bayi prematur?
4. Apa saja yang termasuk pemeriksaan keadaan umum pada bayi?
5. Berapa nilai frekuensi pernapasan normal pada bayi?

Kunci Jawaban

1. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan fisik bayi baru lahir adalah sebagai berikut:
 - a. Kondisi bayi saat pemeriksaan
 - b. Prioritas pemeriksaan
 - c. Lingkungan pemeriksaan
 - d. Lingkungan pemeriksa
 - e. Pendekatan terhadap bayi
 - f. Partisipasi orang tua
2. Tujuan penting pemeriksaan fisik bayi antara lain sebagai berikut:
 - a. Menilai kondisi bayi
 - b. Deteksi kondisi Bayi baru lahir

- c. Memberikan dasar asuhan
- d. Memantau tumbuh kembang
- 3. Pemeriksaan tambahan yang diperlukan pada bayi prematur adalah sebagai berikut:
 - a. Rontgen dada untuk menilai perkembangan paru-paru
 - b. USG kepala untuk mendeteksi kemungkinan perdarahan otak
 - c. MRI otak, jika ditemukan kelainan berdasarkan hasil USG kepala
 - d. USG jantung untuk mendeteksi masalah struktural pada jantung
 - e. Pemeriksaan mata, terutama bagi bayi yang pernah menerima terapi oksigen untuk menilai kondisi pembuluh darah retina
 - f. Evaluasi tumbuh kembang secara berkala hingga bayi berusia 2 tahun
- 4. Yang termasuk pemeriksaan keadaan umum pada bayi adalah
 - a. Menilai kesadaran bayi (aktif, menangis kuat, atau lemah).
 - b. Mengamati warna kulit (merah muda, pucat, sianosis, atau ikterik).
 - c. Menilai tonus otot (baik, lemah, atau hipotonia).
 - d. Mengevaluasi frekuensi pernapasan dan denyut jantung.
- 5. Frekuensi pernapasan normal pada bayi adalah 30-60 kali/menit

E. Rangkuman Materi

Langkah awal yang penting dalam menjamin kesehatan dan kesejahteraan bayi adalah pemeriksaan bayi baru lahir. Prosedur ini melibatkan sejumlah tes untuk menentukan seberapa baik bayi telah menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar rahim, mengidentifikasi kemungkinan cacat bawaan, dan menjadi dasar untuk perencanaan perawatan di masa mendatang. Skor Apgar, yang mengevaluasi lima faktor penting detak jantung, pernapasan, warna kulit, tonus otot, dan respons refleks digunakan untuk memulai pemeriksaan fisik. Segera setelah bayi lahir, skor Apgar memberikan ringkasan singkat tentang kesehatan mereka. Setelah itu, indikator vital termasuk suhu tubuh, detak jantung, dan laju pernapasan diukur untuk memastikan proses fundamental tubuh berjalan sebagaimana mestinya.

Pemeriksaan fisik yang lebih menyeluruh dilakukan, termasuk anggota badan, alat kelamin, dada, perut, kepala, dan leher. Untuk menemukan anomali atau tanda-tanda masalah kesehatan, setiap bagian tubuh diperiksa dengan saksama. Selain itu, mengevaluasi kesehatan otak bayi memerlukan pemeriksaan refleks dasar. Penilaian harus mencakup pengukuran antropometri, seperti berat badan, panjang badan, dan lingkar kepala dalam kaitannya dengan kriteria pertumbuhan. Hal ini membantu mengidentifikasi masalah perkembangan atau gizi sejak dini yang memerlukan perawatan lebih lanjut. Pengukuran antropometri dilakukan

secara berkala seiring perkembangan anak untuk memantau perkembangannya. Pengukuran seperti tinggi badan, berat badan, dan indeks massa tubuh (IMT) digunakan untuk menentukan kemungkinan kelainan pertumbuhan dan mengevaluasi status gizi. Dengan mempertimbangkan semua hal, pemeriksaan fisik bayi baru lahir dan pelacakan perkembangan antropometri sangat penting untuk mengidentifikasi masalah kesehatan sejak dini dan memungkinkan penanganan yang cepat dan tepat.

F. Glosarium

Antropometri: Ilmu pengukuran dimensi tubuh manusia (berat badan, tinggi/panjang badan, lingkar kepala) untuk menilai pertumbuhan dan status gizi.

Intervensi: Tindakan atau upaya yang dilakukan untuk mencegah, mengatasi, atau memperbaiki masalah kesehatan.

Adaptasi fisiologis: Penyesuaian fungsi tubuh terhadap kondisi baru, misalnya bayi menyesuaikan diri setelah lahir.

Aorta: Pembuluh darah arteri terbesar yang membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh.

Apgar: Skor penilaian kondisi bayi baru lahir berdasarkan 5 parameter: denyut jantung, pernapasan, warna kulit, tonus otot, dan refleks.

Auskultasi: Pemeriksaan dengan mendengarkan bunyi tubuh, biasanya menggunakan stetoskop.

Bonding: Ikatan emosional yang terbentuk antara bayi dan orang tua, terutama ibu.

Bradikardi: Denyut jantung lebih lambat dari normal.

Diastol: Tekanan darah saat jantung relaksasi (darah masuk ke jantung).

Echocardiography (Ekokardiografi): Pemeriksaan jantung dengan gelombang ultrasonik (USG jantung) untuk melihat struktur dan fungsi jantung.

Evidence-based: Pendekatan yang didasarkan pada bukti ilmiah terbaru dan terpercaya.

Growth spurt: Masa percepatan pertumbuhan yang berlangsung cepat dalam waktu singkat.

Head to toe: Metode pemeriksaan fisik dari kepala hingga kaki secara sistematis.

Hipersalivasi: Produksi air liur yang berlebihan.

Inspeksi: Pemeriksaan dengan cara melihat atau mengamati.

Megap-megap: Kondisi bayi kesulitan bernapas, ditandai dengan mulut membuka berulang seperti "megap".

Mekonium: Feses pertama bayi, berwarna hijau kehitaman, lengket, dan pekat.

Neonatus: Bayi baru lahir hingga usia 28 hari.

Neurologis: Segala sesuatu yang berkaitan dengan sistem saraf.

Nonverbal: Komunikasi tanpa kata-kata, misalnya melalui ekspresi wajah, gerakan, atau sentuhan.

Oksigen: Gas yang dibutuhkan tubuh untuk proses pernapasan dan metabolisme.

Palpasi: Pemeriksaan dengan cara meraba menggunakan tangan.

Perkusi: Pemeriksaan dengan mengetuk bagian tubuh untuk menilai kondisi organ di bawahnya.

Presentasi: Bagian tubuh janin yang pertama kali memasuki jalan lahir (misalnya kepala, bokong/sungsang).

Pulse oximetry (Pulse oksimetri): Alat non-invasif untuk mengukur kadar saturasi oksigen dalam darah menggunakan sensor di jari, kaki, atau telinga.

Refleks: Respon otomatis tubuh terhadap rangsangan, tanpa melalui kesadaran.

Resusitasi: Upaya pertolongan untuk mengembalikan fungsi pernapasan dan sirkulasi, misalnya resusitasi jantung paru.

Rooting: Refleks bayi saat pipinya disentuh, ia akan menoleh dan mencari puting untuk menyusu.

Saturasi oksigen: Persentase oksigen yang terikat dalam hemoglobin darah, menunjukkan kecukupan oksigen dalam tubuh.

Sistol: Tekanan darah saat jantung berkontraksi (memompa darah keluar).

Skrining: Pemeriksaan awal untuk mendeteksi kemungkinan adanya penyakit atau kelainan.

Stetoskop: Alat medis untuk mendengarkan bunyi tubuh, seperti detak jantung atau pernapasan.

Takikardi: Denyut jantung lebih cepat dari normal.

Tiroid: Kelenjar di leher yang berfungsi mengatur metabolisme tubuh melalui produksi hormon.

Tonus otot: Tingkat ketegangan atau kekencangan otot dalam keadaan istirahat.

Transisi: Masa peralihan, misalnya bayi beradaptasi dari kehidupan intrauterin ke ekstrauterin.

USG (Ultrasonografi): Pemeriksaan menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi untuk menampilkan gambar organ dalam tubuh.

G. Referensi

- Budiarti, D, M. (2011). Buku Ajar Neonatus Bayi & balita (-). Jakarta: Trans Info Media.
- Gustina, Irwanti. 2022. Modul Ajar Praktikum Asuhan Kebidanan Bayi, Balita & Anak Prasekolah. Jakarta: Universitas Binawan
- Marbun, Sahyuni Sari. 2017. Pengkajian Fisik Bayi Baru Lahir, Penampilan Dan Perilaku Bayi Baru Lahir Serta Rencana Asuhan Bayi 2-6 Hari Medan: Institut Kesehatan Helvetia
- Maryati, D., Sujianti, & Budiarti, T. (2011). *Buku Ajar Neonatus Bayi & Balita*. Jakarta: Trans Info Media
- Pratiwi, N., Erismawati, E., Warikar, A. A., & Lestari, D. P. (2023). Pengaruh Media Video Terhadap Keterampilan Pemeriksaan Tanda-Tanda Vital (TTV) pada Mahasiswa Keperawatan Prodi D-III Keperawatan Manokwari. *Malahayati Nursing Journal*, 5(11), 3869–3882. <https://doi.org/10.33024/mnj.v5i11.11784>
- Saifuddin. 2006. Buku Panduan Praktis Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal. Jakarta: YBPSP
- Saputra, Lyndon. 2014. Catatan Ringkas Asuhan Neonatus, Bayi, Dan Balita. Tangerang Selatan: Bina Rupa Aksara Publisher
- Solehah, Imroatul et al. 2021. "Asuhan Segera Bayi Baru Lahir." Fakultas Kesehatan Diploma III Kebidanan Universitas Nurul Jadid 5(3): 78.
- Suryaningsih, SSiT., M.Keb., dkk. (2023). Buku Ajar Bayi Baru Lahir DIII Kebidanan Jilid I. Jakarta Selatan: Mahakarya Citra Utama.
- Wahyuni, Sari. 2012. Asuhan Neonatus, Bayi Dan Balita Penuntun Belajar Praktik Klinik. Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran EGC

CEKLIST PEMERIKSAAN FISIK PADA BAYI BARU LAHIR**Petunjuk Penilaian**

Beri nilai untuk setiap langkah klinik dengan menggunakan kriteria sebagai berikut :

0 = Tidak dikerjakan

1 = Mampu (Kegiatan dilakukan dengan benar dan sesuai urutan, tetapi kurang tepat)

2 = Mahir (Kegiatan dilakukan dengan benar, tepat dan tanpa ragu, berurutan sesuai prosedur)

No	Kegiatan	0	1	2
A.	Persiapan Alat ▪ Meja pemeriksaan dan alasnya ▪ Celemek ▪ <i>Handscoon</i> ▪ Kassa steril ▪ Senter/Pen light ▪ Thermometer anal ▪ Gelas kecil berisi air klorin ▪ Stetoskop ▪ Selimut Bayi ▪ Bengkok ▪ Timbangan Bayi ▪ Pita Ukur/Metlin ▪ Pengukur panjang badan ▪ Lampu sorot ▪ Baju Bersih bayi 1 set ▪ Kapas DTT dalam kom tertutup ▪ Tiga Kom berisi: Klorin 0,5%, air sabun, air detergen ▪ Nierbeken ▪ Alat tulis gelang identitas			
B	Content			
1	Menjelaskan ke Ibu atau keluarga maksud dan tujuan dilakukan pemeriksaan.			
2	Melakukan anamnesa riwayat dari ibu meliputi faktir genetik, faktor lingkungan, sosial, faktor ibu dan neonatal			
3	Menyusun alat secara ergonomis untuk memudahkan dalam melakukan tindakan			
4	Mencuci tangan menggunakan sabun dibawah air mengalir, kemudian dikeringkan dengan handuk bersih.			
5	Menjaga suhu bayi dan lingkuang dalam keadaan hangat.			

6	Meletakkan bayi pada tempat yang rata/tempat tidur (upayakan tempat untuk pemeriksaan aman untuk menghindari bayi terjatuh)			
7	Memeriksa muka dan kulit Muka: apakah ada kelainan seperti Sindrom Down Kulit: Apakah berwarna pucat, kuning biru, perdarahan atau edema?			
8	Melakukan penimbangan dengan cara meletakkan kain atau kertas pelindung dan atur skala timbangan dikurangi dengan berat alas dan pembungkus bayi			
9	Melakukan pengukuran panjang badan. Meletakkan bayi ditempat yang datar kemudian mengukur panjang badan bayi menggunakan alat pengukur panjang badan dari kepala sampai tumit dengan kaki/badan diluruskan.			
10	Kepada b. Apakah terdapat caput succedaneum, cepalhematom, moulase, UUB cekung, hydrocephale dan anencephalus? c. Mengukur lingkar kepala Sirkumferensia fronto-okspitalis 34 cm Sirkumferensia mento-okspitalis 35 cm Sirkumferensia suboksipito-bregmantika 32 cm			
11	Muka Apakah ada paralisis, jarak antara hidung dan mulut, pembesaran mandibula?			
12	Telinga Pemeriksaan hubungan antara kantung mata dan telinga (jarak normal kedua mata 3 cm) adakah pengeluaran sekret?			
13	Mata Adakah perdarahan subkonjungtuva, konjungtivitis, katarak, strabismus, jarak antara kedua mata?			
14	Hidung Periksa apakah ada atresia, gerakan cuping hidung, pengeluaran sekret (purulen atau berdarah)			
15	Mulut Periksa apakah ada labioschizis, palatoschizis, atau labiopalatoschizis?			
16	Leher			

	Amati apakah ada pembengkakan atau pembesaran kelenjar thyroid atau vena jugularis?			
17	Dada Mengukur lingkar dada dari daerah punggung lalu kembali ke dada (pengukuran dilakukan melalui kedua puting susu) Lingkar Normal: 30-38 cm Denyut jantung normal: 120-160x/menit Amati pernapasan, pernapasan bayi diafragmatik dan abdominal, tidak ada retraksi dada pada saat bernafas. Pernapasan normal: 30-60x/menit			
18	Mengukur suhu tubuh melalui axila. Suhu tubuh normal 36,5°C-37,5°C			
19	Abdomen Bagaimana bentuk perut bayi (sifoid/bentuk cekung seperti perahu), adakah penonjolan, omphalokel, gastroschisis, perdarahan pada tali pusat, warna tali pusat?			
20	Genitalia Perempuan: apakah labia majora sudah menutupi labia minora, uretra dan vagina berlubang, secret vagina? Laki-laki: apakah testis sudah turun ke dalam skrotum, lubang penis, letak lubang penis?			
21	Anus Memeriksa apakah anus berlubang atau tidak (atresia ani)			
22	Ekstremitas Amati pergerakan bayi, apakah terdapat trauma pada daerah tersebut, adakah kelebihan jari atau polidaktili, adakah sidaktili (jari berselaput)			
23	Punggung Meletakkan bayi dengan posisi tengkurap kemudian raba sepanjang tulang belakang, adakah spina bifida, meningocele atau myelomeningocele?			
24	Memeriksa refleks Refleks moro Refleks Rooting (mencari) Refleks sucking (menghisap) Refleks (menelan) Refleks Blinking (kedip)			

	Refleks Graps (menggenggam) Refleks Tonic Neck Refleks Walking dan Stepping (berjalan dan melangkah) Refleks Babinski			
25	Merapikan Bayi			
26	Menjelaskan pada orang tua tentang hasil pemeriksaan			
27	Membereskan alat-alat			
28	Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir kemudian mengeringkan dengan handuk bersih			
29	Melakukan pendokumentasian tindakan yang telah dilakukan			
	Skor Total: <u>Nilai total skor</u> 58			

PROFIL PENULIS



Wahyu Utami Ekasari, S.ST., MPH Lahir di Blora, 19 Desember 1987. Pendidikan tinggi yang ditempuh penulis yaitu jenjang DIII Kebidanan di Akademi Kebidanan An – Nur Purwodadi lulus tahun 2009, dilanjutkan DIV Bidan Pendidik di Poltekkes Kemenkes Semarang lulus tahun 2011, kemudian S2 Kesehatan Masyarakat dengan peminatan Kesehatan Ibu dan Anak di Universitas Sebelas Maret Surakarta lulus tahun 2015. Riwayat pekerjaan penulis diawali pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2019 di Akademi Kebidanan An – Nur, dan pada tahun 2019 – saat ini sedang berkerja di Program Studi Kebidanan Program Sarjana Universitas An Nuur dan mengampu mata kuliah Pengantar Praktik Kebidanan; Pemeriksaan Fisik Ibu dan Bayi; Psikologi Kehamilan, Persalinan, Nifas, dan Bayi Baru Lahir; KB dan Pelayanan Kontrasepsi; Gizi dalam kebidanan; Asuhan pada Bayi, Balita, dan Anak Prasekolah, Komplikasi dalam Kehamilan, Persalinan, Nifas, dan Bayi Baru Lahir; Pelayanan Kebidanan Komunitas; serta Kewirausahaan. Penulis aktif sebagai pengajar, anggota dalam organisasi profesi bidan, penulis buku dan artikel jurnal terakreditasi nasional. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: wahyuutamie@unan.ac.id

Pratiwi Lumbantobing, SST., M.KM. Lahir di Tarutung, 22 Juni 1985. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Bidan Pendidik, Universitas Sumatera Utara Tahun 2008. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Sumatera Utara dan lulus Tahun 2016. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2021 di Program Studi Sarjana Kebidanan STIKes Senior Medan. Saat ini penulis bekerja di Universitas Senior Medan mengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan Pada Bayi, Balita dan Anak Pra Sekolah, Asuhan Kebidanan pada Remaja dan Perimenopause, Pelayanan Kebidanan dalam Sistem Pelayanan Kesehatan Masyarakat, Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal, Praktik Profesionalisme Kebidanan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: pratiwiumbantobing2201@gmail.com

Motto: "Success is the ability to go through and overcome from one failure to the next without losing enthusiasm"

PROFIL PENULIS



Anggita Septyani Permatasari, S.Tr.Keb.,M.Tr.Keb, Lahir di Grobogan 1 September 1994, Pendidikan tinggi yang telah di tempuh oleh penulis yaitu jenjang D4 Kebidanan pada Program Studi Kebidanan Pendidik Universitas Kadirilulus tahun 2016, melanjutkan jenjang S2 Terapan Kebidanan pada Prodi Magister Terapan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Semarang lulus tahun 2020. Saat ini penulis bekerja di Universitas An Nuur mengampu mata kuliah pengantar praktik kebidanan, pemeriksaan fisik ibu dan bayi, fisiologi pada kehamilan, persalinan, nifas dan BBL, pengantar holistic care, dan asuhan kebidanan pada persalinan dan BBL. Penulis dapat dihubungi melalui alamat email Anggitas866@gmail.com



Pratiwi Lumbantobing, SST., M.KM. Lahir di Tarutung, 22 Juni 1985. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Bidan Pendidik, Universitas Sumatera Utara Tahun 2008. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Sumatera Utara dan lulus Tahun 2016. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2021 di Program Studi Sarjana Kebidanan STIKes Senior Medan. Saat ini penulis bekerja di Universitas Senior Medan mengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan Pada Bayi, Balita dan Anak Pra Sekolah, Asuhan Kebidanan pada Remaja dan Perimenopause, Pelayanan Kebidanan dalam Sistem Pelayanan Kesehatan Masyarakat, Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal, Praktik Profesionalisme Kebidanan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: pratiwilumbantobing2201@gmail.com
Motto: "Success is the ability to go through and overcome from one failure to the next without losing enthusiasm"

PROFIL PENULIS



Dewi Sapta Wati, S.Tr.Keb., M.Kes Lahir di Grobogan 18 Mei 1991. Dengan Latar Pendidikan Diploma III Kebidanan Di STIKES Ngudi Waluyo, Penulis Melanjutkan Ke Diploma IV STIKES Ngudi Waluyo, Dan Melanjutkan Ke Universitas Negeri Semarang Sehingga Meraih Gelar Magister Kesehatan Masyarakat. Saat Ini Aktif Menjadi Dosen Kebidanan di Universitas An Nuur . Adapun kegiatan maupun pelatihan yang pernah di ikuti adalah Baby Massage (2023)



Sri Untari., S.SiT., M.Kes lahir di Grobogan, 18 Agustus 1979, memiliki riwayat pendidikan D3 Kebidanan di Panti Wilasa Semarang lulus tahun 2001, DIV Bidan Pendidik di Stikes Ngudi Waluyo Ungaran lulus tahun 2006, S2 Pendidikan Profesi Kesehatan di UNS Surakarta lulus tahun 2012, saat ini penulis sebagai dosen tetap prodi D-III Kebidanan Fakultas Sains dan Kesehatan Universitas An Nuur Purwodadi, aktif dalam kegiatan Tridharma, penulis sebagai salah satu pengajar prodi D-III Kebidanan, penulis juga aktif dalam kegiatan penelitian dan pengabdian. Sebagai seorang penulis menyadari masih banyak kekurangan dari hasil karya yg penulis hasilkan maka dari itu kritik dan saran yg membangun sangat penulis harapkan. Besar harapan penulis untuk selalu mendedikasikan ilmu yg bermanfaat untuk kemajuan Ilmu Kebidanan. Penulis dapat dihubungi dengan email: untariharsono@gmail.com

Sinopsis

Buku Ajar Pemeriksaan Fisik Ibu dan Bayi menyajikan panduan komprehensif dan terstruktur untuk memperkuat kompetensi pengkajian klinik pada masa kehamilan, persalinan, nifas, serta periode bayi baru lahir dan anak. Bab 1 membahas konsep anamnesis, pengkajian riwayat kesehatan dan obstetri, serta keterampilan komunikasi yang efektif sebagai fondasi hubungan terapeutik antara bidan, ibu, dan keluarga. Bab 2 memandu pemeriksaan tanda vital ibu dan bayi melalui pengenalan peralatan, langkah pemeriksaan yang sistematis, perlengkapan pemeriksaan, faktor yang memengaruhi hasil, serta peran bidan, dilengkapi pengenalan alat ukur gula darah dan infus set untuk menunjang keputusan klinik yang tepat.

Bab 3 mengintegrasikan pemeriksaan umum pada ibu dan bayi, pemantauan tanda vital, pemeriksaan neurologi, dan pemeriksaan penunjang sehingga pembaca menguasai alur pengkajian yang menyeluruh dan konsisten. Bab 4 mendalami pemeriksaan abdomen pada kehamilan dan persalinan, dimulai dari prinsip dasar pemeriksaan fisik, anamnesis, teknik pemeriksaan, dan pendekatan per sistem hingga penerapannya pada ibu hamil, ibu bersalin, dan saat nifas. Penyajian materi menekankan ketelitian klinik, keselamatan pasien, dan penalaran yang kuat agar hasil pemeriksaan berujung pada keputusan asuhan kebidanan yang akurat.

Bab 6 mengulas pemeriksaan dasar pada kehamilan, persalinan, dan nifas, termasuk optimalisasi posisi janin, pemeriksaan dalam dan penggunaan spekulum, serta perbaikan perineum sebagai keterampilan penting di layanan primer. Bab 7 memfokuskan pemeriksaan bayi baru lahir, bayi, dan anak, mencakup pemeriksaan fisik menyeluruh, tanda vital, dan antropometri untuk pemantauan tumbuh kembang secara dini. Setiap bab dilengkapi latihan atau soal, rangkuman materi, glosarium, dan daftar pustaka guna mendukung pembelajaran aktif dan persiapan uji kompetensi, sementara profil penulis pada bagian akhir memberikan gambaran keahlian tim penyusun. Buku ini dirancang sebagai rujukan terpercaya bagi pendidik, mahasiswa, dan praktisi kebidanan dalam mewujudkan pelayanan yang aman, efektif, dan berpusat pada keluarga.

Buku Ajar Pemeriksaan Fisik Ibu dan Bayi menyajikan panduan komprehensif dan terstruktur untuk memperkuat kompetensi pengkajian klinik pada masa kehamilan, persalinan, nifas, serta periode bayi baru lahir dan anak. Bab 1 membahas konsep anamnesis, pengkajian riwayat

kesehatan dan obstetri, serta keterampilan komunikasi yang efektif sebagai fondasi hubungan terapeutik antara bidan, ibu, dan keluarga. Bab 2 memandu pemeriksaan tanda vital ibu dan bayi melalui pengenalan peralatan, langkah pemeriksaan yang sistematis, perlengkapan pemeriksaan, faktor yang memengaruhi hasil, serta peran bidan, dilengkapi pengenalan alat ukur gula darah dan infus set untuk menunjang keputusan klinik yang tepat. Bab 3 mengintegrasikan pemeriksaan umum pada ibu dan bayi, pemantauan tanda vital, pemeriksaan neurologi, dan pemeriksaan penunjang sehingga pembaca menguasai alur pengkajian yang menyeluruh dan konsisten. Bab 4 mendalami pemeriksaan abdomen pada kehamilan dan persalinan, dimulai dari prinsip dasar pemeriksaan fisik, anamnesis, teknik pemeriksaan, dan pendekatan per sistem hingga penerapannya pada ibu hamil, ibu bersalin, dan saat nifas. Penyajian materi menekankan ketelitian klinik, keselamatan pasien, dan penalaran yang kuat agar hasil pemeriksaan berujung pada keputusan asuhan kebidanan yang akurat.

Bab 6 mengulas pemeriksaan dasar pada kehamilan, persalinan, dan nifas, termasuk optimalisasi posisi janin, pemeriksaan dalam dan penggunaan spekulum, serta perbaikan perineum sebagai keterampilan penting di layanan primer. Bab 7 memfokuskan pemeriksaan bayi baru lahir, bayi, dan anak, mencakup pemeriksaan fisik menyeluruh, tanda vital, dan antropometri untuk

pemantauan tumbuh kembang secara dini. Setiap bab dilengkapi latihan atau soal, rangkuman materi, glosarium, dan daftar pustaka guna mendukung pembelajaran aktif dan persiapan uji kompetensi, sementara profil penulis pada bagian akhir memberikan gambaran keahlian tim penyusun. Buku ini dirancang sebagai rujukan terpercaya bagi pendidik, mahasiswa, dan praktisi kebidanan dalam mewujudkan pelayanan yang aman, efektif, dan berpusat pada keluarga.

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

ISBN 978-634-7426-25-3



9

786347

426253

